

Онкология и радиология Казахстана

№1 (18) 2011

Қазақстан онкология және радиология журналы

Главный редактор
Ж.А. Арзыкулов,
профессор

Редакционная коллегия
Абисатов Х.А., Адильбаев Г.Б., Баишева С.А., Жолдыбай Ж.Ж., Ижанов Е.Б.,
Имангалиева Н.Т. (патентовед), Кайрбаев М.Р. (административный редактор),
Ким В.Б., Монахов Б.В., Нургалиев Н.С., Савхатов Д.Х. (зам.главного редактора),
Сейтказина Г.Д., Филиппенко В.И., Чичуа Н.А.

Редакционный совет

Давыдов М.И. (Россия)	Ш. Фуджи (Япония)
Мусулманбеков К.Ж. Казахстан	В. Кешич (Сербия)
Шарман А.Т. (Казахстан)	М.А. Мур (США)
Алчинбаев М.К. (Казахстан)	Р. Якез (Австрия)
М. Россели (Италия)	К. Нарайян (Австралия)

Ответственный секретарь
Кабдрахманов К.Б.

Редакторы переводов
Аязбаев Н.Б., Галушкин М.А., Утельбаева А.Е.

Адрес редакции
г. Алматы, 480091, пр. Абая, 91
НИИ онкологии и радиологии МЗ РК
Тел. (327) 292 10 63
«Онкология и радиология Казахстана», №1 (18), 2011 г.
Собственник - РГКП «НИИ онкологии и радиологии МЗ РК»
Свидетельство о регистрации - №10248-ж от 14.07.2009 г.
Тип. «Идан», ул. Коммунальная, 39
Тираж 200 экз.
Журнал выпускается 1 раз в 3 мес.

Содержание

Диагностика

Сравнительная оценка информативности визуальных методов диагностики колоректального рака. *Арзыкулов Ж.А., Жолдыбай Ж.Ж., Садыков М.С.* (3)

Лучевая диагностика прорастания опухоли толстой кишки. *Арзыкулов Ж.А., Жолдыбай Ж.Ж., Садыков М.С.* (5)

Метафизарные корковые дефекты длинных трубчатых костей в период их роста. *Хуснутдинова Г.И., Савхатов Д.К.* (7)

Современные возможности компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике злокачественных новообразований головного мозга у детей. Литературный обзор. *Потапов А.В.* (9)

Особенности злокачественных новообразований и их диагностики в детском возрасте. Литературный обзор. *Потапов А.В.* (11)

Возможности компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике злокачественных новообразований костей и мягких тканей у детей. Литературный обзор. *Потапов А.В.* (13)

Ранняя диагностика рака яичников. *Батырова Л.М.* (15)

Роль ранней диагностики рака молочной железы. *Батырова Л.М.* (16)

Лечение

Комплексное лечение меланомы кожи и его результаты. *Абисатов Х.А., Балтабеков Н.Т., Савхатов Д.Х.* (17)

Лечение опухолей глаза и орбиты. *Ажигалиева М.Н.* (21)

Миома матки, железистая гиперплазия эндометрия и нейроэндокринные нарушения — факторы риска развития рака эндометрия. *Аликулова У.А.* (23)

Опыт применения препарата Бортезомиб у пациентов с множественной миеломой в Павлодарской области. *Сейсенбекова Ж.Б.* (25)

Альтернативные методы предупреждения осложнений хирургического лечения туберкулеза легких. *Зетов А.Ш.* (26)

Эзофагеальное стентирование при раке пищевода. *Жураев Ш.Ш., Байтилеуов Т.А., Шайхиев Е.У., Садыков Н.К., Шокебаев А.А.* (27)

Предоперационная химиоинфузия в бронхиальную ар-

терию в комплексном лечении немелкоклеточного рака легкого III стадии. *О.К. Кулакеев, С.Е. Оспанов, Д.Т. Арыбжанов* (29)

Результаты хирургического и комбинированного лечения рецидивных сарком мягких тканей. *Байзаков Б.Т., Кулакеев О.К.* (32)

Предоперационная лучевая терапия больных раком прямой кишки при различных режимах фракционирования и с радиомодификаторами. *Кулиева Н.Г.* (36)

Профилактика постлучевых осложнений у пациенток с раком шейки матки. *Батырова Л.М.* (39)

Консервативное лечение больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста. *К.И. Ниязбекова* (40)

Эпидемиология

Распределение гистологических типов рака легкого по регионам Республики Азербайджан. *А.А. Солтанов* (42)

Клинико-генеалогический анализ семей с плоскоклеточным раком кожи. *Алиева К.А., Гасанова А.Х.* (46)

К вопросу о гисто-цитоморфологических особенностях плоскоклеточного рака кожи. *Мурадов Х.К., Гасанова А.Х.* (48)

Оптимизация скрининга заболеваний молочной железы. *Ватанха В.С.* (51)

Тезисы

Возможности криотерапии при лечении базальноклеточного рака кожи. *Серикбаев Г.А., Жумадуллаев Б.М., Тулеуова Д.А., Савхатов Д.Х., Косаев А.К.* (58)

Клинико-цитологические особенности местнораспространенного рака шейки матки при применении неоадьювантной полихимиотерапии Аликулова. *Жамбылский ООД* (58)

Результаты хирургического и комбинированного лечения опухолей плечевой кости. *Серикбаев Г.А., Жумадуллаев Б.М., Тулеуова Д.А., Савхатов Д.Х., Косаев А.К.* (59)

Хирургическое лечение гигантоклеточных опухолей костей. *Тулеуова Д.А., Серикбаев Г.А., Савхатов Д.Х., Косаев А.К.* (59)

Современные подходы к организации паллиативной помощи в Республике Казахстан. *Кульжанов М.К., Егеубаева С.А., Нуркеримова А.К., Досмаилова А.М.* (60)

Сравнительная оценка информативности визуальных методов диагностики колоректального рака

Арзыкулов Ж.А., Жолдыбай Ж.Ж., Садыков М.С.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Колоректалды обырдың визуалды диагностикалық тәсілдерінің ақпараттық салыстырмалы бағасы

Ж.Ә.Арзықұлов, Ж.Ж.Жолдыбай, М.С.Садықов

Колоректалды обырды әртүрлі диагностикалық тәсілдермен зерттеу арқылы ісіктің таралу дәрежесін бағалай отырып, қолайлы диагностикалық тәсілдер қолданылды. Колоректалды обырды саластырмалы түрде анықтауда эндоскопиялық зерттеу биопсия алумен қатар, кешенді рентгенологиялық зерттеу, ультрандыбысты зерттеулер ең негізгі минималды алгоритм болып саналады.

Анализ наблюдений позволил определить возможности

Comparative Evaluation Of The Informativeness Of The Visual Methods Of Diagnostics Colorectal Cancer

Arzykulov Zh.A., Zholdybay Zh.Zh., Sadykov M.S.

The analysis of observations made it possible to determine the possibilities of different methods of study in the estimation of the prevalence of tumor process. The carried out observations and their analysis it made possible to manufacture the rational

различных методов исследования в оценке распространенности опухолевого процесса. Проведенные наблюдения и их анализ дал возможность выработать рациональную диагностическую тактику применения диагностических методов при опухолевых поражениях толстой кишки. При этом следует, что эндоскопическое исследование толстой кишки с биопсией, комплексное рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследование органов брюшной полости является тем минимальным диагностическим алгоритмом, который необходим для дифференциальной диагностики колоректального рака.

diagnostic tactics of the application of diagnostic methods with the tumor defeats of thick gut. In this case it follows that an endoscopic study of thick gut with the biopsy, a comprehensive x-ray examination, the ultrasonic the study of the organs of abdominal cavity are that minimum diagnostic algorithm, which is necessary for differential diagnostics of colorectal cancer.

Одной из наиболее сложных, трудоемких и значимых проблем современной медицины является проблема диагностики и лечения заболеваний кишечника. В Республике Казахстан ежегодно выявляется более 2-х тысяч больных раком ободочной и прямой кишки [1,2]. По показателям смертности колоректальный рак занимает соответственно 6 и 7 место.

В настоящее время современная программа исследования для ранней диагностики заболеваний толстой кишки, предусматривает использование как эндоскопических методов, в первую очередь фиброколоноскопии, так и рентгенологических [3,4,5]. Детальное распознавание онкологических заболеваний органов брюшной полости, а также степени распространенности опухолевого процесса, не представляется возможным без применения УЗИ, КТ.

С целью углубленного научного анализа данных клинического, инструментального и лучевых методов обследования больных с онкологическими заболеваниями толстой кишки на различных этапах диагностики и лечения была проведена сравнительная оценка информативности визуальных методов диагностики колоректального рака.

Из данной таблицы 1. следует, что результаты КТ измерений в большинстве случаев соответствовали макроскопическим размерам опухоли. Преуменьшение размеров опухоли при эндоскопическом исследовании и первично – двойном контрастировании объяснялись отсутствием возможности измерить экстраорганный протяженность образования, которая являлась максимальным ее

размером. Кроме того, невозможность продвижения колоноскопа или ректоскопа при стенозирующих опухолях также служила причиной неудачных измерений.

Преувеличение размеров опухоли при первично – двойном контрастировании наблюдалась в тех случаях, когда максимальным был размер опухоли по длиннику и не учитывался феномен проекционного искажения. Ошибочные результаты измерений при трансабдоминальной эхографии были следствием недостаточной визуализации органа из – за большого количества газа в кишечнике.

Как видно из представленных в таблице данных, при эндоскопическом и рентгенологическом исследовании толстой кишки оценка инвазивности роста опухоли была ограничено возможной, даже при группировании стадий Т3 – Т4. Эти методы малоэффективны вследствие невозможности

Таблица 1. Сравнительная эффективность различных методов диагностики в определении максимального размера опухоли толстой кишки (точность до 1 см)

Степень соответствия результатов измерений верифицированным данным	Количество исследований (абс.)							
	ЭИ		РИ		УЗИ		КТ	
	абс.	% ± m	абс.	% ± m	абс.	% ± m	абс.	% ± m
С о в п а д е н и е размеров	324	81,2±2,1	342	85,7±1,9	352	88,2±1,7	391	97,9 ± 0,7
Преувеличение размеров	19	4,8±5,0	24	6,0±4,9	16	4,0±5,0	2	0,5 ± 7,0
Преуменьшение размеров	30	7,5±4,9	15	3,8±5,1	14	3,5±4,5	2	0,5 ± 7,0
О т с у т с т в и е возможности измерить опухоль	26	6,5±4,9	18	4,5±5,0	17	4,3±5,0	4	1,0 ± 5,7
Всего исследований:	399	100	399	100	399	100	399	100

Таблица 2. Сравнительная эффективность диагностических методов в определении глубины инвазии рака толстой кишки

Хар-ка опухоли TNM	Кол – во случаев (абс.)				Оценка метода		
	ИП	ЛО	ЛП	ИО	Т	Ч	С
Первично – двойное контрастирование толстой кишки							
T3 – T4	243	88	66	2	0,62	0,73	0,14
% ± m	60,9±3,1	22,1±4,4	16,5±4,6	0,5±7,0			
Эндоскопическое исследование толстой кишки							
T3 – T4	236	83	67	13	0,58	0,70	0,11
% ± m	59,1±3,2	20,8±4,5	16,8±4,6	3,3±5,1			
Трансабдоминальная эхография							
T3	252	24	18	105	0,90	0,69	0,92
% ± m	63,2±3,0	6,0±4,9	4,5±5,0	26,3±4,3			
T4	10	25	24	340	0,80	0,78	0,81
% ± m	2,5±5,2	6,3±4,9	6,0±4,9	85,2±1,9			
Компьютерная томография							
T3	337	6	8	48	0,97	0,98	0,87
% ± m	84,5±1,9	1,5±5,4	2,0±5,3	12,0±4,7			
T4	12	3	6	378	0,98	0,84	0,99
% ± m	3,0±5,1	0,8±6,3	1,5±5,4	94,7±1,1			

оценки внекишечного роста опухоли и поэтому представляли значительное количество ошибочных результатов.

Возможности КТ более информативны, по сравнению с ПДК и УЗИ в определении размеров опухоли по длиннику и поперечнику, измерении толщины пораженной стенки, а также протяженности опухоли по отношению к окружности кишки. Измерения проводили как по аксиальным срезам, выполненным на уровне опухоли, так и по реконструктивным изображениям необходимого сечения отрезка кишки, пораженного опухолью.

Анализ наблюдений позволил определить возможности различных методов исследования в оценке распространенности опухолевого процесса. Проведенные наблюдения и их анализ дал возможность выработать рациональную диагностическую тактику применения диагностических методов при злокачественных и доброкачественных поражениях толстой кишки. При этом следует, что эндоскопическое исследование толстой кишки с биопсией, комплексное рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследование органов брюшной полости

является тем минимальным диагностическим алгоритмом, который необходим для дифференциальной диагностики колоректального рака.

Эндоскопическое исследование рекомендуется в качестве основного метода диагностики в скрининговой программе раннего выявления колоректального рака.

Ультразвуковое исследование толстой кишки выполняется после уточнения локализации зоны обструкции с помощью эндоскопического или рентгенологического методов.

Анализируя достоинства и недостатки клинических и инструментальных методов диагностики колоректального рака, можно сделать вывод, что ни один из них не является абсолютно точным. Только комплексное использование в определенной последователь-

ности традиционных рентгенологических, ультразвуковых и КТ методов диагностики в состоянии преодолеть ограничения классических приемов обследования пациентов.

Список использованной литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2008 г. (статистические материалы). - Алматы, 2009. - 99 с.
2. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И., и др. // Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2009г. – Алматы, 2010. - 108с.
3. Перевозников А.И. Возможности колоноскопии в диагностике причин толстокишечной непроходимости: автореф. дис. канд. мед. наук. - М., 1999. - 25с.
4. Кузьмин-Крутецкий М.И. Колоноскопия в диагностике и лечении хирургических заболеваний толстой кишки: автореф. дис. д-ра мед. наук. - СПб, 1998.
5. Наврузов С.Н., Абдужаппаров С.Б., Ососков А.В. Роль и значение рентгендиагностики при онкологии аноректальной зоны // Мат. VI съезда онкологов и радиологов стран СНГ. - Душанбе, 2010. - С. 88.

Лучевая диагностика прорастания опухоли толстой кишки

Арзыкулов Ж.А., Жолдыбай Ж.Ж., Садыков М.С.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Тоқ ішек ісігінің өсуінің сәулелік диагностикасы Ж.Ә.Арзықұлов, Ж.Ж.Жолдыбай, М.С.Садықов

Сәулелік диагностикалық тәсілдің тиімділігін бағалауда тоқ ішек обырының ағзалармен тіндерге өсуін анықтағанда КТ зерттеудің дәлдігі - 0,98; сезімталдығы - 0,96; арынайлығы - 0,98 және осыған сәйкес трансабдоминалдық эхография - 0,88; 0,81; 0,90.

Тоқ ішектің қатерлі ісігінің орнын, ішектің қабырғасына өсу дәрежесін анықтауда ультрадыбысты зерттеу тәсілінен де, ең ақпаратты тәсіл - бұл компьютерлік томография болып саналады.

При сравнении эффективности лучевых методов диагностики в определении прорастания рака толстой кишки в окружающие органы и ткани точность КТ составляет 0,98; чувствительность - 0,96; специфичность - 0,98 и ТАЭ - 0,88; 0,81; 0,90 соответственно.

КТ является значительно более информативным методом определения границ раковой опухоли, ее локализации в толстой кишке и степени прорастания за пределы кишечной стенки по сравнению с УЗИ.

Оценку степени распространения опухоли в стенку толстой кишки проводили, руководствуясь классификацией TNM. Согласно этой классификации степень T1 соответствовала опухолевой инфильтрации кишечной стенки до подслизистого слоя, а T2 - до мышечного слоя. Степень T3 подразумевает распространение опухоли до субсерозного слоя, а степень T4 - прорастание серозной оболочки и распространение на соседние структуры.

Как при трансабдоминальной эхографии (ТАЭ), так и при компьютерной томографии (КТ) было невозможно дифференцировать стадии T1, T2, T3. Поэтому оценку возможности этих методов в определении глубины инвазии рака толстой кишки осуществляли по следующей группировке стадий: T1 - T2 - опухоль ограничена стенкой кишки, T3 - опухоль распространяется на непокрытые брюшиной поверхности кишки, T4 - опухоль прорастает серозную оболочку и распространяется на соседние органы и ткани.

Эта градация давала возможность более объективно сопоставить эффективность применяемых методов. При КТ и трансабдоминальной эхографии (ТАЭ) стадия T3 характеризовалась довольно четким контуром органа на уровне опухоли, а окружающая клетчатка сохраняла структурность, что давало основание утверждать, что опухоль ограничивается стенкой кишки. Опухоль в этой стадии не распространяется на субсерозный участок кишки [1,2,3].

Стадия T3 включает в себя также те случаи, когда опухоль поражает субсерозную поверхность толстой кишки. Непокрытые брюшиной поверхности имеют, как известно, восходящая ободочная кишка, нисходящая ободочная кишка и промежуточная часть прямой кишки. При поражении этих отделов толстой кишки в КТ картине и при УЗИ наблюдали неровный бахромчатый наружный контур кишки и инфильтрацию прилежащей клетчатки. В тех случаях, когда поражался субсерозный участок восходящей ободочной или нисходящей ободочной кишки, к вышеуказанным симптомам присоединялся признак утолщения находящихся

Beam Diagnostics Of The Germination Tumor The Guts Fat

Arzykulov Zh.A., Zholdybay Zh.Zh., Sadykov M.S.

With the comparison of the effectiveness of the beam methods of diagnostics in the determination of the germination of cancer of thick gut into the surrounding organs and the cloth the accuracy X-ray CT composes 0,98; sensitivity - 0,96; specificity - 0,98 and trans-abdominal of ultrasonic study - 0,88; 0,81; 0,90 respectively.

X-ray CT is the considerably more informative method of determining the boundaries of cancerous tumor; its localization to the thick gut and the degree of germination beyond the limits of intestinal wall in comparison with the Ultrasonic study.

в этой зоне листков брюшины. Распространение опухоли на серозную оболочку кишки соответственно T4. При этом контур органа становился нечетким и бахромчатым, что являлось при КТ и ТАЭ отображением выхода на поверхность кишки опухолевых узлов. Воспалительная инфильтрация жировой клетчатки всегда сопровождала выход опухоли за пределы кишки, что также служило признаком стадии T4.

Причинами неправильных заключений при КТ и УЗИ явилась подпаянность опухоли к прилежащим петлям кишки и недостаточная выраженность жировой клетчатки, окружающей опухоль [4,5]. В этих случаях правильная интерпретация КТ и УЗИ картины была невозможна.

Стадия T3-T4 включала в себя также случаи прорастания опухоли в соседние органы и ткани, этот процесс был у 71 (17,8%) больного. У них были отмечены прорастание опухоли в различные органы брюшной полости и забрюшинного пространства, частота поражения которых по отношению к общему количеству больных со степенью инвазии T4, представлена в таблице 1.

Из таблицы видно, что в результате прорастания раковой опухоли наиболее часто поражались органы и ткани малого таза, тонкий кишечник и ее брыжейка, брыжейка сигмовидной кишки. Другие органы брюшной полости и забрюшинного пространства поражались с меньшей частотой.

При анализе наблюдений вне кишечного распространения опухоли обнаружено, что по данным УЗИ и КТ картина прорастания рака толстой кишки отличается многообразием и зависит от степени, места инвазии и выраженности жировой клетчатки [6,7]. Постоянной особенностью являлось утолщение стенки кишки в месте прорастания опухоли в другой орган с потерей четкого изображения наружного контура кишки и деформацией ее просвета.

У 9 больных опухоль прямой кишки и дистального отрезка сигмовидной кишки вовлекала в свою структуру матку или мочевого пузырь, при этом задняя поверхность пораженной кишки не прослеживалась, образуя единый

Таблица 1. Частота прорастания раковой опухоли в окружающие органы

	Количество случаев	
	абс.	%
Матка и ее придатки	5	7,0
Мочевой пузырь	4	5,6
Стенки таза	12	16,9
Брыжейка сигмовидной кишки	17	23,9
Тонкий кишечник и ее брыжейки	10	14,1
Желудок и желудочно – ободочная связка	5	7,0
Почки	5	7,0
Предстательная железа и семенные пузырьки	4	5,6
Передняя брюшная стенка	4	5,6
Печень и желчный пузырь	3	4,2
Магистральные сосуды	2	2,8
Всего:	71	100

Таблица 2. Сравнительная эффективность лучевых методов диагностики в определении прорастания рака толстой кишки в окружающие органы и ткани

ме-тод	Кол – во случаев								Оценка методов		
	ИП		ЛО		ЛП		ИО		Т	Ч	С
	абс.	М ± m	абс.	М ± m	абс.	М ± m	абс.	М ± m			
ТАЭ	67	16,8 ± 4,6	16	4,0 ± 5,0	20	5,0±5,0	296	74,2±2,5	0,88	0,81	0,90
КТ	80	20,0 ± 4,5	4	1,0 ± 9,9	3	0,8±6,2	312	78,2±2,3	0,98	0,96	0,98

конгломерат неправильной формы. Поражение мочевого пузыря у 4 больных характеризовалось относительно небольшим по протяженности местом пролабирования опухоли в стенку пузыря. Менее часто поражались семенные пузырьки и предстательная железа, что объясняется наличием между этими органами и прямой кишкой плотной перегородки (апоневроз), а также наличием собственной капсулы предстательной железы.

Прорастание опухоли поперечно – ободочной кишки в желудок и желудочно – ободочную связку у 5 больных проявлялась наличием облаковидного уплотнения желудочно – ободочной связки с вовлечением в его структуру стенки желудка. При этом на КТ томограммах и при УЗИ визуализировали уплотнение жировой клетчатки в проекции брыжейки с наличием отдельных узловых образований, обусловленных увеличенными лимфатическими узлами.

Выраженное прорастание опухоли сигмовидной кишки в собственную брыжейку имело место в 17 случаях и всегда сопровождалось увеличением лимфатических узлов пораженной брыжейки и усилением ее сосудистого рисунка.

Прорастание опухоли ободочной кишки в печень с распространением ее и на желчный пузырь наблюдали у 3 пациентов. На КТ и при УЗИ наблюдали плотное примыкание опухоли печеночного угла ободочной кишки к печени и перестройку структуры последней, при вовлечении в процесс желчного пузыря его стенки и околопузырная клетчатка теряли дифференцировку, контуры желчного пузыря деформировались, содержимое становилось неоднородным с более высоким, чем в норму денситометрическими показателями (17 – 22Н) [4,8].

При раке восходящей, нисходящей ободочной кишки и удлинненной сигмовидной кишки в некоторых наблюдениях отмечалось прорастание опухоли в окологепатическую клетчатку. При этом опухолевые массы ни в одном из случаев не достигали паренхимы.

В 17 наблюдениях опухоль толстой кишки распространялась на стенки кишечника, которые прилежали к опухоли. При УЗИ и на КТ в этих случаях

обнаруживали опухолевую инфильтрацию прилежащей жировой клетчатки, в структуре которой наружный контур вовлеченной кишки не дифференцировался.

Поражение передней брюшной стенки имело место у 4 больных при обширных опухолях поперечно – ободочной кишки. В КТ и ультразвуковой картине при этом отсутствовала дифференцировка между мышцами передней брюшной стенки и врастающей в них опухолью.

Из таблицы 2 видно, что в определении вне кишечного распространения опухоли ультразвуковые методы исследования обладали меньшей эффективностью, чем КТ. Это объясняется ограниченным полем зрения интракорпоральных датчиков и наличием препятствия для проникновения ультразвука при трансабдоминальной эхографии. Также следует, что в определении прорастания рака толстой кишки в соседние органы и ткани при КТ было сделано 7 ошибочных заключений. Как ложноотрицательные, так и ложноположительные результаты имели место

при наличии сопутствующего перифокального воспаления в зоне прорастания опухоли. Даже при ретроспективном анализе КТ томограмм этих больных мы не обнаружили дифференциально – диагностических различий опухолевой и воспалительной инфильтрации.

Однако, несмотря на указанные ошибочные результаты, данные КТ являются методом выбора в определении прорастания рака толстой кишки в окружающие органы и ткани. При этом точность метода составляет 0,98; чувствительность – 0,96; специфичность – 0,98.

Таким образом, компьютерная томография является значительно более информативным методом определения границ раковой опухоли, ее локализации в толстой кишке и степени прорастания за пределы кишечной стенки по сравнению с УЗИ. Вместе с тем, этими методами невозможно разрешить поражение отдельных слоев кишечной стенки.

Список использованной литературы

1. Жаркова И.И. Лучевые методы диагностики в онкологическом скрининге // Вестн. рентгенологии и радиологии. - 1992. - №1. - С. 10-11.
2. Китаев В.В. Компьютерная томография опухолей ободочной кишки // Вестн. рентгенологии и радиологии. - 1991. - №1ю-С. 37-41.
3. Лемешко З.А. Роль ультразвукового метода в диагностике злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта / Мат. всесоюзной научн. «Актуальные проблемы организации и повышения качества ультразвуковой диагностики опухолей». - М., 1990. - С. 149-150.
4. Китаев В.В., Железнев Д.И. Компьютерная томография при раке толстой кишки // Вестн. рентгенологии и радиологии. - 1991. - №1. - С. 41-45.
5. Фазылов А.А., Фазылова С.А. Перспективные технологии ультразвуковой диагностики в онкологии // Мат. VI съезда онкологов и радиологов стран СНГ. - Душанбе, 2010. - С. 95.
6. Орлова Л.П. Диагностические возможности ультразвуковых методов исследования в колопроктологии // Проктология. - 2006. - №1. - С. 3-10.
7. Лемешко З.А., Григорьева Г.А., Гурвич Р.Н. Ультразвуковое исследование кишечника // Клиническая медицина. - 1998. - №6. - С. 89-94.
8. Горшков А.И., Акберов Р.Ф. Комплексное клиничко-рентгенологическое исследование в диагностике опухолей толстой кишки // Вестник рентгенологии и радиол. - 1993. - №6. - С. 47-49.

Метафизарные корковые дефекты длинных трубчатых костей в период их роста

Хуснутдинова Г.И., Савхатов Д.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Мақалада өсу кезіндегі ұзын қуыс сүйектердің метафизарлық қабықша ақауларф бойынша қысқаша мәліметтер мен негізінен өс кезеңдегі ұзын қуыс сүйектердің рентгенограммасы бойынша өзіндік клиникалық консультациялық материалдың талдауы берілген (32 байқа).

Жұмыста диагностикалаудың қателектері мен қиындықтары, сонымен қатар өзіндік байқаулары бойынша метафизарлық қабықша ақауларының ағымдық ерекшеліктері көрініс тапқан.

Цель

- дать краткие сведения по диагностике метафизарных корковых дефектов длинных трубчатых костей в период их роста.

Задача

- на основе собственного клинического консультативного материала дать анализ по метафизарным корковым дефектам длинных трубчатых костей.

Основной анализ проведен по рентгенограммам и КТ костей скелета (КТ в единичных случаях).

Поверхностные лакуны костной ткани, известные в литературе, как «метафизарные фиброзные корковые дефекты» благодаря радиографическим методам исследования (главным образом, обычной рентгенографии, линейной и компьютерной томографии) стали довольно часто наблюдаться при исследовании костей по различным мотивам (травма, опухоль или какое-либо другое заболевание).

Обнаруженные случайно кортикальные дефекты становятся нередко причиной серьезных диагностических ошибок и клиницистов и радиологов и гистологов. Так, например, их принимают за внесуставные туберкулезные очаги, костную кисту, гигантоклеточную опухоль, фиброзную дисплазию, абсцесс Броди, эозинофильную гранулему, костную саркому.

Гистологически обычно они расцениваются как «остеобластокластома» или «фиброзная дисплазия», «веретенноклеточная» саркома (Виноградова Т.Т., 1964).

По мнению Некачалова В.В. (2000) микроскопически ткань кортикального дефекта состоит из коллагеновых волокон, тесно прилегающих друг к другу. Между волокнами выявляются фиброциты, а также гигантские клетки, напоминающие остеокластомы, макрофаги и близок к «неостеогенной фиброме».

Между тем, научные исследования последних лет указывают на то, что кортикальные дефекты являются анатомическим вариантом развития костей у детей и не требуют специального лечения (Kaats' Th.E., Joyce Th.M., 1984).

В этом аспекте чрезвычайно важно привлечь внимание широкого круга врачей к данной проблеме. Терминология данного состояния подробно изложена в монографии Квашниной В.И. (1971). Есть указания М.В. Волкова (1985), что субпериостальная форма неостеогенной фибромы при ее краевом расположении развивается из метафизарного коркового дефекта. По мнению С.Т. Зацепина (2000) метафизарный кортикальный дефект, наблюдаемый у детей, чаще ничем себя не проявляющий и не имеющий никакой

In article brief data on diagnostics metaphysical cortical defects long. Tubular bones during their growth and the analysis own clinical. Advisory material basically under roentgenograms of long tubular bones. In the period of their growth (32 supervision).

In work mistakes and difficulties of diagnostics, and also feature of current are reflected metaphysical cortical defects on own supervision.

семиотики, обнаруживаемый случайно на рентгенограммах является неопухолевым диспластическим процессом.

Этиопатогенез

До сих пор нет единого мнения о природе метафизарных корковых дефектов. Можно согласиться с теми исследователями, которые считают, что корковые дефекты это состояния патологической костной перестройки (Рейнберг С.А., 1964; Богоявленский И.Ф., 1976; Хуснутдинова Г.И., 1980).

Существуют мнения о метафизарных корковых дефектах у детей как о множественных очагах варианта развития, как о нормальном анатомическом варианте развития растущих костей, наблюдающихся у совершенно здоровых детей и подростков ((Kerts Jh.E., M.D. and Joyce M.D., 1984).

Клиника Квашнина В.И. (1971) считает, что кортикальные лакуны -заболевание растущего скелета, чаще в возрасте от 5 до 15 лет, могут быть обнаружены и у взрослых и даже у пожилых людей.

Терние их чаще бессимптомное, редко отмечается выраженный болевой синдром, чаще исследуются мальчики в связи с травмой, отсюда их преобладание по сравнению с девочками. Лабораторные исследования без отклонений от нормы.

Рентгенологическая картина

метафизарного коркового дефекта характерна: типичное проявление в виде краеобразующего при выведении на контур дефекта в корковом слое неправильно-овальной формы с полициклическими контурами и склеротическим ободком, расположенного по длиннику кости, обычно в метафизарных отделах длинных трубчатых костей, чаще всего от 0,5см x 1,0 см, реже крупнее, гомогенно просветленной структуры в зависимости от степени выраженности или отсутствия костной репарации на момент исследования.

Иногда возможно вздутие истонченного контура коркового слоя, однако периостальная реакция не характерна.

Собственный консультативный материал составляет 32 наблюдения с метафизарными корковыми дефектами. Наиболее часто корковые дефекты наблюдались в бедренной кости (14)) большеберцовой (13), реже малоберцовой (3), редко плечевой (1) и в лучевой (1) костях с обеих сторон с заметным преобладанием в дистальном метафизе большеберцовой кости.

Из таблицы 1 видно, что метафизарные корковые дефекты встречаются у детей в подростковом и юно-

Таблица 1. Распределение числа наблюдений с метафизарными корковыми дефектами по полу и в возрасте

Пол	Возраст (в годах)			
	До 10	11-15	16-10	Всего
Мужской	3	8	12	23
женский	1	3	5	9
Итого:	4	11	17	32

Таблица 2. Распределение числа наблюдений с метафизарными корковыми дефектами по полу и локализации

Локализация в костях	Всего	Локализация в метафизах длинных в трубчатых костях			
		Муж.	жен	Муж.	жен
		проксим.	проксим.	дистальн	дистальн
бедренная	14	1	3	7	3
большеберц.	13	4	4	3	2
малоберцу	3	1	1	1	-
плечевая	1	1	-	-	-
лучевая	1	-	1	-	-
пяточная	1	-	-	-	-
седалищная	1	-	-	-	-
	34*	14	9	4	5
		32			

* - Примечание: у 2-х - двойная локализация в костях

шеском возрастах: до 10 лет - у 4, с 11 до Yd- у 11, с 16 до 20 лет - у 12, а именно в периоде роста костей скелета. Самого младшего возраста была девочка 2-х лет. Распределение числа наблюдений с корковыми дефектами по полу и локализации представлено в таблице №2.

Из таблицы № 2 видно, что несколько преобладала локализация в дистальной метафизе бедренной (7) и проксимальном метафизе большеберцовой (4) костей. В других костях одиночные наблюдения встречались как в проксимальных, так и в дистальных метафизах трубчатых костей (малоберцовой, плечевой и лучевой), редко - в других костях (пяточная -1, седалищная кость- 1).

Наблюдения показывают, что метафизарные корковые дефекты возникали неизменно в метафизе длинной трубчатой кости и в динамике с ростом кости в длину как бы отодвигались в метадиафиз и даже в диафиз постепенно, подвергаясь костной репарации.

Рентгенограммы в динамике за 6 мес, 1,5 года и 3 года показали заметную костную репарацию в виде появления краевого реактивного характера остеосклероза за счет эндо-ста и структурной перестройки в зоне фиброзных дефектов.

Ошибки и трудности диагностики по собственным наблюдениям

При направлении на консультацию ставились следующие диагнозы: туберкулезный остит бедренной кости -1, остеомиелит бедренной кости -1, повреждение мениска - 1, ушиб, разрыв связок голеностопного сустава -1, патологический перелом -2 (большеберцовой кости -1, лучевой -1), абсцесс Броди обеих бедренных костей -1, фиброзная дисплазия -2, абсцесс Броди большеберцовой

кости -1, асептический некроз большеберцовой кости -1, инфекционно-аллергический полиартрит -1, саркома Юинга большеберцовой кости -1.

К трудностям следует отнести одно наблюдение при типичной рентгенологической картине коркового дефекта большеберцовой кости у мальчика 13-14 лет в сочетании с зоной Лоозера в малоберцовой кости гистологическое заключение было - «остеоид - остеома».

Особенности течения метафизарных корковых дефектов в собственных наблюдениях:

1. Метафизарный корковый дефект бедренной кости наблюдался в сочетании с болезнью Кёнига у юноши 17 лет.
2. Корковый дефект проксимального метафиза плечевой кости в сочетании с врожденной деформацией П-Ш пальцев кистей у подростка 15 лет.
3. Корковый дефект метафиза лучевой кости наблюдался с аналогичным дефектом в 1 пяточной кости у подростка 14 лет.
4. Двусторонняя локализация в дистальных метафизах бедренных костей у подростка 13 лет.
5. Метафизарный корковый дефект в разных костях (в бедренной и большеберцовой) у юноши 16 лет.
6. Операция предпринималась по поводу фиброзной остеодисплазии нижней трети бедренной кости подростку 13 лет, ^рентгенологически оценивался как метафизарный корковый дефект, гистологическое заключение - фиброзный корковый дефект.

Закключение. Несмотря на то, что метафизарные корковые дефекты в настоящее время радиологически хорошо изучены, распознавание их возможно лишь при знакомстве с ними. Ошибки и трудности в диагностике их имеют место, как в клинической, так и рентгенологической оценке. Особенно трудна их гистологическая оценка.

Что касается их сущности: заболевание растущей кости или вариант развития не так уж важно. Важно, что они исчезают без всякого лечения при динамическом наблюдении и не являются опухолевой природы.

Путаницу в диагностике метафизарных корковых дефектов вносят, к сожалению, и клиницисты, и рентгенологи, и гистологи. Поэтому диагностика метафизарных корковых дефектов должна быть комплексной, главным образом, клинко-рентгенологической и гистологической, здесь требуется профессионализм.

Список использованных источников

литературы

1. Богоявленский И.Ф. Патологическая функциональная перестройка костей скелета. М.: Медицина, 1976.-С. 110-117.
2. Виноградова Т.Т. Диагностика костно-суставной патологии по биопсиям. М., 1964.-С.178-181.
3. Волков В.В. Болезни костей у детей. Мю: Медицина, 1985.-364 с.
4. Зацепин С.Т. Костная патология взрослых. М.: Медицина, 2001.-С.213-216.
5. Квашкина В.И. Дифференциальная диагностика метафизарных корковых дефектов трубчатых костей. Ташкент, 1971.
6. Th.E.Keats' M.D., Ju.M.Joyce M.D. Metaphyseal cortical irregularities in children: A new Perspective on a Multi-Total growth variant //Skeletal Radiology.-1984.-№ 12.-С. 112-118.

Современные возможности компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике злокачественных новообразований головного мозга у детей. Литературный обзор

Потапов А.В.

Центральная клиническая больница
Управления делами Президента РК, Алматы

Компьютерлік және магнитті-резонансті томография балалар бас миы ісігін анықтауда негізгі сәулелік диагностика болып табылады. КТ және МРТ жаңа мүмкіндігін пайдалана ерте диагностикалау, педиатриялық практикада бас миы қатерлі жаңа түзілімін емдеудің нәтижесін жақсартады.

Компьютерная и магнитно-резонансная томография являются основными методами лучевой диагностики в выявлении опухолей головного мозга у детей. Ранняя диагностика с применением современных возможностей КТ и МРТ способствует улучшению результатов лечения больных со злокачественными новообразованиями головного мозга в педиатрической практике.

Computer and magnetic resonance imaging are the main methods of beam diagnostics in identifying brain tumors in children. Early diagnosis using advanced features of CT and MRI improves outcomes of therapy of the patients with malignant tumors of the brain in pediatric practice.

В настоящее время отмечается неуклонный рост частоты злокачественных опухолей головного мозга. Рост показателей заболеваемости связан не только с улучшением выявляемости опухолей с помощью новых диагностических методов, но и с истинным возрастанием случаев опухолей головного мозга (Дергунова Н.И., 2004). Лучевая диагностика злокачественных новообразований головного мозга, несмотря на внедрение в клиническую практику КТ и МРТ, по мнению большинства авторов, продолжает оставаться актуальной проблемой. Ранняя диагностика с применением современных возможностей КТ и МРТ способствует улучшению результатов лечения больных со ЗН головного мозга (Ахметова Г.С., 2007).

Рентгеновская компьютерная томография длительное время является одним из основных методов в нейроонкологической практике (Гайдар, 2006). КТ позволяет визуализировать ткань опухоли головного мозга, оценить анатомо-топографические особенности выявленного образования и попытаться дифференцировать их основные типы. В настоящее время методы компьютерной томографии интенсивно развиваются и большинство этих нововведений могут быть успешно использованы в диагностике опухолей головного мозга у детей в качестве вспомогательных высокоинформативных и малоинвазивных методик.

КТ ангиография пришла на смену традиционной ангиографии сосудов головного мозга. Эта методика предполагает быстрое внутривенное болюсное введение рентгеноконтрастного препарата. Преимуществами метода являются быстрота исследования и соответствие полученных данных результатам интраартериальной ангиографии, при этом возможна визуализация и артериальных и венозных структур, которые определяются одновременно. К недостаткам метода можно отнести использование контрастного вещества и отсутствие информации о характере потока. В детской нейроонкологии КТ ангиография позволяет оценить изменение сосудистой топографии, выявить стенозирование магистральных сосудов вследствие воздействия новообразования, визуализировать особенности строения собственной сосудистой сети опухоли (в том числе внутриопухолевые шунты) (Гайдар, 2006).

КТ-миело-цистернография – метод, сочетающий в себе возможности КТ и миелографии, который относится к инвазивным методам получения изображений, так как требует введения в субарахноидальное пространство контрастного вещества. В отличие от рентгеновской миелографии, при КТ-миелографии требуется меньшее количество контрастного вещества. (Можаев С.В., Субботин А.Е., 2000; Decler Y.A., Shimada H., Gonzalez I., 2004).

Перфузионная компьютерная томография этот метод позволяет оценить временные и объемные показатели перфузии мозга путем оценки динамики прохождения контрастного вещества по сосудам головного мозга. Преимущества перфузионной КТ является быстрота исследования. Недостатком является необходимость использования контрастного вещества и ограничение протяженности зоны исследования. В нейроонкологии перфузионная КТ способна оценить степень васкуляризации новообразования и особенности его кровоснабжения, а также эффект предоперационной эмболизации опухоли (Pedrosa P., Higher H.P., Schuth M., 2009).

Магнитно-резонансная томография на сегодняшний день является основным и высокоинформативным методом в исследованиях патологических состояний головного мозга, в первую очередь для диагностики опухолей головного мозга, в том числе в педиатрической практике (Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Озерова В.И., Пронин И.Н., 2001). Преимуществами МРТ являются высокое пространственное разрешение, высокая чувствительность к изменению белого вещества мозга, получение изображений с большими анатомическими деталями в любой плоскости сканирования, что позволяет точнее оценить взаимоотношение опухоли и сосудистых стволов, различить геморрагические и кистозные компоненты опухоли.

Широкий, постоянно совершенствующийся, набор импульсных последовательностей обеспечивает различный тип тканевой контрастности на МР-изображениях, что предоставляет большие, чем при КТ возможности для характеристики различных тканей, что имеет большое практическое значение в том числе и в педиатрической нейроонкологии (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006).

Несколько слов о современных МРТ методиках, которые помогают в диагностике опухолей головного мозга.

Магнитно-резонансная ангиография головного мозга в отличие от спиральной компьютерной томографии, обычной и цифровой субтракционной ангиографии, позволяет визуализировать кровеносные сосуды даже без применения контрастного вещества. Исследования можно проводить в режимах 2D или 3D (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006). При МР-ангиографии удается визуализировать основные магистральные артерии, включая основные стволы внутренних сонных и позвоночных артерий, а также их внутримозговые сегменты. Применительно к нейроонкологии МР-ангиография позволяет оценить дислокацию и нарушение проходимости магистральных сосудов головного мозга вследствие воздействия опухоли, источники кровоснабжения и дренирование. При МР-ангиографии у больных с новообразованиями головного мозга, преимущественно менингосудистого ряда, необходимо оценивать как дислокационные изменения, так и источники кровоснабжения. Визуализация венозной системы при МР-флебографии является важным звеном в диагностике объемных патологических образований головного мозга и позволяет оценить взаимоотношение синусов, вен с новообразованиями (Klaus-Dietrich Ebel, Hans Blickman, Eberhard Willich, Ernst Richter, 1999).

Магнитно-резонансная миелография и цистернография - неинвазивные методики, позволяющие получать высококонтрастные по отношению к веществу мозга изображения ликворных пространств без дополнительного контрастирования, применяются для изучения анатомии ликворных пространств и выявления патологических новообразований в них (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006).

Диффузно-взвешанные магнитно-резонансные изображения позволяют дифференцировать зоны быстрой и медленной диффузии протонов. При этом зоны с быстро движущимися протонами имеют более высокий по сравнению с неизменной мозговой тканью сигнал (Krabbe K., Gideon P. et al., 1997). Диффузно-взвешанные исследования дают дополнительную диагностическую информацию для дифференцировки новообразований головного мозга со сходными проявлениями на T1 и T2 МРТ (глиомы, опухоли с кольцевидным накоплением контраста), перитуморальной отека (вазогенный или цитотоксический), о наличии или отсутствии внутриопухолевых кист (Mulkern M., Gudbjartsson H., Westin C. et al., 2006). В последнее время диффузно-взвешанные и тензорные МРТ начали применяться для визуализации хода нервных трактов мозга – трактография. Стало возможным с помощью трактографии планировать операционный доступ и объем оперативного удаления внутримозговых опухолей с учетом знания расположения проводящих путей, их заинтересованности в патологическом процессе (смещение, деформация или инвазия и повреждение) с целью максимально радикальной резекции опухоли и с минимальными послеоперационными осложнениями (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006).

Перфузионные магнитно-резонансные изображения это метод получения МР-изображений позволяет путем срав-

нения динамики прохождения парамагнитного контрастного вещества или артериальной крови с измененными («мечеными») спинами через вещество мозга оценить тканевую перфузию, а также рассчитать временные характеристики мозгового кровотока (Sartor K., 2002). В настоящее время перфузионные исследования проводятся для оценки гемодинамики опухолей головного мозга, при дифференциальной диагностике поражений мозга, для мониторинга состояния опухоли после проведенной лучевой и химиотерапии, в диагностике рецидива опухоли и/или лучевого некроза (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006).

Функциональная магнитно-резонансная томография. Картирование активности мозга позволяет выявить области нейрональной активности головного мозга, возникающие при тестах в ответ на стимуляцию – действие моторных, сенсорных и других раздражителей. Функциональная МРТ должно будет стать неотъемлемой частью МРТ-протокола у больных с опухолями головного мозга, расположенными вблизи функционально значимых зон коры головного мозга. На основе полученных данных нейрохирурги проводят планирование операционного подхода и объем резекции новообразования, а радиологи рассчитывают области распределения дозы планирование облучения опухоли (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006; Гайдар Б.В., 2006).

Магнитно-резонансная спектроскопия позволяет неинвазивно получить информацию о метаболизме мозга. Основана МР спектроскопия на регистрации «химического сдвига» и позволяет оценивать содержание отдельных химических соединений, чаще всего метаболитов (N-ацетиласпартат, холин-содержащих, креатин, лактат, АТФ, миоинозитол и пр.) в отдельных участках головного мозга. В онкологии данная методика применяется для оценки различных объемных образований головного мозга (Meng L., 2004). Несмотря на то, что по данным МР спектроскопии нельзя с уверенностью предсказать гистологические тип новообразования, тем не менее большинство исследователей сходятся во мнении, что опухолевые процессы характеризуются низким соотношением N-ацетиласпартата к холину (NAA/Cho), увеличением соотношения холина к креатину (Cho/Cr) и в некоторых случаях появление пика лактата. Дифференциальный диагноз между продолженным ростом, рецидивом опухоли и лучевым некрозом крайне затруднен. В подобных случаях протонная МР спектроскопия является дополнительным методом в дифференциальной диагностике. В спектре лучевого некроза характерным признаком является наличие так называемого «мертвого пика» - широкого лактат-липидного комплекса в диапазоне 0,5-1,8 ppm на фоне полной редукции пиков остальных метаболитов (Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 2006; Гайдар Б.В., 2006).

Таким образом, КТ и МРТ является основным методом лучевой диагностики в педиатрической нейроонкологии, позволяющим не только проводить выявление опухолей головного мозга, но и проводить их дифференциальную диагностику между собой и неопухолевыми заболеваниями. При этом сегодня речь идет не просто о диагностике, а о возможно раннем распознавании новообразований головного мозга.

Особенности злокачественных новообразований и их диагностики в детском возрасте.

Литературный обзор

Потапов А.В.

Центральная клиническая больница
Управления делами Президента РК, Алматы

Ересектермен салыстырғанда, балаларда кездесетін қатерлі түзілімнің өзіндік клиникалық, эпидемиологиялық және генетикалық сипаттағы ерекшеліктері бар. Балалар қатерлі түзілімін диагностикалау, ересек пациенттерден айырмашылығы бар. Мысалы, табиғаты эпителиалды ісік (рак) балаларда өте сирек кездеседі, ал саркомалар өте жиі. Балаларда 3 жасқа дейін кездесетін ісіктер туа пайда болған, ал ересектерде бұндай ісіктер 3-4% жағдайда кездеседі.

Malignant neoplasms in childhood have characteristic features in clinical, epidemiological and genetic development in compared with adults. Diagnostics of malignant neoplasms in children is also different from adult patients. For example,

Существуют характерные клинические, эпидемиологические и генетические признаки опухолей у детей. Так, например, опухоли эпителиальной природы (раки) у детей встречается не чаще, чем в 5-6% всех наблюдений, в тоже время саркомы встречаются практически в 84% случаев. Львиная доля всех злокачественных образований у детей по гистогенезу представлены производными мезенхимы и нейроэктодермы, в то время как у взрослых преобладают эпителиальные опухоли. В детском возрасте отмечается высокий удельный вес так называемых эмбриональных опухолей, составляющих в структуре заболеваемости около 40%, а у детей до 1 года – до 85% (Дурнов Л.А., 2003). В подавляющем большинстве случаев опухоли у детей до 3 лет – врожденный, у взрослых такие опухоли встречаются не более чем в 3-4% случаев. Сравнительно высокая частота злокачественных опухолей в первые годы жизни делает весьма вероятным предположение об антенатальном происхождении опухолей детского возраста (Дурнов Л.А., 2003).

Нередко опухоли и пороки развития органов и систем возникают одновременно. Целенаправленные исследования позволяют установить у подавляющего большинства детей с опухолями те или иные признаки дисморфизма. Так, например, крестцово-копчиковые тератомы могут сочетаться с различными опухолевыми образованиями нижнего отдела позвоночника, нижних отделов живота и урогенитальной области (Dahlin D.C., Umi K.K., 1986). У детей, страдающих крипторхизмом, в 35 раз повышен риск возникновения злокачественной опухоли. Риск увеличивается с ростом ребенка, а абдоминальная локализация в 4 раза озлокачивается, чем паховая. Гетеротипические или персистирующие ткани плода могут иметь предрасположенность к развитию опухолей. Так, они могут вызывать краниофарингиому в кармане Ратке, хордому из нотохордальных остатков ядер пульпы, светлоклеточную аденокарциному генитального тракта из остатков мезотелия, различные карциномы в области бронхиальных, щитоподъязычных кист, а также

Злокачественные новообразования в детском возрасте имеют характерные клинические, эпидемиологические и генетические особенности в сравнении со взрослыми. Диагностика злокачественных новообразований у детей также имеет отличия от взрослых пациентов. Так, например, опухоли эпителиальной природы (раки) у детей встречается редко, в тоже время саркомы встречаются очень часто. В подавляющем большинстве случаев опухоли у детей до 3 лет – врожденный, у взрослых такие опухоли встречаются не более чем в 3-4% случаев.

tumors of epithelial nature (c-r) in children is rare, at the same time sarcomas occur very often. The vast majority of tumors in children under 3 years old - congenital, in adults population, such tumors are not more than 3-4% of cases.

из остатков удвоенной кишки и дефектов билиарного тракта (Hanson J.W., 2006). Описана группа синдромов, которые могут дать ценную информацию при изучении генетики опухолевых заболеваний. Острый лейкоз описан при синдроме Rubinstein-Taubi (короткий роста, задержку развития, аналогичные черты лица, и широкие пальцы ног и первый), аномалии Poland (отсутствие большой грудной мышцы и синдактилия), синдроме Шварцмана (экзокринная поджелудочная недостаточность и нейтропения). Гепатобластома описана при синдроме Beckwith-Wiedemann. Саркомы мягких тканей нередко обнаруживаются Li-Fraumeni), болезни Ретлинггаузера. Опухоль Вилмса сочетаются с нейрофиброматозом, синдромом Drash (псевдогермафродитизм, гломеруллопатия и опухоль почки), с пороками мочеполовой системы – крипторхизм, гипоспадия, дисгения гонад, особенно у мальчиков, с нейрофиброматозом Perlmann (двухсторонняя почечная гамартома, макросомия, гипертрофия клеток поджелудочной железы, необычное лицо). Болезнь Ходжкина часто встречается у детей с таким синдромом, как атаксия-телеангиоэктазия (Дурнов Л.А., 2003; Hanson J.W., 2006).

К следующей особенности опухолей в детском возрасте можно отнести то, что около половины всех опухолей у детей, не принимая во внимание ранний детский возраст, занимают гемобласты (острый лейкоз, злокачественные лимфомы, лимфогранулематоз). Значительный удельный вес приходится на опухоли ЦНС, затем следуют новообразования забрюшинного пространства, такое распределение отмечено в большинстве стран мира, о чем было отмечено в эпидемиологическом обзоре выше.

Из солидных злокачественных новообразований в педиатрической практике наиболее часто встречаются новообразования головного мозга (15-20%), опухоли брюшной полости и забрюшинного пространства (в том числе нефробластома - 6-8% и нейробластома 5-7%), саркомы мягких тканей (8%) и костей (5-6%), ретинобластома (2-4%) (Дурнов Л.А., 2003; Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Ж., Жумадуллаев Б.М., 2006)

Опухоли центральной нервной системы – наиболее частые солидные опухоли у детей. Большинство опухолей головного мозга (70-80%) у детей возникают из глиальных клеток не метастазируют за пределы ЦНС до проведения оперативных вмешательств (Ланцовский Ф., 2005).

Большинство злокачественных новообразований у детей отличаются значительно более высокой чувствительностью к химиолучевой терапии, чем у взрослых, что определяет более благоприятный прогноз. При многих злокачественных опухолях у детей длительный период ремиссии можно добиться у 70-90% пациентов (Чиссов В.И., Дарьялова С.Л., 2007).

В успехах, достигнутых в лечении злокачественных опухолей у детей, решающее значение играет своевременная диагностика на ранних этапах его развития (Дурнов Л.А., 2006). Однако диагностика в онкологической практике у детей имеет свои особенности. Во-первых, невозможность получения анамнеза от самого пациента, (речь идет о детях раннего возраста), отсутствием жалоб. Поэтому приходится прибегать к расспросу родителей и ближайших родственников, а этот анамнез далеко не равноценен анамнезу, полученному от больного. Вторая особенность характеризуется относительно малым числом визуально обнаруживаемых опухолей. У детей встречается как казуистика рак молочной железы, рак шейки матки, рак пищевода и желудка (большинство из

которых доступны эндоскопическому исследованию). Третьей особенностью диагностики опухолей в педиатрической практике относится расположение наиболее часто встречающихся опухолей в труднодоступных для исследований областях: черепная коробка (опухоли ЦНС), забрюшинное пространство (нейробластома и нефробластома). Опухоли, локализующиеся в этих областях нередко растут длительно не вызывая видимых объективных изменений. Раздвигая окружающие органы и ткани, новообразования, постепенно увеличиваются в размере и часто обнаруживаются лишь тогда, когда достигают значительной величины, или, как это нередко бывает при нейробластоме, дают метастазы в отдаленные органы и ткани (Чиссов В.И., Дарьялова С.Л., 2007). Следующей особенностью диагностики онкопатологии в детском возрасте является то, что существует большое количество «масок», под которыми скрываются злокачественные опухоли. Практически любое заболевание в раннем детском возрасте, да и некоторые физиологические состояния могут быть похожи своими проявлениями на опухолевый процесс и наоборот (Чиссов В.И., Дарьялова С.Л., 2007).

Диагностический процесс в современной педиатрической онкологии это сложный комплекс мероприятий, начинающийся с расспроса родителей и ребенка (если это возможно), осмотра последнего и включающий в себя применение целого ряда специальных методик, основное место среди которых занимают методы лучевой диагностики.

Возможности компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике злокачественных новообразований костей и мягких тканей у детей. Литературный обзор

Потапов А.В.

Центральная клиническая больница
Управления делами Президента РК, Алматы

Бүгінгі күні педиатриялық практикада КТ және МРТ сүйек және майда тінді ісіктерді анықтауда негізгі диагностикалық әдіс болып табылады. Кампьютерлі және магнитті –резонансті томография аймақтағы жаға жетістіктер, балаларда кездесетін сүйек және майда тін қатерлі ісіктерін ерте анықтап, және де жасалған ем нәтижесін бағалауға мүмкіндік береді.

CT and MRI of today are the main methods of diagnosis of bone tumors and soft tissue tumors in pediatric practice. Advancements in computer and magnetic resonance imaging

Компьютерная томография последнее время интенсивно развивалась в форваторе технического прогресса создания современной аппаратуры и программного обеспечения. Сейчас появились мультidetекторные компьютерные томографы с большой скоростью сканирования и возможностью производить срезы до 0,5 мм с высоким разрешением. Появилась возможность ретроспективной реконструкции в различных плоскостях. Для определения поражения костей используют костные алгоритмы исследования с костными и мягкоткаными окнами (Fayad L.M., Johnson P., et al., 2005; Dalrymple N.C., Prasad S.R., et al., 2007)

При опухолях костей КТ также используется для получения вспомогательных данных в диагностике костеобразующих опухолей, чтобы оценить деструкцию костной ткани и стабильность костей, а также как сопровождение чрескожной деструктивной терапии.

КТ в диагностике опухолевого поражения костей показана при неопределенности относительно наличия обызвествления или оссификации опухолевого матрикса, а также если необходимо выявить начальные эрозивные изменения или определить протяженность деструкции костной ткани. Обызвествление матрикса в патологическом образовании помогает дифференцировать хондрогенные опухоли от остеогенных (Прокоп М., Галански М., 2007)

Компьютерная томография занимает одно из ведущих мест в диагностике опухолей мягких тканей различной локализации, в 90-100% точно оценивает распространенность пальпируемых опухолей за счет незначительного различия в плотности изучаемых тканей (Каминская И.В., 2003; Fayad L.M., Johnson P., et al., 2005). КТ позволяет выявить мягкотканые новообразования, судить об их форме, размерах, границах, структурных особенностях, взаимоотношениях с прилежащими органами (Weekes R.G. McLeon R.A., Reiman H.M., Pritchard D.J. 1985; Лукьянченко А.Б., 1990). Однако все опухоли мягких тканей имеют схожие проявления при КТ, патогномичных признаков для какого-либо типа не выявлено, исключение составляет липома (Munk P.L., Lee M.J., Janzen D.L., Connel D.G., Logan P.M., Poon P.Y., Bainbridge T.C., 1997; Каминская

КТ и МРТ на сегодняшний день являются основными методами диагностики опухолей костей и мягких тканей в педиатрической практике. Современные достижения в области компьютерной и магнитно-резонансной томографии способствуют раннему выявлению злокачественных новообразований костей и мягких тканей у детей, а также позволяют проводить оценку эффективности проводимой терапии.

to early detection of malignant tumors of bone and tumors of soft tissues in children, and also allow evaluation of the effectiveness of therapy.

И.В., 2003). Заподозрить наличие злокачественное новообразование при КТ исследовании можно по наличию вторичных деструктивных изменений в прилежащих костных структурах в виде нарушения целостности коркового слоя. Отсутствие разделительной жировой прослойки между опухолью и костью при неизменном кортикальном слое всегда свидетельствует об интимной связи с надкостницей. КТ высокочувствителен в выявлении вторичных изменений кости – возможно выявить глубину инвазии, что оказывает помощь в выборе тактики оперативного лечения (Соколовский В.А., Лукьянченко А.Б., 1988).

До внедрения болюсного контрастирования и ангиографических методик исследования с применением КТ возникали сложности в выявлении вовлеченности в патологический процесс сосудов и нервных стволов. Единственным признаком, указывающим на вовлечение в патологический процесс было отсутствие на нескольких томограммах разделительных жировых прослоек (Vanel D., 1997).

Следует отметить, что информативность КТ выше в предоперационном периоде, так как после хирургических вмешательств затруднено выявление опухолевой ткани на фоне постоперационных изменений (соединительная ткань, гематомы и т.д.) (Ekelund L., Herrbin K., Rydholm A., 1983; Hudson T.M., Hamlin D.J., Ennking W.P., Peterson H., 1985) Возникают сложности в диагностике с использованием КТ непальпируемых опухолей мягких тканей. Главным образом эти затруднения связаны с тем, что плотность новообразования и мягких тканей имеют общие значения, и приходится ориентироваться на косвенные признаки, такие как смещение близлежащих анатомических структур, жировых и соединительно тканых прослоек, увеличению объема мышечной массы в сравнении с контрлатеральной стороной (Ekelund L., Herrbin K., Rydholm A., 1983; Hudson T.M., Hamlin D.J., Ennking W.P., Peterson H., 1985)

Таким образом, эффективность КТ в отображении основных проявлений опухолей костей выше, чем рентгенографии, за счет более точной оценки состояния коркового слоя, лучшего выявления периостальных реактивных изменений, более детальной характеристики

внутренней структуры поражения, лучшего определения границы очагов, формы внутрикостных включений, внекостного компонента, а также оценки его взаимоотношений с близлежащими анатомическими структурами и сосудисто-нервным пучком (Иммухаметов А.И. Шариффуллин Ф.А.1992; Чибисова М.А.,1997) При этом к недостаткам компьютерной томографии в диагностике злокачественных новообразований опорно-двигательной системы можно отнести то, что затруднена дифференциальная диагностика большинства злокачественных и доброкачественных опухолей мягких тканей. Кроме того, получение поперечных КТ-изображений конечностей сопряжено с выполнением многочисленных срезов на значительном протяжении, что удлиняет время исследования и ведет к увеличению лучевой нагрузки на пациента.

Однако современное развитие метода компьютерной томографии в сочетании с контрастными и сосудистыми исследованиями, а также постпроцессорной обработки полученных изображений позволяют поставить этот метод на одно из первых мест в диагностики злокачественных новообразований костей и мягких тканей в том числе и в педиатрической практике.

Магнитно-резонансная томография относится к от одному из самых молодых методов лучевой диагностики, однако, он уже зарекомендовал себя как высокоинформативный метод исследования в диагностике опухолей опорно-двигательной системы (Bertomi F., Unni K.K. McLeod R.A. Dahlin D.C., 1985; Berkowitz J.F., Kier R., Rudicel S., 1991)

Отсутствие МР-сигнала от кортикального слоя кости и кальцификатов, как считали некоторые авторы на ранних этапах использования МРТ, делали этот метод малоприменимым для диагностики остеогенных опухолей (Jardf O., Desablens B., Defrance D. et al., 1987; Pardo M. J., Feuntes R.M., Martin M.K., Garcia H.R., 1991). В дальнейшем мнение большинства авторов изменилось. К числу хорошо визуализируемых образований относят гемангиому, метастазы (Buetow P., Kransdorf M., Moser R., 1990), гемопоэтические опухоли (множественная миелома, лимфома и эозинофильная гранулема..

МРТ позволяет непосредственно визуализировать опухоль, уточнить ее структуру, характер роста, более точно, чем рентгенография, оценить границы опухолевой инфильтрации костного мозга и кортикального слоя. Преимуществом МРТ также является возможность непосредственной визуализации, оценки структуры и границ экстраоссального мягкотканого компонента, определения его соотношения с сосудисто-нервным пучком и окружаю-

щими тканями (Брюханов А.В., Васильев А.Ю., 2006) МР-томографическая симптоматика опухолей костей зависит от типа опухолевой матрицы (хрящевая, фиброзная, костная, мягкотканая), степени агрессивности новообразования и особенности его роста в костномозговом канале. В зависимости от характера роста различают экспансивные и инфильтративные новообразования костей (Berquist T.H.,1989).

На МР-томограммах злокачественные косте- и хрящевые опухоли в большинстве случаев проявляются наличием зоны инфильтрации костного мозга с неровными нечеткими контурами (Vanel D., Lacombe M., Covanet D. et al., 1987). Необходимо отметить, что точная оценка гистологической структуры новообразования по данным МР-томографии практически невозможна, тем не менее МРТ считается методом выбора при оценке протяженности и размеров злокачественных опухолей костей. По сравнению с другими методами лучевого исследования МРТ позволяет наиболее точно установить границы опухолевой инфильтрации в костномозговом канале, протяженность поражения кортикального слоя и субпериостального распространения опухолевой ткани (Manaster B.J., Ensign M.F., 1991). Существенное значение при проведении МРТ также имеет оценка размеров и локализация экстраоссального компонента, определение его четких границ и соотношение с различными группами мышц и сосудисто-нервным пучком (Брюханов А.В., Васильев А.Ю., 2006).

Злокачественные опухоли мягких тканей на МР-томограммах, как правило, визуализируются как одиночные или множественные образования с неровными контурами, средней и низкой интенсивности МР-сигнала на T1 ВИ и средней и высокой интенсивности на T2 ВИ. Структура новообразования чаще всего неоднородная за счет наличия участков некроза и кровоизлияний. Злокачественные опухоли практически всегда сопровождаются отеком прилежащих мягких тканей, прорастают в окружающие мягкие ткани (в том числе сосудисто-нервный пучок), распространяются на надкостницу и вызывают вторичные костные изменения. Благодаря высокой контрастности изображения мягких тканей МРТ позволяет детально характеризовать структуру опухоли, форму, контуры и тип роста опухоли, определить ее локализацию, протяженность, размеры и связь с соседними тканевыми структурами. Таким образом, современные достижения в области компьютерной и магнитно-резонансной томографии способствуют раннему выявлению злокачественных новообразований костей и мягких тканей у детей, а также проводить оценку эффективности проводимой терапии.

Ранняя диагностика рака яичников

Батырова Л. М.

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

Проблема распознавания злокачественных опухолей яичников является одной из наиболее трудных и нерешенных(1,3). Повсеместный рост заболеваемости раком яичников, высокие показатели смертности определяет актуальность и приоритетность этой проблемы.

Отсутствие патогномичных симптомов при ранних стадиях заболевания, широта возрастной группы заболевших женщин – все это представляет значительные трудности в диагностике рака яичников, поэтому больные чаще всего поступают в стационар на лечение в стадии диссеминации опухоли.(1,3,4,5,8)

Так, целью данного исследования является поиск наиболее эффективного сочетания комплексного обследования пациенток с подозрением на рак яичников.

Диагностика злокачественных опухолей яичников основана на использовании инструментальных и лабораторных методах исследования.

Основные задачи диагностики сводятся к:

- определение топика процесса (какой орган поражен);
- характер поражения (злокачественный или доброкачественный процесс);
- степень распространенности процесса;
- состояние организма (с целью определения возможности применения того или иного вида лечения).(2,4,7,9)

При обнаружении объёмного образования в области малого таза необходимо исключить такие заболевания, как дивертикулиты, внематочную беременность, кисты и доброкачественные опухоли яичника, миому матки, и эндометриоз. Следует помнить, что некоторые злокачественные новообразования, такие, как рак ЖКТ или молочной железы, могут метастазировать в яичники.(2,4,10)

С клинического обследования- начинается постановка диагноза: выяснение жалоб, сбор анамнеза и гинекологическое исследование.(1,5,6,10)

Наряду с анализом клинических данных применяется УЗИ малого таза. Этот метод- точен на 80-90 процентов, безвреден и многократно проводим при необходимости.(1,3,7) Для более углублённой диагностики при наличии опухолей яичников применяют такие высокоинформативные методы, как КТ и МРТ, ПЭТ. Диагностическая информативность МРТ в выявлении злокачественных опухолей яичника выше, чем УЗИ, КТ, показателя СА-125 в сыворотке крови и других клинических методов исследования.(4,7,8,9)

Возможность визуализации жизнеспособной опухолевой ткани и оценки ее биологической активности по степени интенсивности накопления в тканях метаболического РФП отличает ПЭТ от лучевой диагностики. ПЭТ обеспечивает возможность получения уникальной информации, в частности: достоверную дифференциальную диагностику злокачественных опухолей, доброкачественных новообразований и неопухолевых заболеваний; точное определение регионарной и отдаленной распространенности опухолевого процесса «во всем теле» и за одно исследование; объективную оценку эффективности проводимого лечения, а также раннее выявление рецидивов.(1,2,5,9)

Рентгенография грудной клетки — обязательный компонент обследования при подозрении на опухоль

яичников, так как позволяет диагностировать возможное метастазирование в лёгкие и плевральную полость.(2,6,10)

Выполнение лапароскопии или лапаротомии и получение материала для гистологического исследования является необходимым для постановки диагноза. Только гистологическая верификация диагноза может дать точный и окончательный ответ (1,3,8)

Определение маркеров опухоли яичников – опухолевых антигенов в частности -СА 125, не является решающим в постановке диагноза и учитывается лишь в сочетании с другими признаками рака.(4,8) Маркеры рака яичников могут быть повышены и при других заболеваниях, а также у беременных женщин.

С целью уточнения патогенеза опухолей и опухолевидных образований яичников, наряду используются такие современные методы исследования, как цитоморфологические, морфометрические, гистохимические.

Таким образом, согласно данным литературы, современная диагностика опухолей яичников не может базироваться на одном каком-то методе исследования, а требует целого комплекса диагностических мероприятий для установления факта наличия яичникового образования на ранних стадиях развития и проведения дифференциальной диагностики доброкачественного или злокачественного процесса, а также определения возможного морфологического строения опухоли.

Своевременная диагностика в значительной мере определяет успех современного лечения при раке яичников.

Список литературы

1. Абдуллаева Л.М., Бабаджанова Г.С., Турсунов Х.З., Назарова Д.Б. Клинико-морфологические особенности доброкачественных опухолей яичников // *Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ. Ташкент, 2008.* 372.
2. Автандилов Г.Г. Окулярная измерительная сетка для цито-, гисто- и стереометрических исследований // *Архив патологии. 1972. Т.34. №6.* 76-77.
3. Айрапетян Л.Г., Джилаян Г.А. Оценка некоторых прогностических факторов при лечении рака яичников // *Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ. Ташкент, 2008.* 373.
4. Антонеева И.И. Патогенетические аспекты прогрессии неоплазмы при раке яичников // *Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ. Ташкент, 2008.* 374.
5. Ахмедова А., Сергеева Н.С., Маршуткина Н.В., Мишунина М.П., Новикова Е.Г. Опухолеассоциированный антиген СА 125 в динамике у больных раком яичников при разных схемах лечения. // *Вопросы онкологии. 2003. 49. № 1.* 95-98.
6. Каирбаева М.Ж. Современные подходы к лечению рака яичников// *Здоровье и болезнь. – 2009. - №5(81).* - С.5-9.
7. Нугманов Э.У., Кайрбаев М.Р., Кукубасов Е.К., Каирбаева М.Ж.
8. Молекулярный маркер СА-125 в сыворотке крови больных раком яичников // *Терапевтический вестник. – 2009. - № 3 (23).* – С.302.
9. Жордания К.И. Некоторые аспекты диагностики и лечения рака яичников // *Онкология и гематология – 2003 - №10 – с 4-6.*
10. Урманчеева А.Ф. Мешкова И.Е. Вопросы эпидемиологии и диагностики рака яичников // *Онкология и гематология – 2006- № 3-с 6-9.*
11. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. Л., 1989.–464 с.

Роль ранней диагностики рака молочной железы

Батырова Л. М.

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

Каждый год в мире регистрируются около 1 млн. женщин заболевших раком молочных желез (РМЖ).[1,2]

В структуре онкологической заболеваемости рак молочной железы занимает первые позиции [1]. Летальность от рака молочной железы в Алматинской области увеличилась в 1,3 раза и составляет 6,1 чел. на 100 000 населения (2008 год) [1]. Поэтому, совершенствование методов ранней диагностики рака молочной железы является актуальным.

В Республике Казахстан – ежегодно регистрируют и ставят на учёт с раком молочной железы около трех тысяч женщин. [3]

Учитывая опыт передовых стран с 2008 г. в Казахстане внедряется скрининговая программа рака молочной железы. В маммографическое обследование включены женщины в возрасте от 50 до 60 лет.[1,2,6]

Цель настоящего исследования - анализ эффективности проводимых комплексных обследований молочной железы - маммографического, ультразвукового, биопсийного, для успешного лечения и снижения смертности от рака молочной железы в областном онкологическом диспансере города Талдыкорган.

Диагностика рака молочной железы включает два направления: первичный и уточняющий.[2,5]. К первичной диагностике относят самообследование и индивидуальный осмотр. Одним из ведущих методов уточняющего диагноза является маммография.

Скрининговая маммография (МГ) – целевая профилактическая рентгенография молочной железы определенных возрастных групп женщин. Причем, соответственно стандарта каждой женщине делают снимки в двух проекциях, то есть четыре снимка.

Основная цель скрининговой маммографии – выявление бессимптомных ранних форм рака молочных желез[4,5].

При маммографии определялось, что для раннего рака молочной железы характерны округлость образования однородной структуры размером от 1см до 5см, мелкобугристые контуры, соседние ткани имели дезорганизацию структурного рисунка и микрокальцинаты.

Таблица 1. Показатели размеров опухолей

Больные, %	Размеры, см
24,8±5,2	до 1
45,2±3,7	от 1 до 2
30,0±4,7	от 2 до 5
100	

Раннее выявление РМЖ – своевременное лечение и продление срока жизни. Ранний рак молочной железы – это преневзивный (неинфильтрирующий) внутрипротоковый рак, а также «микроинвазивный» рак с очагами начинающей инвазии.[1,6]

При ультразвуковом исследовании определялась неоднородность внутренней структуры, наличие синдрома внутреннего эха и акустическое затемнение позади[1,2]

Ультразвуковое исследование проводилось с использованием цветового и энергетического доплера (HITACHI, Япония).

Морфологическая диагностика проводится в несколько

этапов: цитологический (дооперационный), цитологические и гистологические экспрессные методы (интраоперационные), плановое гистологическое исследование (операционный) и цитологическое исследование (диспансерный).

Биопсия - проводилась с выделений из молочной железы, пункционная с образования, готовились мазки-отпечатки с изъязвленной поверхности и операционный материал с самой опухоли молочной железы и регионарных лимфоузлов. В результате морфологической диагностики выявляется внутримембранный, интрапротоковый; инвазивный протоковый, дольковый, медуллярный, коллоидный и тубулярный рак (таблица 2).

Итак, маммография и лабораторный скрининг могут приме-

Таблица 2. Гистологические типы опухолей

Больные, %	Тип опухоли
8,2±2,2	Неинвазивный протоковый
5,1±0,7	Инвазивный дольковый
76,5±6,8	Инвазивный протоковый
3,4±0,8	Инвазивный папиллярный
2,3±0,06	Медуллярный
4,5±0,8	Слизистый
100	

няться как алгоритмы при комплексном подходе выявляемости ранних стадий рака молочной железы [3,4,5,6] Многоэтапная диагностика позволяет достичь установления 100% диагноза.

Таким образом, наиболее перспективным в диагностике рака молочной железы является дальнейшее развитие многоэтапной диагностики.

Литература

1. Лучевая диагностика заболеваний молочной железы (методические рекомендации). МЗ РК КАЗНИИОУР. г. Алматы 2009 г. с 5-7.
2. Лучевая диагностика заболеваний молочной железы (методические рекомендации). 7-18.08.2006. МЗ РК КАЗНИИОУР. с 2-5.
3. Республиканский семинар «Вопросы ранней диагностики рака молочной железы и шейки матки» (сборник статей) МЗ РК КАЗНИИОУР. Международное общество гинекологического рака. 1-3.11.2007 г. Алматы. с 15-16.
4. Республиканский семинар с международным участием «Современные подходы в диагностике и лечении рака молочной железы» (сборник статей) МЗ РК КАЗНИИОУР. 6-7.10.2008 г. Алматы. с 7-8.
5. Республиканский Мастер-КЛАСС с международным участием 5. «Выявление, диагностика и лечение рака молочной железы» МЗ РК КАЗНИИОУР. Европейская школа онкологии. 2-6.11.2009 г. Алматы. с 3-4.
6. Приказ МЗ РК №607 от 15.10.2007. «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения». с 4-7
7. Аналитические годовые обзоры Областного онкологического диспансера г. Талдыкорган за 2007, 2008, 2009 г с55-56, с78-79, с94-96.

Комплексное лечение меланомы кожи и его результаты

Абисатов Х.А., Балтабеков Н.Т., Савхатов Д.Х.
Казахстанско-Российский медицинский университет,
Алматинский городской онкологический диспансер, КазНИИОиР

Тері меланомасымен сырқаттанған 278 науқасқа алдымен түбегейлі тұрғыда хирургиялық ем қолданылып, олар төмендегідей алты топқа бөлінді: I – топқа хирургиялық ем (64 науқас), II – операциядан кейінгі сәулелік ем (49 науқас), III – 49 науқасқа операциядан кейін төменгі деңгейліктегі интерферон альфа (3 млн МЕ №10), IV – 37 науқасқа операция + жоғарғы интерферон альфа (9 млн МЕ/м² №4), V – 47 науқасқа химияиммундық ем, VI – 43 науқасқа - химиотерапия (дакарбозин, цисплатин).

Проведена сравнительная оценка эффективности шести методов лечения у 278 больных меланомой кожи, где 64 больным произведено радикальное хирургическое лечение (контрольная группа), остальным 214 больным адъювантные курсы лучевой терапии (49 больных), низкодозная иммунотерапия интерфероном альфа по 3 млн МЕ/ №10 (38 больных), высокодозная иммунотерапию интерфероном альфа (по 9 млн МЕ/м² №4) химио-иммунотерапия (47 больных), химиотерапия (43 больных).

Актуальность

Меланома кожи является чрезвычайно злокачественной опухолью нейроэктодермального происхождения, развивающаяся из меланоцитов, продуцирующих специфический пигмент-пептид меланин. Из-за высокой потенции к местному росту, способности к диссеминации лимфогематогенным путем по коже, регионарным лимфатическим и отдаленным органам, меланома кожи относится к одной из самых агрессивных форм злокачественных опухолей с непредсказуемым прогнозом

Основным методом лечения меланомы кожи является хирургический, эффективность и адекватность которого во многом зависит от пред- и интраоперационного стадирования заболевания. На ранних стадиях, соответствующих I и отчасти II степени инвазии по Кларку после хирургического лечения около 90% пациентов переживают 5 и более лет, а при поражении опухолью глубоких слоев кожи, включая дерму, подкожно-жировую клетчатку, при наличии внутрикожных метастазов вокруг основного очага и в регионарных лимфатических узлах эффективность хирургического лечения резко снижается и основная масса больных погибают на фоне прогрессирования опухолевого процесса в течение первых двух-трех лет (В.В. Анисимов, С.В. Фрадкин 2000, А.С. Барчук 2004, Л.В. Демидов с соавт, 2004 Д.В. Кудрявцев, 2009, А.В.Ф. Batch с. et al, 2001, Batch С.М. et al, 2001).

Для улучшения результатов хирургического лечения локально-регионарных форм меланомы кожи ведется активный поиск путей химио- иммунотерапевтической профилактики рецидивов и метастазов.

Следует отметить, что существующие в настоящее вре-

мя противоопухолевые химиопрепараты и биологические модификаторы по отношению к меланоме и ее метастазам малоэффективны. Тем не менее среди противоопухолевых химиопрепаратов наиболее активными являются декарбазин, препараты платины и нитрозометилмочевина, однако отдаленные результаты применения их в плане профилактики рецидива и метастазов во многом невысокие и неоднозначные (Л.В. Демидов с соавт, 2004, Л.Д. Носов, 2004, Н.И. Переводчикова, 2005, Д.Д. Пак с соавт, 2008 Д.В. Кудрявцев с соавт, 2008, Atkins М.В., 1999, Eggermont А.М. et. al, 1998, Keilholz V. et. al, 1999, Rozenberg S. et. al, 1999).

С целью повышения функции иммунной системы организма, а также для профилактики дальнейшего прогрессирования опухолевого процесса в дальнейшем зарубежье проведено ряд проспективных кооперативных исследований с применением различных дозных режимов интерферона-а у больных меланомы кожи II-III стадии (Cascinelli N. et. al, 1994, G Grob J.J. et al, 1998, Legha. S, 1997, Kizkwood J. M. et al, 2000). Тем не менее нерешенным остается вопрос, при каких стадиях меланомы наиболее эффективен высокодозный, при каких низкодозный режим применения интерферона. Малоизученным вопросом является целесообразность сочетанного применения химиопрепаратов с интерфероном-а.

Цель исследования

- оценить эффективность различных видов адъювантной терапии меланомы кожи.

Материал исследования

Материалом для исследования послужили данные о 278 больных меланомой кожи, проходивших лечение на базе онкологических клиник г. Алматы в период с 1997 по 2004 годы, прослеженность более 5 лет составила 100%.

Средний возраст больных составил 60,3 года. По полу распределение больных было следующим: женщин -171(61,5%), мужчин-107 (38,5%).

Для установления диагноза меланомы кожи и ее стадии, степени распространенности наряду визуальным осмотром и пальпацией были применены дерматоскопия аппаратом «Скиноскоп» фирмы “ Menard” (Япония), ультразвуковое, рентгенологическое исследование, включая КТ, МРТ, и электронно-полевой интерференционной топической томографии (ГРВ), определение клеточного иммунитета, а

Таблица 1. Методы лечения больных меланомой кожи

Номер группы	Метод лечения	Количество больных	
		абс.	%
I	Хирургическое лечение + лучевая терапия	49	17,6
II	Хирургическое лечение + низкодозная иммунотерапия интерфероном-а (ИФа)	38	13,6
III	Хирургическое лечение (контрольная группа)	64	23,0
IV	Хирургическое лечение + высокодозная иммунотерапия интерфероном-а (ИФа)	37	13,3
V	Хирургическое лечение + низкодозная иммунотерапия интерфероном-а + полихимиотерапия (ПХТ)	47	16,9
VI	Хирургическое лечение + полихимиотерапия (ПХТ)	43	14,6
	Всего	278	100,0

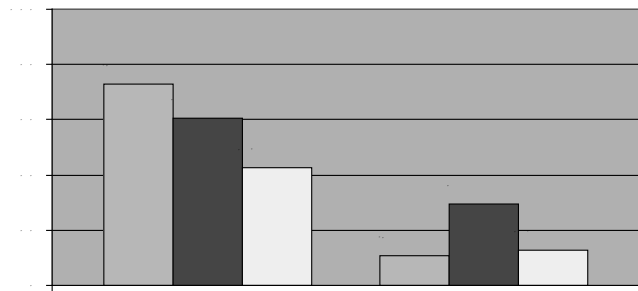


Рисунок 2. Сравнительные показатели 3-х и 5-летней выживаемости больных меланомы кожи с промежуточным и высоким риском метастазирования в зависимости от метода лечения. 3-летняя выживаемость ($x_2 = 8,0$) 5-летняя выживаемость ($x_2 = 6,4$)

именно СД3, СД4, СД8 и иммуно-регуляторного индекса СД4/СД8. Иммунологические исследования проводились до и после окончания каждого метода лечения, а в последующим через каждые 2 месяца в сроки до 4-5 лет.

Среди 278 больных меланомы кожи локализовались у 85 больных в туловище, у 127 – в верхней и нижней конечности, у 66 на голове и шеи. Локальная форма с местным распространением опухоли установлена у 151 (54,3%), локально-регионарная форма, т. е. наряду с первичным очагом имелись метастазы в регионарных лимфатических узлах – у 127 (45,7%) больных.

При локальной форме кожи распространенность опухоли, соответствующая T1-2 N0 M0 со степенью инвазии кожи I - II степени по Кларку было 104, T3-4 N0 M0 с инвазией кожи III-IV степени по Кларку 47 больных, а среди локально-регионарной формой – больных с распространенностью опухоли T3-4 N0 M0 с инвазией кожи по Кларку III степени – 28, IV степени – 46, а T3-4 N1 M0 с инвазией кожи IV – V степеней – 53 больных.

Методика исследования

В зависимости от примененного метода лечения больные были разделены на 6 групп (таблица №1).

Из таблицы № 1 следует, что всем 278 больным первоначально проводилось хирургическое лечение под общей внутривенной анестезией, линия разреза на туловище проходила отступая на 4-5 см от видимых краев опухоли, единым блоком с подкожной жировой клетчаткой и поверхностной фасцией. На голове и шее линия разреза уменьшалась до 3 см от края опухоли. У 7 пациентов при локализации опухоли на нижней конечности производилось широкое иссечение без наложения швов и рана велась открыто. После удаления основного очага проводилось гистологическое исследование с определением степени инвазии слоев кожи по Кларку.

В случае выявления увеличенных регионарных лимфатических узлов производилась регионарная лимфаденэктомия. Так, при поражении метастазами паховой области у 21 больного производилась операция Дюкена, при локализации первичной опухоли на верхних конечностях и туловище- 27 больным- аксиллярная лимфаденэктомия, на голове и шее 12 больным – операции Ванаха и типа Крайла.

При отсутствии пальпируемых лимфатических узлов в регионарной зоне у 19 больных при III-IV степени инвазии по Кларку проводилась профилактическая регионарная лимфаденэктомия.

В первую группу вошли 49 больных, получивших после хирургического лечения дистанционную гамма-терапию на место основного очага и в зону возможного регионарного метастазирования в РД по 2 Гр, до СОД 40 Гр на основной очаг, на регионарную область до 20 Гр.

Во вторую группу вошли 38 больных, которым после хирургического лечения проводилась низкодозная

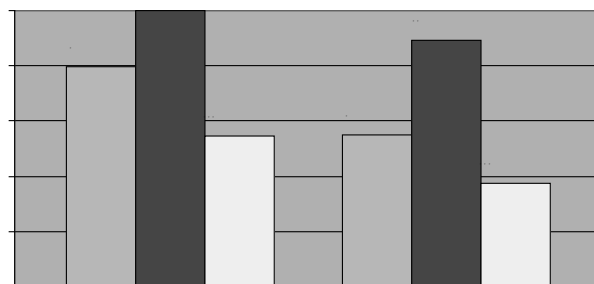


Рисунок 1. Сравнительные показатели 3-х и 5-летней выживаемости больных меланомы кожи с низким и промежуточным риском метастазирования в зависимости от метода лечения. 3-летняя выживаемость ($x_2 = 26,6$) 5-летняя выживаемость ($x_2 = 26,2$)

иммунотерпия интерфероном – альфа в дозе 3 млн МЕ внутривенно в ежедневном режиме до суммарной дозы 30 млн МЕ, с последующей поддерживающей интерферонотерапией по 3 млн МЕ однократно только при снижении иммунорегуляторного индекса СД4/ СД8 ниже 1,3.

В третьей группе 64 больным проводилось только хирургическое лечение.

Следует отметить, что в первых трех группах лечение проводилось у больных с низким и промежуточным риском развития метастазов в стадии T1N0M0, T2N0M0, T3N0M0.

В четвертую, пятую и шестую группы были включены 127 больных с меланомой кожи промежуточным и высоким риском развития метастазов, среди которых в четвертой группе 37 больным после хирургического лечения проводилась высокодозная иммунотерапия интерфероном альфа по 9 млн МЕ/м² внутривенно с интервалом 2 дня, всего 4 введения, в пятой группе 47 больным низкодозная иммунотерапия интерфероном альфа по 3 млн МЕ п/к до суммарной дозы 30 млн МЕ в сочетании с последующими 6 курсами полихимиотерапии по схеме дакарбазин 1400 мг и цисплатин 50 мг внутривенно, а в шестой группе 43 больным проводились 6 курсов полихимиотерапии дакарбазином по 1400 мг и цисплатином 50 мг с интервалом 21 день.

Непосредственные результаты лечения

Среди осложнений в процессе и после окончания хирургического лечения в комбинации с лучевой терапией отмечались невыраженная лейкопения, снижение показателей клеточного иммунитета на 30%, с низкодозной иммунотерапией интерфероном альфа почти у всех больных имел место гриппоподобный синдром, сопровождающийся повышением температуры тела и головной болью только при первом введении интерферона альфа, но это не послужило поводом для отказа от лечения. В последующем, при каждом введении его, указанный синдром уменьшался по интенсивности. Показатели клеточного иммунитета оставались в норме, а затем повышались более чем на 50% от исходного уровня, что сопровождалось улучшением общего состояния больного. Применение высокодозной иммунотерапии сопровождалось выраженными побочными эффектами – повышением температуры тела до 39-40°, сильными болями в голове, суставах, пояснице, повышением уровня АЛТ, АСТ, появлением белка в моче, что послужило поводом для остановки лечения у 29,6% больных.

При сочетанном применении низкодозной интерферонотерапии и полихимиотерапии с дакарбазином и цисплатином также наблюдался менее выраженный гриппоподобный синдром, а также тошнота, иногда рвота, кратковременная диарея и аллопеция. Однако, все эти симптомы после коррегирующей терапии уменьшились и все 47 больных полностью получили запланированный курс лечения.

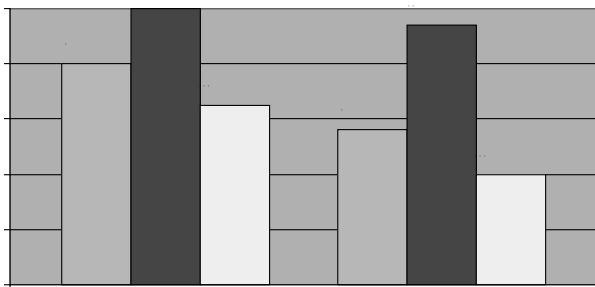


Рисунок 3. Сравнительные показатели 3-х и 5-летней выживаемости больных меланомы кожи с T1N0M0 в зависимости от метода лечения. 3-летняя выживаемость ($x_2 = 7,2$) 5-летняя выживаемость ($x_2 = 11,8$)

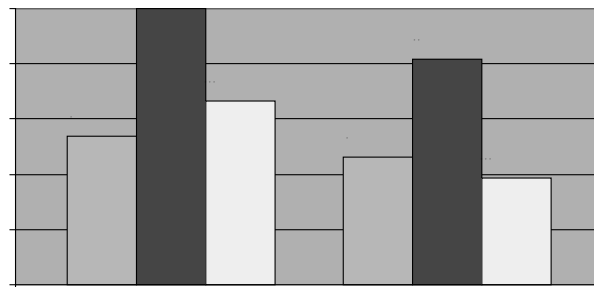


Рисунок 4. Сравнительные показатели 3-х и 5-летней выживаемости больных меланомы кожи с T2N0M0 в зависимости от метода лечения.

3-летняя выживаемость ($x_2 = 7,4$) 5-летняя выживаемость ($x_2 = 6,0$)

Отдаленные результаты лечения

Показатели 3-х и 5-летней выживаемости больных меланомой кожи, подвергавшихся различным методам лечения иллюстрируют рисунки № 1-6.

Данные рисунка №1 показывают, что при меланоме кожи с низким и промежуточным риском метастазирования наилучшие показатели 3-х и 5-летней выживаемости наблюдаются в группе больных, у которых после хирургического лечения применялась низкодозная иммунотерапия интерфероном альфа (3-х и 5-летняя выживаемость соответственно 100% и $89,4 \pm 5,0\%$, безрецидивный период $51,2 \pm 1,7$ мес.), тогда как при применении послеоперационной лучевой терапии эти показатели соответственно – $79,6 \pm 5,7\%$ и $55,1 \pm 7,1\%$, безрецидивный период $45,0 \pm 1,7$ мес., а в контрольной группе больных, подвергавшихся только хирургическому лечению – $55,6 \pm 6,2\%$ и $37,5 \pm 6,0\%$ соответственно, безрецидивный период $36,0 \pm 3,1$ мес.

Из рисунка № 2 следует, что при меланоме кожи с промежуточным и высоким риском метастазирования 3-х летняя выживаемость была выше среди больных, получивших хирургическое лечение в комбинации с высокодозной интерферонотерапией альфа ($73,0 \pm 7,3\%$), а у больных, которым после хирургического лечения проводились курсы низкодозной интерферотерапии в сочетании с полихимиотерапией 3-х летняя выживаемость = $60,4 \pm 7,5\%$, полихимиотерапии – $42,5 \pm 7,2\%$. Пятилетняя выживаемость заметно была выше в группе больных, получивших иммунотерапию в сочетании с полихимиотерапией $29,4 \pm 6,8\%$, безрецидивный период $20,6 \pm 2,5$ мес., а в группе больных, получивших только полихимиотерапию она была $12,8 \pm 6,7\%$, безрецидивный период $14,1 \pm 4,7$ мес.

При анализе 3-х и 5-летней выживаемости больных в зависимости от стадии распространенности опухоли выявлены следующие результаты.

При T1N1M0 (рис.3) среди трех методов лечения наиболее эффективным является комбинация хирургического лечения с низкодозной иммунотерапией, где 3-х и 5-летняя выживаемость составила 100% и $94,1 \pm 14,7\%$, $89,5 \pm 5,0\%$, медиана безрецидивного периода – $67,2 \pm 2,0$ мес., тогда как аналогичные показатели при применении адъювантной лучевой терапии составили $80,0 \pm 7,7\%$ и $56,0 \pm 10,0\%$, медиана безрецидивного периода $51,1 \pm 7,0$ мес., а после одного хирургического лечения соответственно $65,0 \pm 10,3\%$, $40,0 \pm 11,2\%$, медиана безрецидивного периода $39,8 \pm 3,4$ мес.

При T2N0M0 (рис. 4) наилучшие результаты были получены также при применении адъювантной низкодозной иммунотерапии, где 3-х и 5-летняя выживаемости составила 100% и $81,8 \pm 12,1\%$, медиана безрецидивного периода – $54,3 \pm 3,0$ мес, а в группах больных, которым проводились послеоперационная лучевая терапия и только хирургическое лечение существенное отличие 3-х и 5-летней выживаемости не получено, медиана безрецидивного

периода была соответственно $40,5 \pm 6,2$ мес. и $38,1 \pm 4,3$ мес.

При меланоме кожи в стадии T3-4N0M0 (рис. 5) наиболее высокие показатели 5-летней выживаемости наблюдались при сочетании хирургического лечения с низкодозной иммунотерапией – $80,0 \pm 8,9\%$, медиана безрецидивного периода составила $48,0 \pm 6,4$ мес., на последующих местах больные получивших адъювантный химио-иммунотерапии ($38,1 \pm 10,5\%$ с медианой безрецидивного периода $36,0 \pm 2,1$ мес.), высокодозной иммунотерапии ($34,6 \pm 9,1\%$, $30,0 \pm 3,2$ мес.), лучевой терапии ($27,2 \pm 13,1\%$, $28,1 \pm 6,1$ мес.), полихимиотерапии ($17,6 \pm 9,2\%$, $18,0 \pm 13,1$ мес.), только хирургическое лечение ($14,6 \pm 6,8\%$, $12,4 \pm 3,2$ мес.).

При поражении метастазами регионарных лимфатических узлов в стадии T3-4N1M0 (рис.6), где применялось комплексное лечение 3-х летняя выживаемость была лучше среди больных, получивших адъювантную высокодозную иммунотерапию $47,0 \pm 12,1\%$, а после адъювантной низкодозной иммунотерапии $42,9 \pm 10,8\%$, полихимиотерапии – $31,8 \pm 9,3\%$, а 5-летняя выживаемость была наилучшей среди больных, получивших адъювантную низкодозную иммунотерапию $38,1 \pm 10,5\%$ с медианой рецидивного периода $24,5 \pm 3,3$ мес, после высокодозной иммунотерапии – $17,6 \pm 9,2\%$ с медианой безрецидивного периода $15,8 \pm 2,1$ мес, полихимиотерапии – $13,6 \pm 7,3\%$ с медианой безрецидивного периода $10,7 \pm 3,2$ мес.

Следует отметить, что уровень клеточного иммунитета является важным прогностическим фактором при меланоме кожи. Нами выявлено, что у 19 пациентов с меланомой кожи, подвергавших только хирургическому лечению, отмечалось снижение количественных показатели клеточного иммунитета через месяц после лечение на $60,0 \pm 5,5\%$ от исходных показателей, среди 25 больных, которым применялось адъювантная низкодозная иммунотерапия, отмечалось повышение иммунорегуляторного индекса СД4/СД8 у большинства больных в 2 раза, через 6 месяцев этот индекс составил в среднем $1,5 \pm 0,2$ и сохранялись в течение длительного времени и ни у одного из 22 до конца прослеженных больных не был выявлен рецидив заболевания.

Проведение высокодозной иммунотерапии у 14 больных сопровождалось выраженным снижением СД4/СД8 индекса среди всех исследуемых нами методов противоопухолевого лечения.

Среди 21 больного через месяц после проведения полихимиотерапии после каждого курса лечения отмечалось снижение СД4/СД8 индекса на $10,0 \pm 6,2\%$ от исходного уровня.

Нами выявлено, что при снижении иммуномодуляторного индекса ниже 1,3 чаще наступает рецидив заболевания. Поэтому использование контроля клеточного иммунитета с помощью СД4/СД8 индекса с последующей коррекцией его восстановления до нормы позволяет проводить поддерживающую иммунотерапию низкими дозами интерферона-а не еженедельно в течение 1,5-2 лет, а только при снижении

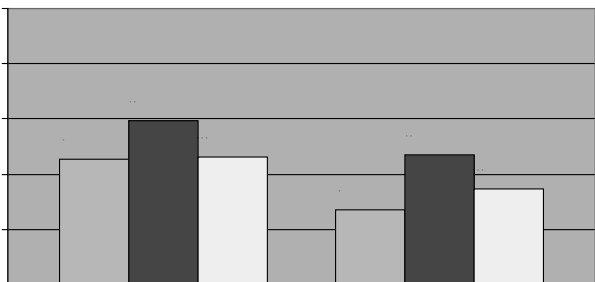


Рисунок 5. Сравнительные показатели 3-х и 5 – и летней выживаемости больных меланомы кожи Т3-4N0M0 в зависимости от метода лечения. 3-летняя выживаемость (x2 =13,9) 5-летняя выживаемость (x2 =7,4)

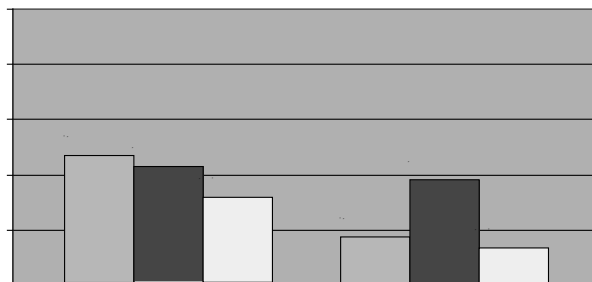


Рисунок 6. Сравнительные показатели 3-х и 5 – и летней выживаемости больных меланомы кожи Т3-4N1M0 в зависимости от метода лечения. 3-летняя выживаемость (x2 =1,0) 5-летняя выживаемость (x2 =4,0)

CD4/CD8 ниже 1,3 и после восстановления его до нормы остановить терапию и систематически проводить контроль за состоянием клеточного иммунитета. Данная методика позволяет без ущерба для больного экономить финансовые затраты почти в 10 раз, при хорошем качестве жизни больных.

Выводы

1. Послеоперационная лучевая терапия улучшает выживаемости больных меланомой кожи только при T1N0M0, а при поражении глубоких слоев кожи (T2-4) она не улучшает результаты хирургического лечения.
2. При локальной форме меланоме кожи с низким T1-2N0M0 и промежуточным риском метастазирования (T3-4N0M0) наиболее эффективным методом лечения является применение после хирургического лечения низкодозной иммунотерапии интерфероном-а (3 млн. МЕ п/к № 10), которая обладает иммуностимулирующим эффектом, а последующие инъекции иммунопрепарата осуществлять не постоянно, а только при снижении иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 ниже 1,3, что статистически увеличивает 3-х и 5-летнюю выживаемость больных по сравнению с примененными нами другими методами лечения, повышая качество жизни пролеченных больных.
3. При локально-регионарной форме меланомы кожи (T3-4N0M0) с высоким риском метастазирования наиболее эффективным методом лечения является применение адъювантной низкодозной иммунотерапии интерфероном-а в сочетании с дакарбазином и цисплатином или только высокодозной интерферонотерапии. Однако использования высоких доз интерферона-а (9 млн. МЕ/м²) сопровождается выраженными побочными эффектами, что послужило причиной остановки почти у 1/3 больных, начавших лечение. Особенно его трудно переносят больные пожилого возраста, а также имеющие тяжелые сопутствующие заболевания.
4. При наличии метастазов в регионарных лимфатических узлах нами примененные методы оказались малоэффективными, что требует дальнейшего совершенствования комплексных методов лечения.

Список использованной литературы

1. Анисимов В.В. – Меланома кожи (перспективы улучшения диагностики и лечения). Автореф. дисс... докт. мед. наук. - СПб, 2000. - С. 97
2. Барчук А.С. – Хирургическое лечение меланом. //Практическая онкология: избранные лекции под. редак. С.А. Тюлядина и В.В. Моисеенко. - СПб: Центр ТООМ, 2004. -С. 555-564.
3. Демидов Л.В., Харкевич Т.Ю. Адъювантное лечение больных меланомой кожи. //Практическая онкология: избранные лекции. под. ред. С.А. Тюлядина и В.В. Моисеенко. - СПб: Центр ТООМ,

2004. - С. 573-583.

4. Кудряцев Д.В., Кудрявцева Г.Т., Мардынский Ю.С. Адъювантная химиотерапия как компонент комплексного лечения меланомы кожи //Вопросы онкологии., 2008, I том 54, №2 с. 170-177.
5. Кудряцев Д.В. Факторы прогноза и отдаленные результаты комбинированного и комплексного лечения меланомы кожи. Автореф. дисс.. д.м.н., Обнинск, 2009
6. Носов Д.А. Лекарственное лечение диссеминированной меланомы. //Практическая онкология: избранные лекции. под. ред. С.А. Тюлядина и В.В. Моисеенко, «Центр ТООМ» СПб, 2004 с. 584-594.
7. Пак Д.Д., Лазутина Т.Н. Меланома. В руководстве «Онкология» (национальное руководство), под. ред. В.И. Чиссова и М. И. Давыдова. Москва, «ГЭ ОТАР-Медиа», 2008 с 848-862.
8. Переводчикова Н.И. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Москва, 2005 с. 698
9. Фрадкин С.В., Залуцкий И.В. Меланома кожи. Минск, 2000. - 221.
10. Atkins M.B., Lotze M.T., Dutcher J.P. et al. High-dose recombinant interleukin-2 therapy for patients with metastatic melanoma: Analysis of 270 patients treated between 1985 and 1993 // J. Oncol. - 1999. - vol. 17. - P. 205-216.
11. Balch C.M., Soong S.J., Smith T. et. al. Long-term results of a prospective surgical trial comparing 2 cm vs. 4 cm excision margins of 740 patients with 1-4 mm melanomas. Ann. Surg. Oncol., 2001; Vol. 8, p. 101-108.
12. Bath C. M., Soong S.J., Milton G. W. et al. A comparison of prognostic factors and surgical results in 1786 patients localized (stage I) melanoma treated in Alabama, USA and New South Wales, Australia //Ann. Surg. - 2001. - Vol 193. - P. 377-388.
13. Casinelli N., Burfalino R., Morabito A. et al. Results of adjuvant interferon study in WHO melanoma programme // Lancet. - 1994 Vol. 343, p. 913-914.
14. Eggermont A.M. Strategy of the EORTC-MCG trial programme for adjuvant treatment of moderate – risk and high-risk melanoma. / Europ. J. Cancer, 1998. Vol. 34, p.822-826.
15. Grob J.J., Dreno D., de la Salmoniere P. et. al. Randomized trial in interferon-a 2a as adjuvant therapy in resected primary melanoma thicker than 1,5mm without clinically detectable node metastasis. / Lancet, 1998 Vol. 351 p. 1905-1910.
- 16/ Keilholz V., Cornelis J. Gore M. et. al. Dacarbazine, cisplatin and carmustine, with or without IL-2 advanced melanoma: interim analysis of EORTC trial 18951. // Proc. ASCO, 1999, Vol. 18 – Abstr. 2043
17. Kirkwood J.M., Ibrahim J.G., Sondak V.K. et al. High and low-dose interferon alfa-2b in high-risk melanoma: first analysis of intergroup trial E 1690/s 9111/c 9190 / J. Clin. Oncol, 2000. v.18. p. 2444-2459.
18. Legha S.S. Role of interferon A in the Treatment of metastatic melanoma. //Semin/ Onol, 1997, Vol. 24, No. 1 (supht. 4) p. 24-31
19. Rosenberg S., Yang J., Sehawartzentruber D. et. al. Prospective randomized trial of the treatment of patients with metastatic melanoma using chemotherapy. With cisplatin, dacarbazine, and tamoxifen alone or in combination with IL -2 and interferon-a-2b. J. Clin Oncol, 1999. v. 17.p. 968-975

Лечение опухолей глаза и орбиты

Ажигалиева М.Н.

Казахский НИИ глазных болезней

Көз және көзұясы ісіктерін емдеу

Әжигалиева М.Н.

Мақсаты – көз және көзұясы ісіктерін емдеудегі электронды терапия рөлін анықтау.

Мәліметтермен әдістер: Көз және көзұясы ісіктерімен ауырған 17 науқастарды емдеу қорытындылары анықталды.

Қорытынды. Электронды терапия жүргізілгеннен кейінгі жекеленген қорытындылардың көрсеткіші, 17 науқастың 3 жылдан кейін 12 тірі қалды, 4 өлді, бір науқастан хабар жоқ. Тексеру барысында, III және IV сатыдағы науқастар арасында өліл-жітімнің болғандығы анықталды. Біріктірілген емдеу әдісінде емнің әсер ету пайызы емдеуге дейінгі ісіктің таралуы мен аурудың сатысына байланысты болғаны байқалды. Егер ем неғұрлым ерте кезеңде жүргізілсе, емделу пайызы жоғары болды. Емдеуден бұрын ісік көз алмасының шеңберінен асып кеткен болса, емдеу пайызы аз болды. Тікелей қанағаттанарлық және жақын арадағы қорытындылар бізге әсіресе мынадай оқиғаларда, ісік көз шеңберінен асып таралып кеткен жағдайларда жылдам электрондарды қолдануға нұсқау бергізді.

Treatment Of Eye And Orbit Tumours

Goel – study the vole of electronic therapy in the treatment of eye and orbit tumours.

Material and methods: The results of treatment of 17 patients vith eye and orbit tumours have been studied. The lomg-term results of the treatment were studied following electronic therapy conducted.

Results. The study of lomg-term results of conducted electronic therapy showef that after 3 years, 12 out of 17 patients survive, 4 died, theve is no data on one patient.

Accordigly, the lethali'ty was noted amory patients mith the III and IV stsge.

Цель – изучить роль электронной терапии в лечении опухолей глаз и орбиты.

Материал и методы: Изучены результаты лечения 17 больных опухолями глаз и орбиты. Изучены отдаленные результаты лечения после проведенной электронной терапии.

Результаты. Изучение отдаленных результатов после проведенной электронной терапии показало, что из 17 больных через 3 года живы 12, умерло 4, нет сведений об одном больном. Следовательно, летальность среди больных отмечалась у больных с III и IV стадиями. При комбинированном методе лечения выявляется зависимость процента излечения от степени распространенности опухоли к моменту лечения. Если лечение проводилось в более ранние сроки, процент излечения был высоким. При лечении в период, когда опухоль вышла за пределы глазного яблока, процент излечения был меньше. Удовлетворительные непосредственные и ближайшие результаты позволяют нам рекомендовать применение быстрых электронов, особенно в тех случаях, когда имеет место прораствание опухоли за пределы глаза.

Wherever a combined treatment method is applied, the correlation Between the percentage of cured and the degree of tumour spread.

If the treatment was conducted at the earlier stage, the percetage of successful treatment was high. When the treatment was conducted Where the tumour spread outside of the eyeball boundanes, the percentage of those, cuved was lower.

Satisfactory, comprehensive and neavest results allow us to recommend the application of rapid electrons, particulany in cases, where the growth of the human outside eye bounding has taken place.

Актуальность

Анализ результатов лечения внутриглазных опухолей показал, что кроме хирургического лечения необходимо дополнительно использовать электронную терапию, как в начальных, поздних стадиях заболевания.

В начальных клинических стадиях заболевания показано оперативное вмешательство. По данным литературы, при запущенных стадиях послеоперационная летальность достигает 90% и более. Поэтому многие авторы рекомендуют комбинированное лечение, при котором результаты получаются лучше, чем при хирургическом методе.

В последние годы в связи с появлением новых источников излучения открылись новые перспективы в лечении опухолей глаза и орбиты. Обычно в офтальмологической практике применяется классическая рентгенотерапия с двух полей – переднего и бокового. При таком облучении в зону максимальной дозы включается не только опухоль, но и нормальные ткани глаза: 20-25% дозы поглощаются в соседнем глазе, а 20-30% ее падают на ближайшие отделы головного мозга. В то же время такое облучение опухоли оказывается недостаточно эффективным.

Другим распространенным методом лечения является лучевая терапия. Литературные данные об этом противоречивы. До настоящего времени нерешенным остается вопрос о целесообразности применения лучевой терапии после хирургического вмешательства. При опухолях орбиты применяются радиевые аппликаторы, рентгеновское и гамма-облучение, сочетанная лучевая терапия. Однако, при всех этих методах результаты оказались неутешительными. С усовершенствованием техники лучевой терапии они несколько улучшились.

Лучевая терапия при опухолях орбиты в настоящее время получила распространение в некоторых зарубежных клиниках в связи с применением электронной терапии. При лечении опухолей орбиты она позволяет обеспечить наиболее оптимальное дозное распределение поглощенной энергии с высоким градиентом между здоровыми тканями и опухолью. Однако с клинических позиций возникает много сложностей, потому что нередко лечению подвергаются больные с единственным глазом, способным видеть. Трудности облучения глаза связаны с большой лучевой нагрузкой, повреждением глаза, развитием блефарита, катаракты,

вторичной глаукомы, гиперемии дна (включая сосок) с кровоизлиянием и частичной отслойкой сетчатки и значительной потерей зрения. Иногда возникают изъязвления роговицы.

Цель

– изучить роль электронной терапии в лечении опухолей глаз и орбиты.

Материал и методы

Исследования проведены у 17 больных с морфологически верифицированными опухолями глаза и орбиты (плоскоклеточный рак – у 8 пациентов, ретинобластома – у 5, аденокарцинома – у 2, эозинофильная гранулема – у 2 пациентов). Терапия быстрыми электронами с энергией 1% МЭв показала, что 80% изодозы электронного пучка зависит от размеров полей и достигают глубины 4–4,5 см, а 10% падают на глубину не более 7 см. Эти глубины считаются наиболее выгодными при лучевом лечении глаз. Количество и размеры полей выбирались индивидуально в зависимости от локализации и распространенности процесса. Облучение проводилось по 2 Гр ежедневно или по 4 Гр через день при мощности дозы 35–40 рад/мин. Общая суммарная доза доводилась в зависимости от характера опухоли.

Результаты

Изучение отдаленных результатов после проведенной электронной терапии показало, что из 17 больных через 3 года живы 12, умерло 4, нет сведений об одном больном. Следовательно, летальность среди больных отмечалась у больных с Ш и 1У стадиями. При комбинированном методе лечения выявляется зависимость процента излечения от степени распространенности опухоли к моменту лечения. Если лечение проводилось в более ранние сроки, процент излечения был высоким. При лечении в период, когда опухоль вышла за пределы глазного яблока, процент излечения был меньше. Удовлетворительные непосредственные и ближайшие результаты позволяют нам рекомендовать применение быстрых электронов, особенно в тех случаях, когда имеет место прорастание опухоли за пределы глаза.

Комбинированное лечение с хирургическим вмешательством сделано 35 больным в виде пред- и послеоперационного облучения. Лечение в основном подвергались больные с запущенным процессом.

Лечение опухолей глаза до сих пор остается трудной и далеко не решенной задачей клинической офтальмологии. Это объясняется сложными анатомическими особенностями органа, разнообразием гистологической структуры опухолей и различной степенью их злокачественности. Наиболее распространенным методом лечения является хирургическое вмешательство, однако оно во многих случаях не спасает больных от генерализации опухолевого процесса. Химиотерапия в основном используется в плане комплексного лечения.

Многие авторы признают наиболее рациональным методом лечения лучевую терапию или ее сочетание с операцией. Благодаря лучевой терапии во многих случаях удавалось перевести процесс из неоперабельного состояния в операбельное или уничтожить остаточные опухолевые элементы после проведенной операции.

Облучение опухолей у детей в возрасте до 3–4 лет представляло большие трудности, поэтому оно проводилось во время физиологического сна. Когда это не удавалось, пользовались наркозом.

Объем хирургического вмешательства зависит от характера и распространенности процесса – экзеклеации или экзентерации глаза. При двустороннем поражении удаляется тот

глаз, в котором процесс развит сильнее, а второй глаз подвергается облучению.

Результаты. Изучение отдаленных результатов после проведенной электронной терапии показало, что из 17 больных через 3 года живы 12, умерло 4, нет сведений об одном больном. Следовательно, летальность среди больных отмечалась у больных с Ш и 1У стадиями. При комбинированном методе лечения выявляется зависимость процента излечения от степени распространенности опухоли к моменту лечения. Если лечение проводилось в более ранние сроки, процент излечения был высоким. При лечении в период, когда опухоль вышла за пределы глазного яблока, процент излечения был меньше. Удовлетворительные непосредственные и ближайшие результаты позволяют нам рекомендовать применение быстрых электронов, особенно в тех случаях, когда имеет место прорастание опухоли за пределы глаза. Распределение дозы электронного пучка при облучении ретробульбарной опухоли показано на рисунке 1.

Следует отметить, что для обеспечения абластичности и радикальности хирургического вмешательства мы считали целесообразным проводить предоперационное облучение. Девитализация опухолевых клеток после облучения дает возможность обеспечить выполнение онкологического принципа радикального лечения.

Техника облучения опухоли глаз осложняется тем, что необходимо сохранять зрение. Кроме того, нужно полностью избежать облучения головного мозга. В связи с этим выбор условий облучения должен быть индивидуальным.

У больных, подвергавшихся электронной терапии, локализация процесса была следующей: 1) опухоль внутри глаза, 2) опухоль в ретробульбарном пространстве. 3) анофтальм после удаления внутриглазной опухоли, 4) состояние после экзентерации глазницы. В каждом конкретном случае индивидуально планировались условия облучения. Облучение проводилось с одного переднего орбитального поля или с двух взаимоперпендикулярных полей (орбитального и височного).

Успех лучевой терапии орбиты, помимо характера и распространенности процесса, в значительной мере определяется правильным выбором метода и условий облучения, позволяющих подвести к опухоли необходимую дозу за курс лечения при минимальном облучении окружающих тканей.

Учитывая изодозное распределение электронного пучка, мы применяли электроны 66 больным с опухолями глаза и орбиты. Большинство больных, находились в клинике Казахского НИИ глазных болезней. Облучение проводилось после совместного осмотра окулиста и онкорадиолога.

Электронная терапия имеет преимущества перед рентгеновским и гамма-излучением. Они заключаются в резком спаде дозы за очагом поражения, гомогенном распределении ее до определенной глубины проникновения электронов зависит от энергии генерирования. Это побудило нас детально изучить особенности применения быстрых электронов при лечении опухолей глаз и орбиты. Прежде всего необходимо было выяснить дозное распределение энергии излучения при электронной терапии патологических очагов, расположенных в глазном яблоке и орбите и разработать методику их лечения. Облучение быстрыми электронами мы проводили с помощью специальных тубусов.

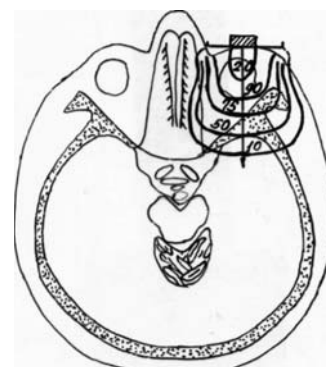


Рисунок 1. Дозное распределение при облучении ретробульбарной опухоли электронным пучком с применением свинцового поглотителя

Миома матки, железистая гиперплазия эндометрия и нейроэндокринные нарушения — факторы риска развития рака эндометрия

Аликулова У.А.

Жамбылский областной онкодиспансер

Актуальность

Среди злокачественных опухолей органов репродуктивной системы у женщин наиболее высока заболеваемость раком молочной железы, шейки матки, тела матки и яичников. Рак молочной железы в последние годы в ряде развитых стран вышел на первое место среди злокачественных опухолей у женщин. В течении последнего десятилетия отмечается отчетливая тенденция снижения заболеваемости инвазивным раком шейки матки (РШМ), что объясняется широким применением профилактических осмотров и цитологического скрининга с последующим лечением дисплазии преинвазивного рака. Это является надежной профилактикой развития инвазивного рака шейки матки. В 1970 г. в СССР впервые зарегистрировано 32782 больных РШМ (25,1 на 100 000 женщин), в 1980 г. - 29539 (20,8 на 100 000), а в 2009 году по РК - 8,5%000.

Цель работы

— определение частоты заболеваемости раком эндометрия среди больных миомой матки, гиперплазией эндометрия и нейроэндокринными нарушениями.

Материал и методы

Обработаны данные всехзарегистрированных больных. Проведен ретроспективный анализ 46 историй болезней больных с диагнозом рак эндометрия

Результаты

Одновременно со снижением заболеваемости РШМ нарастает заболеваемость раком тела матки (РТМ). В 1970г. в СССР было впервые зарегистрировано 8419 больных РТМ (6,4 на 100 000 женщин), а в 1980г. - 13962 (9,8 на 100 000). К началу 90-х годов в СССР рак тела матки «перегонит» рак шейки матки. (В. М. Мерабишвили, 1986). В 1990-1995гг. странах СНГ заболеваемость РТМ колеблется от 4,0-5,2%000 (в республиках Средней Азии) до 8-14,7%000 (в России, Молдаве, Казахстане, Беларуси). Показатели заболеваемости РТМ были высокими в 2000 году - 12,2%000, последующие годы они остаются почти на одном уровне. В 2009 году по РК было зарегистрировано 811случай РТМ, заболеваемость составила - 5,6%000, в течении последних 5 лет она была стабильной.

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями по РК РТМ в 2009 году находится на 10 ранговом месте, среди женщин - на 6-ом месте, а по гениталия - на 2 месте, составляя - 5,6 % 000. По Жамбылской области зарегистрировано 25 случаев РТМ, среди злокачественных новообразований на 12 ранговом месте, по гениталия - на 3 месте, заболеваемость составила - 3,2 %000.

Общая тенденция заболеваемости раком органов репродуктивной системы у женщин - это увеличение числа гормонозависимых опухолей. В основе этой тенденции нахо-

Жатыр миомасы, Бездік гиперплазия ээдометрич және нейроэндокринді бұзылу ө эндометрич регіне қаупті факторлар

Аликулова У.А.

Өткен уақыттағы 2007-2009 жылдардағы диагнозы эндометрия регі болған 46 аурулар тарихына талдау жасалды. Жамбыл облыстық онкология диспансерінде емделген 34 пен 81 жас аралығында. Олардың 31 пациенттері эндометрия рагі жатыр миомасына-сымен үлескен, бездік гиперплазия эндометрия және нейроэндокринді бұзылу.

дится существенное увеличение в популяции эндокринно-обменных нарушений, присущих болезням цивилизации, как ановуляция, гиперэстрогения, бесплодие, ожирение, сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Существенная роль обменно-эндокринных нарушений в организме обуславливает развитие гиперпластических процессов, а также возникновение на этом фоне неопластической трансформации (этиологию и патогенез гормонозависимых опухолей органов репродуктивной системы можно представить в виде треугольника, одна сторона которого эндокринно-обменные нарушения, вторая-генетические факторы, а третья-канцерогенные воздействия, реализующие на фоне первых двух).

К группе повышенного риска наряду с женщинами страдающими нейро-эндокринными нарушениями, рецидивирующими гиперпластическими процессами эндометрия, отнесены также больные миомой матки.

Научными работами последних лет доказана возможность развития рака эндометрия, так и миомы матки в соответствии с двумя патогенетическими вариантами. У 60-70% больных раком эндометрия имеют место предшествующие или сопутствующие нейроэндокринные нарушения, являющиеся следствием ановуляции и гипоталамо-гипофизарной дисфункции. У 30-40 % больных таких нарушений выявить не удается. У 10-60% РТМ сочетается с фибромиомой матки, ЖГЭ и НЭН.

С наступлением менопаузы миома матки часто подвергается обратному развитию. Это обуславливает снижение онкологической настороженности и пассивную врачебную тактику по отношению к женщинам с мало- и бессимптомными миомами в пре-, пери-, постменопаузальных возрастных периодах.

Также РЭ, как правило, развивается в небольших по размерам миоматозных матках со стертой симптоматикой, неправильной тактикой лечения ЖГЭ.

Все изложенное позволяет заключить, что нарушение в репродуктивном и энергетическом гомеостазах могут играть ключевую роль в создании условий для развития гиперпластических состояний и рака эндометрия и служит

Таблица 1. Распределение больных по возрастным группам

Диагноз	Возраст обследованных больных (лет)											
	30-40		41-50		51-60		61-70		71 и более		Всего	
РЭ	2	4,3%	8	17,3%	15	32,6%	12	26%	9	19,5%	46	100%
РЭ в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН.	1	3,2%	3	9,6%	12	38,7%	9	29%	6	19,3%	31	100%

Таблица 2. Распределение больных раком эндометрия в зависимости от морфологической структуры опухоли.

Морфологическая структура опухоли	Всего больных		Рак эндометрия		Рак эндометрия в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН.	
	Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
Высокодифференцированная аденокарцинома	25	55,5	8	66,6	17	51,5
Умереннодифференцированная аденокарцинома	9	20,0	2	16,6	7	21,2
Низкодифференцированная аденокарцинома и недифференцированная аденокарцинома	8	17,7	2	16,6	6	18,1
Выраженная дисплазия по типу <i>ca in situ</i> , атипическая гиперплазия с малигнизацией	3	6,6	0	0	3	9,0

Таблица 3. Распределение больных в зависимости от стадии заболевания

Стадия рака эндометрия	Рак эндометрия		РЭ в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН.	
	Абс. число	%	Абс. число	%
I	27	58,6	19	59,3
II	9	19,5	7	21,8
III	7	15,2	3	9,3
IV	0	0	0	0
Ca in situ	3	6,5	3	9,3

факторами риска развития данного вида новообразования. Поэтому активное выявление предраковых процессов путем обследования групп риска больных с нейроэндокринными нарушениями и миомой матки сможет предотвратить развитие рака эндометрия у данного контингента.

Проведен ретроспективный анализ 46 историй болезни больных с диагнозом рак эндометрия, обследованных и получивших лечение в отделении онкогинекологии Жамбылского областного онкодиспансера за период 2007-2009 г. Возраст больных колеблется от 34 до 81 лет.

В результате исследования установлено, что среди больных РЭ в 31 (67,3%) случаев сочетался с миомой матки, ЖГЭ и НЭН, т. е. у каждого второго больного. Наибольший процент рака сочетания с миомой матки, ЖГЭ и НЭН (12 случаев-38,7%) пришелся на возрастную группу от 51-60 лет. У больных раком эндометрия основная возрастная группа соответствовала также 51-60 лет (15 случаев-32,6%), 61-70 лет (12 случаев-26,0%).

Исследования показали, что у женщин в возрасте 51-70 лет рак эндометрия в сочетании с миомой матки, ЖГЭ, НЭН и с раком эндометрия имеет тенденцию к росту в возрасте от 51 лет и выше (таблица №1).

При сравнительной характеристике морфологической структуры у исследованных больных были выявлены следующие особенности опухолей. В группе больных РЭ в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН высокодифференцированная аденокарцинома встречалась у 17 (51,5%) пациенток; умереннодифференцированная у 7 (21,2%), а у низко- и недифференцированная аденокарцинома отмечалась у 6 (18,1%) женщин.

В группе больных раком эндометрия у 25(55,5%) отмечена высокодифференцированная аденокарцинома, у 9(20,0%) умереннодифференцированная, а низко- и недифференцированная аденокарцинома у 8(17,7%) больных.

Частота высокодифференцированной аденокарци-

номы в группе больных раком эндометрия в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН оказалась выше на 51,5% (таблица №2).

У больных раком эндометрия в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН с 0 стадией заболевания встречалась у 3 (6,5%) больных, I стадия у 19 (59,3%) больных, II стадия у 7 (21,8%) больных, III стадия у 3 (9,3%) больных, IV стадия - 0 (0%).

Из 46 больных раком эндометрия 0 стадия наблюдались в 3 (6,5%)

случаях, I стадия в 27 (58,6%) случаях, II стадия в 9 (19,5%), III стадия в 7 (15,2%), IV стадия в 0 (таблица 3).

Таким образом в нашем исследовании высокая выявляемость с ранними стадиями рака эндометрия 0 стадии 3(6,5%), I-стадии 27(58,6%) и в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН 0-стадии 3(9,3%), I-стадии 19(59,3%), что связано с наличием ранней клинической симптоматики.

Всем больным проводилось специальное лечение с учетом стадии заболевания и морфологической структуры опухоли: хирургическое в объеме экстирпация матки с придатками, расширенная экстирпация матки, комбинированное-хирургическое+лучевое +гормонотерапия, сочетано лучевая+гормонотерапия при противопоказании оперативного лечения.

Таким образом, полученные нами данные еще раз подтверждают, что многие факторы риска развития рака эндометрия, ЖГЭ идентичны и обусловлены единым патогенезом. Поэтому больные миомой матки, особенно в сочетании с нейроэндокринными заболеваниями, т. е. заболеваниями цивилизации, должны относиться к группе риска по возникновению рака эндометрия.

Выводы

Улучшение диагностики и снижение заболеваемости раком эндометрия возможна лишь при отборе групп риска и патогенетическом лечении выявленных фоновых и предраковых процессах тела матки.

Необходимо, чтобы больные миомой матки, особенно старше 40 лет проходили ежегодное обследование с целью активного раннего выявления предраковых состояний и рака эндометрия, не ограничиваясь динамическим диспансерным наблюдением.

Целесообразно активное динамическое наблюдение за женщинами с различными нейроэндокринными нарушениями, такими как ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, входящими в группу риска по развитию неопластических процессов женской половой сферы.

Список литературы

1. Бохман Я. В. Руководство по онкогинекологии.-М., 1989.-464с.
2. Мезинова Н. Н., Патрушева А. С. Диагностика предрака и рака эндометрия у больных миомой матки в пре- и постменопаузе // Акушерство и гинекология.-1985.-№11. -С.30-32.
3. Вихляева Е. М. Руководство по эндокринной гинекологии.-М., 2000.-С. 424-487.
4. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. Показатели онкологической службы РК за 2006- 2009 годы (статистические материалы).-Алматы, 2006-2009 годы.

Опыт применения препарата Бортезомиб у пациентов с множественной миеломой в Павлодарской области

Сейсенбекова Ж.Б.

Павлодарская областная больница им. Г.Султанова, Павлодар

ВМР алған аурулардың қауіпсіздігі МР аурулардың қауіпсіздігіне сай келді:

Нейтропенияның үшінші сатыдағы жиілігі екі топта да бірдей болды;

Тромбоцитопенияның үшінші сатыдағы жиілігі ВМР тобында жиі болды;

ВМР емін алған 15% ауруларда перифериялық нейтропатияның ІІІ сатысы байқалды; көпшілік ауруларда қайталану түрі болды, 50 күн аралығында жақсару 75% болды;

МР алынған 2 ауруда рецидив байқалды.

Біздің байқауымыз бойынша, ВМР емін қолдану МР еміне қарағанда тиімді екенің көрсетеді. Химиялық терапияны бортезомиб аврқылы іске асыру ММ ауруын емдеуде бүгінгі таңда ең таңдаулы деп саналады және өзінің емдеуде ең тиімді екенің дәлелдейді.

Results and conclusions-from February 2009 to February 2010 a combination of bortezomib with melphalan and prednisone (VMP) was used with four patients aged 63 - 65 years (men and women equally). They had achieved complete remission. In the same period of time other four patients aged 63-65 years were treated with MRI protocol . These patients had not achieved complete remissions , achieved only partial. Subsequent two patients relapsed. The safety profile of patients receiving VMP matched the known safety profile of MR:

The frequency of the third degree of neutropenia was same in both groups; The frequency of the third degree of thrombocytopenia was higher in the VMP;

- Peripheral neuropathy of the third degree was observed in 15% of patients treated with VMP, it was reversible with most patients, improvement was noted in 75% within 50 days;

- Recurrence developed in 2 patients receiving MR.

Thus, according to our observation, the VMP treatment greatly exceeds MR. These data suggest that chemotherapy in combination with bortezomib is currently the therapy of choice of patients with MM and it proves its effectiveness.

Актуальность

Несмотря на наличие современных методов лечения, 75% пациентов с множественной миеломой в нашей республике получают традиционные схемы химиотерапии и только 25% пациентов - терапию бортезомибом первой и второй линии. Используя традиционную схему химиотерапии МР (мелфалан+преднизолон) удается получить положительный ответ в 50% случаях, а достичь полных ремиссий только в 5%.

Цель работы

— доказать эффективность использования препарата нового поколения бортезомиба в лечении больных множественной миеломой.

Материалы и методы

8 больных (4 мужчин и 4 женщины) в возрасте от 46 до 70 лет, с подтвержденным диагнозом множественной миеломой на основании общепринятых диагностических критериев.

Протоколы химиотерапии: МР (мелфалан 9 мг/м² + преднизолон 60 мг/м² с 1-4 дни курса) и бортезомиб в комбинации с МР (бортезомиб в дозировке 1,3 мг/м² два раза в неделю в 1,2,4,5 дни недели в рамках четырех шестинедельных циклов (по восемь на цикл) в комбинации с мелфаланом в дозировке 9 мг/м² и преднизолоном по 60 мг/ м² 1 раз в сутки в 1-4 дни каждого цикла).

Результаты

С февраля 2009 года по февраль 2010 года применили комбинацию бортезомиба с мелфаланом и преднизолоном (VMP) у четырех пациентов в возрасте 63- 65 лет (мужчин и женщин поровну). У них достигнута полная ремиссия.

Параллельно в этот же период проводилось лечение по протоколу МР четырьмя пациентам в возрасте 63-65 лет. У данных пациентов полных ремиссий не отмечено, достигнуты только частичные, в последующем у двух пациентов развился рецидив.

Профиль безопасности у пациентов, получавших VMP, соответствовал известным профилям безопасности МР:

- частота нейтропении третьей степени была одинакова в обеих группах;
- частота тромбоцитопении третьей степени была выше в группе VMP;
- периферическая нейропатия третьей степени наблюдалась у 15% пациентов получавших VMP, она имела обратимый характер у большинства пациентов; улучшение отмечено у 75 % в течении 50 дней;
- рецидив развился у 2-х пациентов получивших МР.

Таким образом, по нашему наблюдению, лечение VMP значительно превосходит МР. Эти данные позволяют утверждать, что химиотерапия в сочетании с бортезомибом на сегодняшний день является терапией выбора у больных с ММ и доказывает свою эффективность.

Альтернативные методы предупреждения осложнений хирургического лечения туберкулеза легких

Зетов А.Ш.

Национальный центр проблем туберкулеза, г.Алматы

При хирургическом лечении туберкулеза легких многие известные виды дополнительной герметизации культи усеченного бронха не всегда решают проблему развития ее несостоятельности. [1, 2,].

В Национальном центре проблем туберкулеза с 1999 года стали применять адсорбирующее раневое покрытие Тахокомба компании «Никомед» при операциях на легких. В отделении легочной хирургии пластина Тахокомба использована у 30 пациентов. У 3 (10,0%) пациентов был туберкулезный процесс в виде туберкулем, у 24 (80,0%) был фиброзно-кавернозный туберкулез легких. У остальных 3 (10,0%) больных была пострезекционная эмпиема плевры плевры с бронхиальными свищами.

Бактериовыделителей было 16 (53,3%), из них у 8 (26,6%) выявлена полирезистентность к противотуберкулезным препаратам первого ряда. Больным произведено 30 оперативных вмешательств, из них прецизионных резекций – 3 (10,0%), сегментарных резекций – 5 (16,6%), лобэктомий – 5 (16,6%), пневмонэктомий – 10 (33,3%), трансстернальных трансперикардиальных окклюзий главного бронха – 4 (13,3%), окклюзий главного бронха из контрлатерального доступа – 2 (6,7%), а пластика бронхиального свища была выполнена 1 (3,3%) пациентке.

Из 30 больных, которым для дополнительной герметизации культи было применено адсорбирующее раневое покрытие Тахокомб, эффективность хирургического лечения достигнута у 28 (93,3%). У 2 (6,7%) больных, перенесших трансстернальную трансперикардиальную окклюзию главного бронха с дополнительной герметизацией центрального и периферического концов бронха, в сроки 7 и 18 дней возникла реканализация.

В 2002г. был разработан и внедрен в практику – способ пластики культи бронха аутоангиотрансплантатом после пневмонэктомий и лобэктомий у больных туберкулезом легких. Оперирован 21 пациент с применением аутоангиопластики культи резецированного бронха. У всех пациентов установлен диагноз фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. Бактериовыделителей было 20 (95,2%), из них у 16 (76,2%) была выявлена резистентность к противотуберкулезным препаратам основного ряда. Среди оперативных вмешательств было 5 (23,8%) лобэктомий, 16 (76,2%) пневмонэктомий. В ближайший послеоперационный период у 2 (9,5%) больных после пневмонэктомии развилась клиника бронхиального свища.

Отсутствие реакции иммунного отторжения, надежность пластики бронха, предохраняющая шов культи в период ее вторичного заживления от формирования сообщения между

культей и плевральной полостью, позволили достигнуть эффективности применения аутоангиотрансплантата 90,5%.

С 2009 года стала применяться проленовая сетка фирмы «Джонсон и Джонсон» при различных видах операций на легких с целью профилактики возникновения бронхиальных свищей, которая использована у 26 больных туберкулезом легких.

По клиническим формам туберкулеза была в 2 (7,7%) случаях, кавернозный туберкулез легкого в 4 (15,4%) и фиброзно-кавернозный туберкулез легкого в 20 (76,9%) случаях, один из которых был с эмпиемой плевры с бронхиальным свищем. У всех больных установлена резистентность к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда.

Бацилловыделение при поступлении было у 8 (30,7%) больных, непосредственно перед операцией у 6 (23,0%) больных.

Всего было выполнено 26 оперативных вмешательств. Способ заключался в укреплении механического шва или культи усеченного бронха путем наложения поверх него лоскута проленовой сетки и фиксации П-образными швами на атравматической игле

В ближайший послеоперационный период осложнения в виде развития бронхиального свища не наблюдалось. Преимуществом способа явилось то, что при резекции легкого укрепление механического шва путем наложения и фиксации поверх него проленовой сетки улучшает условия для заживления и предупреждает развитие бронхиального свища.

В лечении туберкулеза первостепенное значение имеет рациональная химиотерапия с учетом лекарственной чувствительности МБТ к противотуберкулезным препаратам. Хирургические методы используются при неэффективности консервативного лечения, и ввиду роста лекарственно-устойчивого туберкулеза они требуют постоянного совершенствования. Разработанные методы применения пластины Тахокомба, аутоангиотрансплантата и проленовой сетки показали их высокую эффективность (более 90,5%) и позволили сделать вывод, что они являются эффективными альтернативными дополнительными средствами профилактики бронхиальных свищей, которых следует рекомендовать для более широкого применения во фтизиохирургии.

Литература

1. Абисатов Х.А. Плевризация культи бронха после обработки ее аппаратом УКБ -25. //Здравоохранение Казахстана. – 1963, №3, С. 31-34.
2. Григорян В.А., Скляр П.М. Влияние способа укрытия культи бронха на исходы оперативного лечения. //Грудная хирургия, 1987, №2, С.59-63.

Эзофагеальное стентирование при раке пищевода

Жураев Ш.Ш., Байтилеуов Т.А., Шайхиев Е.У., Садыков Н.К., Шокебаев А.А.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова

Карцинома пищевода является относительно часто встречающимся заболеванием с неблагоприятным прогнозом. В Республике Казахстан проблема заболеваемости раком пищевода является одной из наиболее актуальных. Ежегодно в республике выявляется свыше 1500 новых пациентов с данной патологией, при этом, смертность от данного заболевания занимает третье место среди всех злокачественных новообразований [1].

К сожалению, более половины больных данной патологией, на момент обращения в онкологический стационар, не подлежат хирургическому лечению [2]. Радикальная хирургическая резекция возможна менее чем в половине случаев. Основной причиной отказа пациенту в операции является местная распространенность опухолевого процесса, либо обширное лимфогенное и гематогенное метастазирование – более, чем у 75% пациентов, на момент выявления заболевания, имеется поражение лимфатических узлов [3]. Даже после радикальной операции, около 20% больных страдают от дисфагии, вызванной либо рецидивом опухоли, либо стриктурой анастомоза.

По этой причине, паллиативные методы выходят на первый план в лечении пациентов с опухолевой обструкцией пищевода. Эти методы включают в себя паллиативные резекции и шунты, лучевую и химиотерапию, периодическое бужирование и баллонную дилатацию, абляцию опухоли с помощью неодим-иттриевого-алюминий-рубинового лазера, установку пищевода стента или эндопротеза, чрескожную гастростомию или комбинацию вышеперечисленных методов [4]. Основой для решения вопроса о тактике паллиативного лечения является возможность улучшения качества жизни и социальной адаптации пациентов с учетом распространенности заболевания, функционального статуса, а главное – прогноза его дальнейшего течения [5].

Опухолевые обструкции пищевода лечат с помощью паллиативного эндопротезирования вот уже более 100 лет. Первые протезы из слоновой кости и самшита устанавливались через рот и фиксировались снаружи, в одном случае даже с помощью привязывания протеза к усам [6]. Наступление эры гибкой эндоскопии и использование флюороскопического контроля позволило существенно увеличить безопасность установки жестких пищеводных стентов, хотя ее ни в коей мере нельзя было назвать нерискованной процедурой. Стандартом являлась подготовительная дилатация пищевода за 4-5 дней до введения жесткого эндопротеза до размеров, на 2-4 Fr превышающих диаметр самого протеза (48-51 Fr – 16-17 мм). При этом количество непосредственных осложнений превышало 20%, а летальность при метаанализе опубликованных серий составила 8,6% [7]. Непосредственными осложнениями являлись кровотечения, перфорации, нарушение дыхания вследствие сдавления трахеи, смещение эндопротеза. Отдаленные осложнения включали миграцию протеза, стриктуру пищевода с последующим кровотечением или образованием эзофаготрахеальной фистулы. Описаны обрастание протеза опухолью, хроническая аспирация и окклюзия просвета трубки комками пищи. Вот почему жесткие пластиковые стенты практически перестали применяться в клинике после появления существенно более безопасных и эффективных саморасширяющихся стентов.

Разработка и внедрение саморасширяющихся пище-

водных стентов преследовали цель уменьшения числа осложнений, связанных как с процедурой, так и с самими стентами. В отличие от жестких эндопротезов установка саморасширяющегося стента технически проще и сопряжена с меньшим риском кровотечения или перфорации, к тому же не требуется избыточной преддилатации пищевода. Упругая и в то же время гибкая конструкция саморасширяющихся стентов позволяет использовать их даже при наличии существенной извитости сужения. Несмотря на значительно более высокую стоимость металлических саморасширяющихся стентов, исследования подтверждают их большую безопасность и эффективность по сравнению с пластиковыми эндопротезами за счет снижения частоты и тяжести осложнений и как следствие – количества повторных вмешательств. При этом уменьшается время пребывания пациента в стационаре и достигаются лучшие качество и большая продолжительность жизни больных [8].

Для определения локализации и протяженности стриктуры вначале выполняется эзофагография. Пациент размещается на флюороскопическом столе на левом боку. Используется седация, область глотки обрабатывается лидокаиновым спреем. Для прохождения стриктуры применяют подходящие ангиографические проводники и катетеры. Проводник и катетер заводят в 12-перстную кишку, чтобы обеспечить максимально стабильное их положение, после чего обычный проводник меняют на более жесткий. Для преддилатации стриктуры перед установкой стента используют 15-миллиметровый баллон, заполняемый контрастом, разбавленным наполовину водой. После преддилатации по проводнику под флюороскопическим контролем в пищевод проводится стент на доставляющей системе. Необходимо, чтобы он по длине покрывал дополнительно по 2-3 см пищевода от каждого края опухоли. Рекомендуется примерно 60% длины стента располагать над серединой стриктуры, чтобы уменьшить риск возможной его миграции. Протяженные стриктуры могут потребовать несколько стентов, перекрывающих друг друга.

Сразу после стентирования с целью выявления возможных осложнений процедуры (например, перфорации пищевода) и для подтверждения проходимости стента в пищевод через катетер вводится неионный контрастный препарат. После прекращения действия седативных препаратов больному можно позволить выпить небольшое количество воды. На следующий день снова выполняется эзофагография для уточнения необходимости дополнительных вмешательств. Например, недостаточно раскрывшийся стент может потребовать дополнительной баллонной дилатации. При миграции устройства возможна установка дополнительного стента. При этом следующий стент устанавливается коаксиально с наложением на предыдущий эндопротез, что предотвращает дальнейшую миграцию. Если по данным эзофагографии подтверждается правильное положение и проходимость стента, пациент может быть переведен на пероральное питание. Рекомендуется употребление измельченной пищи с тщательным ее пережевыванием и употребление карбонатной минеральной воды после еды для уменьшения рефлюкса и очищения просвета стента.

Пищеводный рефлюкс периодически возникает у любого пациента после установки стента, особенно после стентирования пищевода-желудочного соединения.

Симптомы рефлюкса хорошо контролируются назначением омепразола после процедуры. В последнее время появились также стенты с антирефлюксным клапаном, который, однако, не исключает рефлюкс полностью.

Непосредственный технический успех может быть достигнут в 100% случаев с уменьшением степени дисфагии у 83-100% пациентов [9, 10, 11]. Непокрытые стенты прорастают опухолью в 20-30% наблюдений, в то время как покрытые стенты только в 2%. С отсутствием покрытия связано, однако, то, что непокрытые стенты почти не мигрируют. Миграция стента встречается в 30% использования покрытых Wallstent'ов и только в 10-15% случаев использования стентов Gianturco (СООК, Дания), особенно если они устанавливаются в пищеводно-желудочный переход, когда свободный конец протеза открывается в желудок. Новая конструкция стентов с непокрытыми участками по краям значительно уменьшает вероятность миграции [12].

Таким образом, паллиативное лечение дисфагии при неоперабельной карциноме пищевода или рецидиве карциномы на месте анастомоза – важная проблема, требующая решения. Стентирование пищевода является современным, малоинвазивным и эффективным методом лечения данной патологии.

Литература

1. Арзыкулов Ж.А., Ермакбаева Б.Е., Сейтказина Г.Д., Науанова

Л.Т. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2000 год (статистические материалы). – Алматы. – 2001. – 48 с.

2. Давыдов М.И., Полоцкий Б.Е., Стилиди И.С., Тер-Ованесов М.Д. Рак пищевода: современные подходы к диагностике и лечению. – М., «Русский медицинский журнал», том 14, № 14. – 2006. – с. 28-32.

3. Renkin S., Mason R. // Clin. Radiol. – 1992. – Vol. 461. – P. 373-377.

4. Low D.E., Kozarek R.A. // The esophagus: medical and surgical management // Hill L.E., McCallum R. W., Mercer D.E. et al. – Philadelphia: Sanders, 1998. – P. 47-59.

5. Скобелкин О.К., Топчиашили З.А., Тельных М.Ю., Коньков М.Ю. Палиативное лечение рака пищевода (современные направления). – М., «Русский медицинский журнал», том 4, № 7. – 1996. – с. 3-6.

6. Knyrim K., Wagner H.J., Bethge N. et al. // N. Engl. J. Med. – 1993. – Vol. 329. – P. 1302-1307.

7. Kozarek R.A. // Gastroenterologist. – 1994. – Vol. 2. – P. 264-272.

8. Low D.E., Kozarek R.A. // The esophagus: medical and surgical management // Hill L.E., McCallum R.W., Mercer D.E. et al. – Philadelphia: Sanders, 1998. – P. 47-59.

9. Cwikiel W., Stridbeck H., Tranberg K.G., et al. // Radiology. – 1993. – Vol. 187. – P. 661-665.

10. Saxon R.R., Barton R.E., Katon R.M. et al. // Journal of Vascular and Interventional Radiology. – 1995. – Vol. 6. – P. 747-754.

11. Song H.Y., Do Y.S., Han Y.M. et al. // Radiology. – 1994. – Vol. 193. – P. 689-695.

12. Sander R.R., Poesl H. // Endoscopy. – 1993. – Vol. 25 (suppl.). – P. 679-682.

Предоперационная химиоинфузия в бронхиальную артерию в комплексном лечении немелкоклеточного рака легкого III стадии

О.К. Кулакеев*, С.Е. Оспанов**, Д.Т. Арыбжанов***

*Международный Казахско-Турецкий университет, г. Туркестан,

**Областной онкологический центр, г. Кызылорда,

***Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер, г. Шымкент

Өкпенің жасушалы емес қатерлі ісігінің комплексті емдеудегі брохиалды артерияға қолданылатын химиотерапия

О.Қ. Кулакеев, С.Е. Оспанов, Д.Т. Арыбжанов

Мақалада өкпенің жасушалы емес қатерлі ісігінің неoadъювантты химиотерапия 50 науқасқа жүргізілгені кең түрде көрсетілген, 11 (22%) өкпенің барлық және ателектаз зақымдаған бөлігінің біріншілік кеуі орын алды. Морфологиялық өкпенің желпар жасушам 36 (27%) кездессе, 14 (28) аденокарцинома барлық науқастарға ем цикл бойынша неoadъювантты ПХТ жүргізілді 21

(76%) науқастың химиотерапия бірінші курсы процестің бөшктік регрессиясы. Ал 38(76%) ем курс химиотерапиядан науқастарда бөліктік регрессия байланды. 50 35 (70%) оталық ем қолданған. 35 жасалынған ота науқастың 25 кенейтімен. Ал 10 интраперикардпен, перикард резекциясының пульмоноэктомиясы, өкпе түбірі тамырында байланған жекелей кездесті. Цитостатиктерің артерия енгізуі емдеу 10-15% нәтижелерің жақсартады, таңдалған бағдарламасы бойынша емдеудің тиімді аяқталуын етеуі.

Рак легкого (РЛ) — широко распространенное заболевание. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями РЛ в мире занимает 1-е место [1, 3, 5]. Показатель заболеваемости раком легкого населения России в 1997 г. был 44,69 на 100 000 населения, в 2007 г. - 40,2 на 100 000 населения. Если в 1970 году в республике Казахстан заболеваемость раком легкого составила 15,2‰, то к 2007 году она выросла до 22,6‰ и в структуре онкологической заболеваемости с 1985 года занимает 1-ое место [1, 3]. Мужчины заболевают в 5—8 раз чаще женщин. Наиболее часто заболевание регистрируется в возрасте 50 лет и старше. Летальность больных в течение первого года с момента установления диагноза составляет в разных странах от 55,3% до 80% [2, 6, 8, 9].

Среди гистологических форм основную массу больных РЛ составляет немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) составляет около 78-84%. Учитывая, что более половины больных НМРЛ уже неоперабельны на момент установления диагноза, либо в связи с местно-распространенным процессом, либо в связи с наличием отдаленных метастазов, очевидна актуальность разработки методов лекарственной терапии этой формы рака. В настоящее время лекарственная терапия НМРЛ - одна из наиболее динамично развивающихся разделов химиотерапии опухолевых заболеваний. Мета-анализ индивидуальных данных 11 рандомизированных исследований показал, что использование платиносодержащих комбинаций в сочетании с лучевой на 10% снижает риск смерти у больных НМРЛ по сравнению с одной лучевой терапией [4, 7, 10, 12]. Эффективным оказалось использование комбинированной химиотерапии, включающей производные платины в плане неoadъювантной (предоперационной) химиотерапии у больных НМРЛ IIIa,б стадии. Предоперационная химиотерапия, как было показано в рандомизированных исследованиях, более чем в 3 раза увеличивает выживаемость больных, получивших перед операцией 3 курса платиносодержащей комбинированной химиотерапии, по сравнению с контрольной группой, подвергшейся лишь операции [13, 14, 15].

Учитывая вышеизложенное авторами произведена попытка применения предоперационной химиотерапии у больных раком легкого III стадии с применением ре-

гионарного введения цитостатиков в бронхиальную артерию.

Целью нашей работы является изучение непосредственных результатов комбинированного лечения больных НМРЛ с применением неoadъювантной химиотерапии за 5 (2004-2009 гг.) лет.

Материал и

методы

Начиная с июня 2004 года мы имеем практический опыт лечения 50 больных с местно распространенным, центральным раком легкого (Т3N1-2M0) в возрасте 42-65 лет. У 11 (22%) больных при первичном обращении имел место ателектаз пораженной доли или всего легкого. Морфологически в 36 (72%) случаях был плоскоклеточный рак легкого, в 14 (28%) случаях аденокарцинома. Всем больным из-за сомнений операбельности процесса было проведено по два цикла неoadъювантной полихимиотерапии. У 4 (8%) больных по схеме EP: Вепезид 120 мг/м², Цисплатин 80 мг/м² с дополнением длительной инфузией 5-фторурацила 5000мг в течении 120 часов, у 24 (48%) больных по схеме TP: Таксотер 75мг/м², Цисплатин 75 мг/м², у 22 (44%) больных по схеме EP: Вепезид 120мг/м², Цисплатин 80 мг/м². При этом у 20 (40%) больных было произведено внутриаrтериальное, регионарное введение препаратов с селективной катетеризацией бронхиальной артерии (рис. 1).



Рисунок 1. Селективная катетеризация бронхиальной артерии пациента М. -52 года с диагнозом центральный рак правого легкого Т3N1M0, III St. Ангиограмма а. Brochialis справа.



Рисунок 2. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 лет (до лечения). Диагноз: центральный рак левого легкого T3N2M0, III-б St. Левосторонний плеврит с ателектазом легкого.



Рисунок 3. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 лет (после предоперационной химиотерапии).

Результаты

При контрольном осмотре после одного курса химиотерапии у 21 (42%) больных рентгенологически отмечена частичная регрессия процесса, в том числе у 3 (6%) больных восстановление дыхательной функции легких в ранее ателектазированных участках, у 29 (58%) больных стабилизация процесса. После 2х курсов химиотерапии у 38 (76%) больных отмечена частичная регрессия процесса, эндоскопически у 14 (28%) проходимость бронхов восстановлена до сегментарных бронхов (Рис. 2, 3, 4). Рентгенологически отмечена возможность операбельности процесса во всех 38 случаях. Из 50 больных подвергнуты хирургическому лечению 35 (70%) больных (у 3-х больных отмечено противопоказание к хирургическому вмешательству в связи с присоединением сопутствующей сердечно-сосудистой патологии). Из 35 оперированных больных в 25 случаях произведена расширенная пульмонэктомия, а 10 случаях комбинированно-расширенная пульмонэктомия с резекцией перикарда с интраперикардиальной, раздельной обработкой сосудов корня легкого. Послеоперационный период во всех случаях протекал без особенностей. Послеоперационный результат гистологического исследования во всех случаях показал лекарственный патоморфоз III-IV степени. 3 больных в послеоперационном периоде получили лучевую терапию по радикальной программе. В раннем послеоперационном периоде умерла 1 больная из-за нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности. После хирургического этапа все больные получили лучевую терапию на область средостения РОД 2Грей, СОД 45-50 Грей. Затем еще по 2-4 консолидирующих курсов химиотерапии по той же схеме, то и до операции.

Выводы. Таким образом, использование новых противоопухолевых препаратов, в первую очередь, ингибиторов топоизомеразы 1 (Этопозид) и таксанов в сочетании с производными платины позволило повысить операбельность больных с распространенным НМРЛ. Производные платины пока остаются основой современной комбинированной химиотерапии НМРЛ. Однако предоперационная неoadъювантная химиотерапия и химиолучевая терапия с последующей операцией могут считаться апробированным методом и рассматриваться как один из вариантов лечения при III стадии НМРЛ. Применение цитостатиков в режиме внутриартериального введения может улучшить непосредственные результаты лечения на 10-15%, что даст возможность эффективно закончить лечение по выбранной программе.



Рисунок 4. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 лет (после пульмонэктомии через 2 года). Диагноз: центральный рак левого легкого T3N2M0, III-б St. Состояние после комбинированной терапии.

Диагноз: центральный рак левого легкого T3N2M0, III-б St. Частичная регрессия процесса.

Литература

1. Абисатов Х.А. – Клиническая онкология (руководство), Алматы, изд. «Арыс», 2007 с.1240 с.
2. Давыдов М.И., Полоцкий Б.Е. – Рак легкого. М. «Радикс», 1994, с.210
3. Кулакев О.К., Арыбжанов Д.Т., Юсупов А.М. и др. Эффективность неoadъювантной химиотерапии немелкоклеточного рака легкого // В Сб. Республ. Научно-практич. Конференции «Актуальные проблемы клинической онкологии», Семей, 2007, С 150-151
4. Кулакев О.К., Арыбжанов Д.Т., Султанов Р.Р. Результаты лечения рака легкого // Вестник хирургии Казахстана, №3, Алматы, -2005, -С. 113.
5. Онкология. Клинические рекомендации. Под редакцией В.И.Чиссова и С.П.Дарьяловой, Москва. ГЭОТАР - «Медиа», 2006.с. 193-230.
6. Орлова Р.В. Современное стандартное лечение больных немелкоклеточным раком легкого с учетом стадии заболевания // Практическая онкология. – 2000, №3. – С. 17-20.
7. Переводчикова Н.И. Химиотерапия немелкоклеточного рака легкого – состояние проблемы в 2000г. // Практическая онкология. - 2000, №3. – С. 29-37.
8. Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И. Клиническая онкопульмонология. Москва. ГЭОТАР «Медицина», 2000 – 600 с.
9. Харченко В.П., Кузьмин И.В. Рак легкого. М, 2Медицина», 1994 с.480.

10. Burkhart N.M., Allen M.S., Nichols F.C., et. al. Results of en bloc resection for bronchogenic carcinoma with chest wall invasion. //J. Thorac. Cardiovasc. Surg, 2002, vol.123. p.670-675
11. Curan W.J. Issues in the nonoperative management of patients with locally advanced non-small cell lung cancer// Proc. ASCO. - 1999. - Educational book/Ed. M.C. Perry; ASCO. -1999. -P.370-373.
12. Holmes A.C. Surgical adjuvant therapy for stage II and stage III adenocarcinoma and large cell undifferentiated carcinoma// Chest. -1994. -Vol. 106 (6 suppl). -P. 293-296 .
13. Gumerlock P.H. Molecular-clinical correlative studies in non-small cell lung carcinoma.//ASCO.—1999.—Educational book/ Ed.- M.C. Perry; ASCO.-1999.-P.374-381.
14. Kelly K. Future Directions for New Cytotoxic Agents in the treatment of advanced non-small-cell lung cancer// Proc. ASCO. — 2000. — Educational book. -P. 357-367.
15. Marsiglia H., Baldeyrou P., Lartigau E. et.al. //High-dose-rate brachytherapy as sole modality for early-stage endobronchial carcinoma// Inter. J. Radiat, Oncol, Biol, Phys, 2000, vol.47, p.665-672.

Результаты хирургического и комбинированного лечения рецидивных сарком мягких тканей

Байзаков Б.Т., *Кулакеев О.К.

Актюбинский областной онкологический диспансер, г. Актобе,

*Международный Казахско-Турецкий университет, г. Туркестан

Жұмсақ ұлпалар ісіктерінің қайталауындағы ота жасаумен комбинирленген емнің нәтижелері

Байзаков Б.Т., Кулакеев О.К.

Мақалада жұмсақ ұлпалар ісіктері бар 3 жастан 87 жасға дейін 204 науқасты 20 жыл арасында байқаумен емдеу нәтижелері көрсетілген. Науқастардың орта жасы 45 жас. Әйелдер - 110 (53,9±4,7%), ерлер - 94 (46,1±5,1%). Ісіктің алғашқы орнында қайталауы 95 (51,9%) науқаста байқалды. Олардың 73 (76,8%) не қайта радикалды ота жасалды. Жұмсақ ұлпалар ісіктерінің ерекшеліктерине байланысты олардың гистологиялық түрлеріне, көлеміне және емдік түріне байланыспай емнің толық болмауының себептері мен олардың жиі қайталауы байқалады.

Results Of The Surgical And Combined Treatment Of Recurrent Soft Tissue Sarcomas

Bajzakov B.T., Kulakeev O. K.

In article the analysis of the surgical and combined treatment of 204 soft tissue sarcomas for 20 years at the age from 3 years till 87 years is carried out. Middle age has made 45 years. Women was – 110 (53,9 %), men - 94 (46,1 %). Local relapses after treatment of a primary soft tissue sarcomas

have come at 95 (51,9 %) patients. Radical repeated operative intervention concerning local relapse of a tumors was possible at 73 (76,8 %) patients. Non treatment local tumoral process at recurrent tumors, as well as at primary soft tissue sarcomas, is dominating in most cases it is not dependent from histology, the size of a sarcoma and a treatment method.

Саркомы мягких тканей встречаются сравнительно редко, составляя 0,2-2,6% по отношению ко всем злокачественным новообразованиям человека. Показатель заболеваемости составляет 1,7 чел. у мужчин и 1,6 чел. у женщин на 100000 населения [1, 4, 6]. У 60% больных саркома мягких тканей поражает конечности, из них более у двух третей пациентов опухоль локализуется на нижних конечностях. По данным различных авторов особенностью сарком мягких тканей является частое гематогенное метастазирование от 24% до 52,6% и значительно реже – лимфогенное от 2,9% до 10% [2, 3, 5]. Долгое время единственным вариантом лечения больных с саркомами мягких тканей являлся хирургический метод, который остается наиболее распространенным и в настоящее время. После местного иссечения, проведенного в качестве самостоятельного метода лечения, высока частота локальных рецидивов от 38,8% до 81,1% [1, 3, 7]. Удаление саркомы мягких тканей в пределах ее псевдокапсулы сопровождается рецидивированием опухоли приблизительно у 90% больных, при широком местном иссечении опухоли (с небольшими участками окружающих ее здоровых тканей) отмечается 40% частота рецидивов. Установлено, что радикальное местное иссечение опухоли (удаление в пределах анатомической структуры или мышечной группы, либо ампутация) сопровождаются локальными рецидивами в пределах 10-15% случаев [2, 8, 9, 10].

Цель исследования

Изучить результаты хирургического и комбинированного лечения больных саркомами мягких тканей по данным Южно-Казахстанского и Актюбинского областных онкологических диспансеров.

Материал и методы

Настоящее исследование охватывает временной период с января 1990 года по декабрь 2009 года (20 лет). Научная работа проводилась на базе Южно-Казахстанского и Актюбинского областных онкологических диспансеров. Под наблюдением находились 204 больных различными гистологическими вариантами сарком мягких тканей.

Характеристика больных саркомой мягких тканей в соответствии с системой TNM представлена в таблице 1.

В 4 случаях не удалось установить размеры первичной опухоли из-за отсутствия первичной документации по месту жительства. У 113 (57,5±3,5%) больных при первичном обращении размер опухоли был более 5см в наибольшем

Таблица 1. Характеристика больных в соответствии с распространенностью опухолевого процесса и гистологическим вариантом опухоли

Гистологический вариант опухоли	Размер опухоли											
	T ₁						T ₂					
	К о л и - чество		N		M		К о л и - чество		N		M	
	абс чис	%	абс чис	%	абс чис	%	абс чис	%	абс чис	%	абс чис	%
Зл.фиброзная гистиоцитома	27	13,5	1	0,5	-	-	28	14,0	-	-	2	1,0
Липосаркома	5	2,5	-	-	-	-	28	14,0	-	-	-	-
Фибросаркома	14	7,0	-	-	-	-	17	8,5	-	-	-	-
Рабдомиосаркома	9	4,5	-	-	-	-	11	5,5	-	-	-	-
Лейомиосаркома	3	1,5	-	-	-	-	9	4,5	-	-	-	-
Дерматофибросаркома	8	4,0	-	-	-	-	1	0,5	-	-	-	-
Синовиальная саркома	4	2,0	-	-	-	-	4	2,0	-	-	1	0,5
Зл.гемангиоперицитома	2	1,0	-	-	-	-	5	2,5	-	-	-	-
Зл.гемангиоэндотелиома	2	1,0	-	-	-	-	2	1,0	-	-	-	-
Зл. шваннома	7	3,5	-	-	-	-	6	3,0	-	-	-	-
Альвеолярная саркома	2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зл. мезенхимомы	-	-	-	-	-	-	2	1,0	2	1,0	-	-
Гигантоклеточная саркома	1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неклас. саркома	1	0,5	-	-	-	-	2	1,0	2	1,0	-	-
Итого: 200(100%)	85	42,5 ±3,5	1	0,5	-	-	115	57,5 ±3,5	4	2,0	3	1,5

Таблица 2. Распределение больных саркомой мягких тканей по полу

Гистологический вариант опухоли	Пол				Всего	
	Мужчины		Женщины			
	абс	%	абс	%	абс	%
Зл. фиброзная гистиоцитома	24	11,7	33	16,2	57	27,9
Липосаркома	18	8,8	15	7,3	33	16,1
Фибросаркома	17	8,3	15	7,3	32	15,6
Рабдомиосаркома	7	3,4	14	6,9	21	10,3
Лейомиосаркома	6	2,9	6	2,9	12	5,8
Дерматофибро-саркома	3	1,5	6	2,9	9	4,4
Синовиальная саркома	5	2,5	3	1,5	8	4,0
Зл. гемангио-перицитома	4	2,0	3	1,5	7	3,5
Зл. гемангио-эндотелиома	3	1,5	1	0,5	4	2,0
Зл. шваннома	4	2,0	9	4,4	13	6,4
Альвеолярная саркома	1	0,5	1	0,5	2	1,0
Зл. мезенхимомы	1	0,5	1	0,5	2	1,0
Гигантоклеточная саркома	0	-	1	0,5	1	0,5
Некласс. саркома	1	0,5	2	1,0	3	1,5
Итого	94	46,1±5,1	110	53,9±4,7	204	100

измерении, у 85 (42,5±3,5%) опухоль была 5см и менее. Распределение больных по полу представлено в таблице 2.

По данным, представленным в таблице 2, следует, что наиболее часто из всех сарком мягких тканей встречалась злокачественная фиброзная гистиоцитома и чаще у женщин. На втором месте по частоте выявляемости стояла липосаркома, на третьем – фибросаркома, которые чаще наблюдались у мужчин.

Метастазы в регионарные лимфоузлы выявлены у 5 (2,5%) больных, что подтверждает относительно редкое метастазирование сарком мягких тканей в лимфатические узлы. Отдаленные метастазы при первичном обращении выявлены в 3 (1,5%) случаях: у 2 больных злокачественной фиброзной гистиоцитомой и у одного больного синовиальной саркомой.

Саркомы мягких тканей характеризуются крайним разнообразием по гистогенезу, различной частотой поражения мужчин и женщин. Саркомы мягких тканей в нашей группе больных чаще наблюдались у женщин – 110 (53,9±4,7%), реже у мужчин - 94 (46,1±5,1%).

Возраст больных колебался в большом диапазоне от 3 лет до 87 лет. Средний возраст составил 45 лет. Из общего числа больных саркома мягких тканей 32,9% находились за пределами возраста 60 лет и старше. Число заболевших в возрасте от 46 лет до 60 лет и старше составило 63,3% больных.

Локализация сарком мягких тканей на нижних конечностях наблюдалась у 118 (57,9%) больных, на верхних конечностях соответственно - 38 (18,8%), на туловище 48 (23,3%). В сумме локализация саркомы мягких тканей на конечностях составила 76,7%.

Распределение больных в зависимости от локализации опухоли представлены на рисунке 1.

Больным с рецидивными саркома мягких тканей нами проводилось, как и при первичных саркомах хирургическое и комбинированное лечение. Включение предоперационной или послеоперационной лучевой терапии проводилось с учетом предшествующего лечения первичной опухоли, при котором применялась или не применялась лучевая терапия, подведенная доза.

Таблица 3. Частота повторных рецидивов саркомы мягких тканей в зависимости от размера и гистологического варианта опухоли после хирургического лечения

Гистологический вариант опухоли	Размер рецидивной опухоли					
	T1			T2		
	Кол-во	Рецидив		Кол-во	Рецидив	
		абс.	%±m		абс.	%±m
Зл. фиброзная гистиоцитома	9	6	66,7 ± 16,7	6	4	66,7 ± 21,0
Липосаркома	1	0	-	6	4	66,7 ± 21,0
Фибросаркома	6	4	66,7 ± 21,0	4	1	-
Лейомиосаркома	1	1	-	2	1	-
Рабдомиосаркома	2	0	-	3	3	-
Зл. шваннома	1	1	-	3	2	-
Дерматофибросаркома	3	1	-	1	1	-
Зл. гемангиоэндотелиома	1	1	-	-	-	-
Зл. мезенхимомы	-	-	-	1	1	-
Синовиальная саркома	-	-	-	1	1	-
Неклассифицируемая саркома	1	1	-	-	-	-
Всего: 52	25	15	60,0±10,0	27	18	66,7±9,2

Результаты и их обсуждение

Локальные рецидивы после лечения первичной саркомы мягких тканей наступили у 95 (51,9%) больных. Радикальное повторное оперативное вмешательство по поводу локального рецидива опухоли было возможным у 73 (76,8%) больных. У 52 пациентов повторно выполнялось только хирургическое лечение, в эту подгруппу вошли больные, которым на предыдущем этапе проводилось комбинированное и хирургическое лечение.

Хирургическое лечение рецидивов сарком мягких тканей проводилось по тем же принципам, что и при первичных саркомах: абластичность и футлярность. По объему вмешательства все операции можно разделить на 2 типа: сберегательные и калечащие. Ампутации или экзартикуляции выполнены у 17 (30,3%) больных при локализации рецидива саркомы мягких тканей на верхних и нижних конечностях. Ампутация или экзартикуляция конечности вынужденный объем оперативного вмешательства. Уровень ампутации зависел от локализации рецидивной опухоли.

При дефиците тканей оперативное вмешательство нами завершалось пластикой послеоперационной раны. Пластика обширной послеоперационной раны после иссечения рецидива саркомы васкуляризированным лоскутом нами применялась в 2 (3,8%) случаях при локализации опухоли на голени. У одного больного произошла гибель донорского васкуляризированного лоскута из-за тромбоза микрососудистого анастомоза. Рана была пластирована свободным полнослойным кожным лоскутом.

В 7(13,5%) случаях послеоперационная рана пластировалась свободным расщепленным кожным лоскутом, в 4(4,7%) случаях - перемещенным кожно-фасциальным лоскутом. Хирургическое удаление

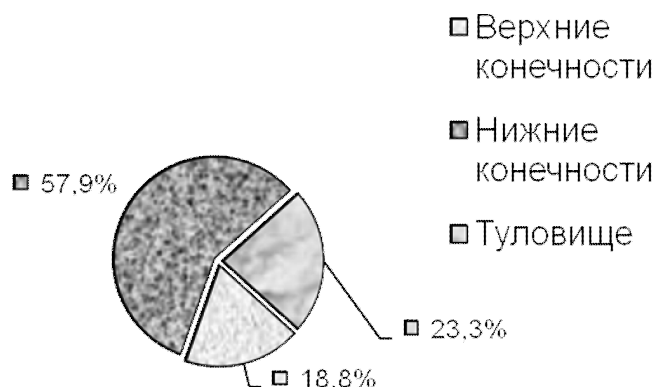


Рис. 1. Распределение больных по локализации опухоли.

рецидивных сарком мягких тканей выполнено у 52 больных и было окончательным методом лечения.

Частота локальных повторных рецидивов после хирургического лечения больных в зависимости от размера и гистологического варианта опухоли представлены в таблице 3.

Из представленных в таблице 3 данных прослеживается, что частота повторных рецидивов саркомы мягких тканей у больных после хирургического лечения не зависит от размера опухоли. Статистически значимых различий нет $p > 0,05$. Анализируя зависимость частоты рецидивов опухоли от гистологического варианта саркомы, можно сделать вывод, что частота рецидивов не зависит от гистологического варианта саркомы мягких тканей. Так у 9 больных с рецидивной злокачественной гистиоцитомой размером до 5 см после хирургического лечения повторные рецидивы наступили у 6 ($66,7 \pm 16,7$). У 6 больных рецидивной фибросаркомой размером до 5 см повторные рецидивы выявлены у 4 ($66,7 \pm 21,0$). Статистически значимых различий нет, $p > 0,05$. Подобный вывод можно сделать, анализируя частоту повторных рецидивов в наиболее многочисленных группах при размере рецидивной опухоли более 5 см в диаметре.

Количество повторных рецидивов не зависимо от размера опухоли постепенно снижается ко 2 году после хирургического лечения пациентов. Зависимость сроков появления локального повторного рецидива от размера опухоли после хирургического лечения рецидивной саркомы мягких тканей отражены в таблице 4.

После хирургического лечения рецидивной саркомы мягких тканей преобладает неизлеченность процесса и ранние повторные рецидивы опухоли. Подобная закономерность наблюдалась и при первичных саркомах. Исключением из данной закономерности явились только 2 случая: злокачественная шваннома и лейомиосаркома при размере опухоли до 5 см, где не наблюдалась неизлеченность локального опухолевого процесса. У больного злокачественной дерматофибросаркомой при размере опухоли более 5 см также не регистрировалась неизлеченность локального опухолевого процесса.

Комбинированное лечение проводилось нами тем больным, которые на предыдущем этапе получили только хирургическое лечение. Комбинированное лечение проведено нами 21 больному при повторных рецидивах саркомы мягких тканей. У 12 больных рецидивная саркома была размером до 5 см. и у 9 больных более 5 см.

Частота локальных повторных рецидивов в зависимости от гистологического варианта и размера опухоли после комбинированного лечения больных представлена в таблице 5.

Статистически значимых различий зависимости частоты повторных рецидивов саркомы и ее размером после комбинированного лечения, как и в подгруппе больных с первичными саркомами мягких тканей, нет, $p > 0,05$. Провести статистический анализ данных зависимости частоты повторных рецидивов от гистологического варианта

Таблица 4. Сроки появления локального опухолевого роста в зависимости от гистологического варианта и размера опухоли после хирургического лечения рецидивной саркомы мягких тканей

Период	Хирургический Размер рецидивной опухоли				Количество больных	
	T ₁		T ₂			
	абс	%± m	абс	%± m	абс	%± m
Неизлеченность процесса	9	27,3±7,7	10	30,3±8,0	19	57,5±8,6
Ранний рецидив	4	12,1±5,6	8	24,2±7,4	12	36,4±8,3
Поздний рецидив	2	6,1±4,2	-	-	2	6,1±4,2
Итого	15	45,5±8,6	18	54,5±8,6	33	100

Таблица 5. Частота локальных повторных рецидивов в зависимости от размера и гистологического варианта рецидивной опухоли после комбинированного лечения

Гистологический вариант опухоли	Размер рецидивной опухоли					
	T ₁			T ₂		
	Кол-во	абс	%±m	Кол-во	абс	%±m
Зл. фиброзная гистиоцитома	7	1	-	5	3	-
Липосаркома	-	-	-	2	0	-
Фибросаркома	3	2	-	1	1	-
Рабдомиосаркома	-	-	-	1	1	-
Зл. шваннома	1	1	-	-	-	-
Синовиальная саркома	1	1	-	-	-	-
Итого 21	12	5	41,7 ± 14,9	9	5	55,6 ± 17,6

саркомы мягких тканей у больных после комбинированного лечения невозможно из-за малого количества наблюдений. Но очевиден тот факт, что в данной группе отсутствуют больные с локальными повторными рецидивами при наличии высокозлокачественных опухолей. Их гибель произошла в первый год после лечения, за исключением одного больного с синовиальной саркомой мягких тканей.

Время появления повторных рецидивов сарком мягких тканей в зависимости от размера опухоли после комбинированного лечения больных представлены на рисунке 2.

Повторные рецидивы, как это отражено на рисунке 2 в сроки до 42 мес. наблюдались у больных после комбинированного лечения только при размере рецидивной опухоли не более 5 см. Прослеживается тенденция к сдвигу по времени в сторону увеличения временного интервала от момента окончания лечения и возникновением повторного рецидива. Отсутствие повторных рецидивов у больных при размере опухоли более 5 см объясняется их гибелью от генерализации опухолевого процесса.

Сроки появления локального опухолевого роста после комбинированного лечения в зависимости от размера рецидивной саркомы мягких тканей отражены в таблице 6.

По данным, представленным в таблице 6, при размере рецидивной опухоли до 5 см после комбинированного лечения в сроки до 6 месяцев локальных повторных рецидивов не наблюдалось.

Анализируя данные по срокам появления локальных рецидивов не зависимо от методов лечения и размера первичной или рецидивной саркомы мягких тканей, можно сделать вывод, что преобладает неизлеченность локального опухолевого процесса.

Частота повторных рецидивов саркомы мягких тканей в зависимости от размера опухоли и способа лечения представлены в таблице 7.

Из представленных данных в таблице 7 повторные рецидивы при размере опухоли до 5 см после хирургического лечения наблюдались у 15 ($60,0 \pm 10,0$) больных, а после комбинированного лечения у 5 ($41,7 \pm 14,9$) пациентов. Статистически значимых различий частоты локальных по-

Таблица 6. Сроки появления локального повторного опухолевого роста после комбинированного лечения в зависимости от размера опухоли

Локальный опухол. рос	Комбинированный				Количество больных	
	Размер рецидивной опухоли					
	T ₁		T ₂		абс.	%± m
	абс.	%± m	абс.	%± m		
Неизлечен. процесса	-	-	3	30,0±15,3	3	30,0±15,3
Ранний рецидив	3	30,0±15,3	2	20,0±13,3	5	50,0±16,7
Поздний рецидив	2	20,0±13,3	-	-	2	20,0±13,3
Итого	5	50±16,7	5	50±16,7	10	100

Таблица 7. Частота локальных повторных рецидивов в зависимости от метода лечения и размера рецидивной опухоли

Метод лечения	Размер рецидивной опухоли					
	T ₁			T ₂		
	Кол-во	Повторный рецидив		Кол-во	Повторный рецидив	
		абс.	%±m		абс.	%±m
Хирургич.	25	15	60,0±10,0	27	18	66,7±9,2
Комбинир.	12	5	41,7±14,9	9	5	55,6±17,6
Итого (73)	37	21	56,8±8,1	36	22	61,1±8,1

Таблица 8. Частота локальных рецидивов в зависимости от размера и метода лечения первичной и рецидивной саркомы мягких тканей

Метод лечения	Первичная опухоль				Рецидивная опухоль			
	T ₁		T ₂		T ₁		T ₂	
	абс.	%±m	абс.	%±m	абс.	%±m	абс.	%±m
Хирургический	43	71,7±6,9	36	61,0±6,3	15	60,0±10,0	18	66,7±9,2
Комбинир.	5	23,8±9,5	11	25,0±6,5	5	41,7±14,9	5	55,6±17,6
Итого	48	57,5±5,3	47	45,6±4,9	20	53,8±8,0	23	57,9±8,0

вторных рецидивов при размере опухоли до 5 см нет, $p > 0,05$.

Нарушение нормальной топографии тканей в зоне операции и дефицит здоровых тканей не только ограничивают объем оперативного вмешательства, но и затрудняют визуальный контроль.

Данные по частоте рецидивов после хирургического и комбинированного лечения больных с первичными и рецидивными саркомами мягких тканей отражены в таблице 8.

Представленные в таблице 8 результаты указывают на отсутствие различий частоты локальных рецидивов после комбинированного и хирургического лечения первичных и рецидивных сарком мягких тканей в зависимости от размера опухоли, $p > 0,05$.

Снижается эффективность комбинированного метода лечения больных с локальными рецидивами сарком мягких тканей. Статистически значимых различий частоты локальных повторных рецидивов в зависимости от метода лечения рецидивной саркомы нет, $p > 0,05$.

Выводы

Таким образом, локальные повторные рецидивы сарком мягких тканей сопровождаются рядом проблем при их диа-

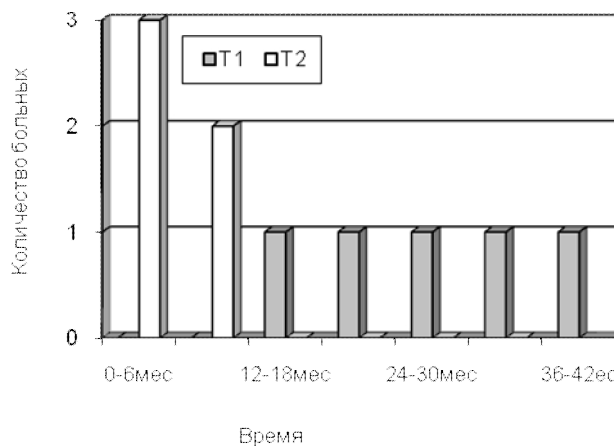


Рис. 2. Сроки появления локальных рецидивов после комбинированного лечения в зависимости от размера опухоли.

гностике. Регионарный фиброз и разрушенные нормальные анатомические барьеры, как результат предшествующего лечения, является главным препятствием в определении истинных границ распространения локального опухолевого процесса в зоне рецидива саркомы. Дефицит здоровых тканей в ряде случаев является основной причиной нарушений принципов радикализма.

Неизлеченность локального опухолевого процесса при рецидивных опухолях, как и при первичных саркомах мягких тканей, является доминирующей в большинстве случаев не зависимо от гистогенеза, размера саркомы и метода лечения.

Литература

1. Алиев М.Д., Соловьев Ю.Н., Хараташвили Т.К. и др. Хондросаркома кости. М.: Инфра-М, 2006. 216 с.
2. Алиев М.Д., Мехтиева Н.И., Бохан Б.Ю. Факторы прогноза сарком мягких тканей // *Вопр. онкологии.* – 2005. – Т. 51, № 3. – С. 288-299.
3. Горбунова В.А., Феденко А.А. Трабектедин: новые возможности химиотерапии диссеминированных сарком мягких тканей. Реферативный журнал «РМЖ» от 29 апреля 2009г.
4. Краевский Н.А., Смольяников А.В., Саркисов Д.С. Патолого-анатомическая диагностика опухолей человека: Руководство: В 2 т. М.: Медицина, 1993. 1248 с.
5. Arce F.P., Pinto J., Portero I. et al. Cutaneous metastases as initial manifestation of dedifferentiated chondrosarcoma of bone. An autopsy case with review of the literature // *J. Cutan. Pathol.* 2000. Vol. 27 (5). P. 262-267.
6. Bruns J., Fiedler W., Werner M., Delling G. Dedifferentiated chondrosarcoma fatal disease // *J. Cancer Res. Clin. Oncol.* 2005. Vol. 131 (6). P. 333-339.
7. Doganavsargil B., Argin M., Sezak M. et al. Dedifferentiated chondrosarcoma of the thumb: a case report // *Arch. Orthop. Trauma Surg.* 2009. Vol. 129 (2). P. 161-166.
8. Evans H.L., Ayala A.G., Romsdahl M.M. Prognostic factors in chondrosarcoma of bone: a clinicopathologic analysis with emphasis on histologic grading // *Cancer.* 1977. Vol. 40. P. 818-831.
9. Fletcher C.D.M., Unni K.K., Mertens F. Pathology and Genetics of Tumors of Soft Tissue and Bone. Lyon, France: IARC Press; 2002. World Health Organization Classification of Tumours. Vol. 5. P. 70.
10. Le Cesne A et al. Phase II study of ET-743 in advanced soft tissue sarcomas: a European Organisation for the Research and Treatment of Cancer (EORTC) soft tissue and bone sarcoma group trial. *J Clin. Oncol.* 2005;23:576-84.

Предоперационная лучевая терапия больных раком прямой кишки при различных режимах фракционирования и с радиомодификаторами

Кулиева Н.Г.

Национальный центр онкологии, г. Баку

Заболеваемость и смертность от рака прямой кишки (РПК) в большинстве экономически развитых стран в последние десятилетия остаются стабильно высокими, проявляя тенденцию к увеличению /4,9,12,14/. В Азербайджане в течение 20 лет заболеваемость РПК увеличилась почти в два раза и составляет 5,9 на 100 тысяч населения /1,2/. Основным методом лечения данного контингента больных – хирургический, в настоящий момент не располагает результатами, приемлемыми для адекватного разрешения проблемы. Процент рецидивирования РПК после радикальных операций, по данным разных авторов, остается достаточно высоким-20%-50%, а пятилетняя выживаемость больных колеблется в пределах 38%-62% /6,7,10,13,15/.

На данном этапе развития онкологии, исходя из современных понятий о канцерогенезе, не вызывает сомнений необходимость поиска оптимальных сочетаний хирургического метода с лучевой терапией, которые с разной степенью эффективности применяются уже в течение ряда лет. В то же время, до настоящего времени не достигнуто единого мнения о последовательности их применения, оптимальных режимах и дозах лучевой терапии, эффективности использования радиомодификаторов и т.д. /3, 5, 8/.

Как известно, комбинированный метод- то есть, сочетание лучевой терапии и операции, направлен на повышение абластики, снижение риска имплантационных метастазов, повышение резектабельности, дезактивацию регионарных метастазов. Между тем, возможности лучевой терапии больных РПК ограничены низкой толерантностью к облучению окружающих органов и тканей, а также риском индукции негативных реакций со стороны организма в целом. Это обстоятельство послужило основанием для поиска способов и средств, способствующих повышению радиочувствительности опухолей прямой кишки. Для оценки некоторых из них нами были проанализированы различные варианты предоперационной терапии у больных РПК.

Материалы и методы

Изучены результаты комбинированного лечения 375 больных РПК, находившихся на стационарном лечении в Национальном центре онкологии Азербайджанской республики. В исследование были включены пациенты, которым проводилась предоперационная лучевая терапия (ЛТ), с последующей радикальной операцией. Из них – 179 мужчин и 196 женщин, в среднем возрастном составе от 32 до 74 лет. Все больные РПК были в плановом порядке обследованы, так как оперативное вмешательство не носило экстренного характера. Наряду с клиническими данными, в обязательном порядке производилась колоноскопия с гистологическим исследованием биоптата, ультразвуковая, компьютерная томография, ряд биохимических тестов, по показаниям использовались более специфические методы - например, радионуклидный, тесты для идентификации сопутствующих патологий и др. У всех больных диагноз РПК был гистологически верифицирован, в подавляющем большинстве была выявлена аденокарцинома

различной степени дифференцировки. У 131 пациента (38,2%) отмечалась стадия заболевания T2-3N0M0, у 142 (38,8%) – T2-3N1-2M0, у 38 (11,0%) – T4N0M0, у 34 (9,9%) – T4 N1-2M0.

В зависимости от метода предоперационной терапии, больные РПК были разделены на VI прогностически равноценных групп.

I группа включала 84 больных РПК, которым проводилось только хирургическое лечение. Чаще всего – брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, реже – брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмы, внутрибрюшная резекция, операция Гартмана-Инятова. II группа включала 76 больных, которым в предоперационном периоде проводилась крупнофракционная ЛТ. Дистанционная гамматерапия осуществлялась на аппаратах РОКУС-М и ТЕРАГАМ, обычно-с 4-х полей, в разовой очаговой дозе (РОД) – 5,0 Гр. в течение 5 дней ежедневно. Достигнутая за этот период времени суммарная очаговая доза (СОД) равнялась 25,0 Гр., что соответствовало СОД-40,0 Гр., подведенной в параметрах традиционного режима. Последующее оперативное вмешательство производилось не позднее, чем через 3-5 дней, во избежание манифестации лучевых реакций. В III группе из 72 больных предоперационное облучение в идентичном крупнофракционном режиме сочеталось с физическим радиомодифицирующим агентом – внутрисполостной локальной СВЧ-гипертермией. Локальное нагревание опухоли проводилось на аппарате «Плот» с частотой колебания 915 МГц, с помощью гибких СВЧ-излучателей, которые вводились в соответствии с локализацией опухоли в прямой кишке. Температурно-экспозиционный режим поддерживался в течение 45 минут при 43оС. Манипуляция проводилась через день, завершалась за 0,5 часа до лучевого воздействия: в 1,3 и 5 день недели. Радиобиологические концепции воздействия гипертермии на клеточные механизмы достаточно подробно освещены в специальной литературе /11/. Для клинической радиологии ожидаемым является как ее собственный цитотоксический эффект, так и селективное усиление воздействия ионизирующего излучения на гипоксичные опухолевые клетки. В IV группе 60 больных РПК ЛТ проводилась в пролонгированном режиме- в РОД-2,0 Гр. ежедневно до СОД-40,0 Гр. – дозы излучения, достаточной для дезактивации наиболее чувствительных опухолевых клеток и как правило не вызывающей выраженных лучевых реакций со стороны здоровых тканей и организма в целом. Для реализации этой программы требовалось 4 недели, с последующим 2-3 недельным перерывом перед плановой операцией. Этот интервал соблюдался и в других группах, в которых применялся данный режим. В V группу были включены 48 больных РПК, которым на фоне идентичного пролонгированного курса ЛТ вводился химиопрепарат- 5-фторурацил, как радиомодификатор-синхронизатор клеточного цикла. Исходя из того, что опухоли прямой кишки условно относятся к медленно растущим (ВУО = 109-118 дней), предполагалось, что количество клеток в фазе митоза должно быть невелико. Синхронизируя с по-

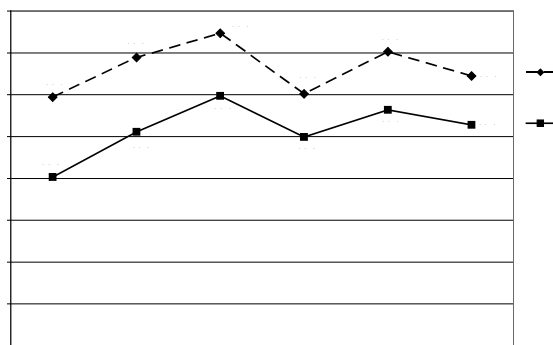


Диаграмма 1. Выживаемость больных РПК при различных методах предоперационной лучевой терапии

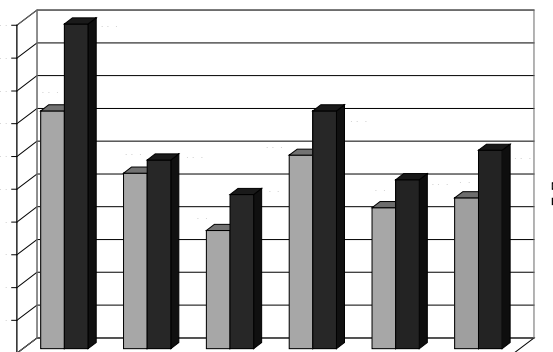


Диаграмма 2. Количество локо-регионарных рецидивов после комбинированного лечения больных рпк при различных вариантах предоперационной терапии (%)

Таблица 1. Степень лучевого патоморфоза опухоли у больных РПК при различных методах предоперационной лучевой терапии

Степень лучевого патоморфоза	Методы предоперационной терапии (М ± m %)				
	Крупно-фракционная ЛТ	Крупно-фракционная ЛТ + локальная ГТ	Пролонгированный курс ЛТ	Пролонгированный курс ЛТ + 5 ФУ	Пролонгированный курс ЛТ + ЭАС
I	30,1 ± 5,2	15,8 ± 4,3	8,7 ± 3,6	13,2 ± 4,9	5,2 ± 3,7
II	50,2 ± 5,7	20,3 ± 4,7	52,4 ± 6,4	28,7 ± 6,5	51,7 ± 8,4
III	15,1 ± 4,1	33,4 ± 5,5	28,6 ± 5,8	36,5 ± 6,9	28,9 ± 7,6
IV	4,6 ± 2,4	30,5 ± 5,4	10,3 ± 3,9	21,6 ± 5,9	14,2 ± 5,9

мощью 5- ФУ клетки опухоли при переходе из фазы Q1 в фазу S, мы рассчитывали эмпирически достичь последующего одномоментного перехода максимально возможного количества клеток в фазу M – наиболее чувствительную к ионизирующему излучению. Введение препарата осуществлялось внутривенно по 500 мг 3 раза в неделю, за 1-1,5 часа до облучения. Всего за курс вводилось 3,0-5,0 г 5-ФУ. В VI группе 35 больным РПК, наряду с предоперационным облучением в пролонгированном режиме, также применялся химический радиомодификатор-электроакцепторные соединения (ЭАС) – как правило, раствор Клииона. За 0,5 часа до облучения внутривенно капельно переливалось 100,0 ml раствора, 3 раза в неделю, всего 6-7 инфузий. Эти соединения в биологической среде в силу своей метаболической инертности, действуя подобно кислороду, проникают в гипоксические зоны опухоли и, акцептируя электрон, препятствуют постлучевой репарации макромолекул, что должно увеличивать степень лучевых повреждений опухоли [11].

Результаты и обсуждение

Все полученные данные были проанализированы и обработаны методами вариационной статистики. Критериями оценки полученных результатов были приняты непосредственные и отдаленные результаты, которые выражались в степени лучевого патоморфоза удаленной опухоли, длительности безрецидивного периода и выживаемости больных. Учитывались также количество и тяжесть осложнений в постоперационном периоде, длительность реконвалесценции и др.

После оперативного вмешательства, при исследовании удаленных тканей, наряду с уточнением стадии заболевания, состояния регионарных лимфоузлов, краев удаленного препарата, оценивалась и степень лучевого патоморфоза опухоли (по Г.А.Лавниковой), индуцированного предоперационной терапией. Полученные данные представлены в таблице №1.

Как видно из таблицы, степень лучевого патоморфоза (ЛП) у больных РПК при различных программах ЛТ была неодинаковой. В группах, где проводилась только ЛТ, III и IV степень была достигнута у 19,7% больных при крупнофрак-

ционном, коротком по времени курсе, и у 38,9% больных при пролонгированном. При этом суммарная очаговая доза (СОД) в обеих группах была одинаковой и равнялась 40 Гр. Очевидно, это обстоятельство было обусловлено необходимостью реализации лучевого эффекта с течением времени. Наибольший процент больных РПК с выраженным патоморфозом опухоли - III и IV степени - была зарегистрирована в группах, где в качестве радиомодификатора применялась СВЧ-гипертермия (63,9%) и 5-ФУ (58,1%). На основании полученных цифровых данных можно вывести ряд закономерностей. В частности, ЛТ в пролонгированном режиме к моменту операции вызывала более выраженный ЛП по сравнению с коротким крупнофракционным курсом; локальная СВЧ-гипертермия в сочетании с ЛТ – значительно более выраженный ЛП по сравнению с ЛТ в идентичном режиме; химический радиомодификатор 5-ФУ в сочетании с ЛТ в пролонгированном режиме существенно повышал процент больных РПК с выраженным ЛП, в то время, как сочетание данного режима ЛТ с другим радиомодификатором-ЭАС- существенных изменений степени ЛП не вызвало ($p \leq 0,05$). Возможно, в данной ситуации этот факт обусловлен сравнительно низким пулом гипоксических клеток в операбельных опухолях прямой кишки.

Далее, для оценки результатов проведенной терапии была изучена годовая выживаемость больных РПК в анализируемых 6 группах больных. Результаты анализа приведены в диаграмме 1.

Анализируя полученные данные, можно было заключить, что предоперационная терапия улучшала показатели выживаемости во всех группах больных ($p \leq 0,05$). Из этой же диаграммы видно, что наиболее высокий процент 3-хлетней и 5-летней выживаемости больных РПК после радикальных операций был в тех группах, где в предоперационном периоде проводилась крупнофракционная ЛТ в сочетании с локальной ГТ, а также - ЛТ в пролонгированном режиме при сочетании с химическим радиомодификатором 5 ФУ. Исходя из того, что положительные результаты показателей выживаемости прямо коррелировали с высокой степенью лучевого патоморфоза, можно было подтвердить вывод, что степень лучевого патоморфоза опухоли к моменту операции является прогностическим фактором для результатов комбинированного лечения больных РПК.

Исходя из современных позиций оценки результатов лечения онкологических больных, в которых одним из приоритетных факторов является качество их жизни, мы проанализировали длительность безрецидивного периода при различных методах предоперационной терапии. Количество зарегистрированных рецидивов представлено в диаграмме 2.

Выявлено, что наибольший процент рецидивов у больных РПК отмечался в группе больных, где радикальной операции не предшествовала предоперационная терапия. Предоперационная ЛТ улучшила 3-х и 5-летние результаты, независимо от режима фракционирования дозы ионизирующего излучения, при тенденции к лучшим показателям 5-летней выживаемости при крупнофракционном курсе по сравнению с пролонгированным. Использование ЭАС в сочетании с ЛТ заметно не повлияло на эффективность лечения. Выраженная тенденция к улучшению результатов просматривалась при сочетании ЛТ с 5-ФУ, а наилучшие результаты у больных РПК отмечались при сочетании ЛТ и локальной ГТ ($p \leq 0,05$).

Одновременно было выявлено, что у больных РПК всех 6 групп длительность жизни и безрецидивная выживаемость коррелировала со степенью инвазии стенки кишки, характеризующейся символом Т, наличием или отсутствием регионарных метастазов на момент начала лечения (N), локализацией опухоли в органе, степенью гистологической дифференцировки опухоли. Наилучшие результаты в рамках данных параметров отмечены при стадиях T1-2N0M0, расположении опухоли в верхних отделах кишки и высокодифференцированных опухолях.

У 68 пациентов (18,1%) из 375, наряду с loco-регионарными метастазами, на протяжении 5 лет были выявлены и метастазы в отдаленные органы - в большинстве случаев - в печень, реже - в кости или легкие, у 1 больного - в головной мозг. У 46 больных (12,2%) за этот же период времени отдаленные метастазы отмечались без наличия loco-регионарного рецидива. В то же время, статистически достоверной корреляции между методом лечения и отдаленным метастазированием у больных РПК в рамках данного исследования не выявлено. Оценивались также степень интраоперационной кровопотери, осложнения нагноительного характера при заживлении раны, декомпенсированные состояния со стороны органов и систем в постоперационный период. В среднем из 375 больных у 129 (34,4%) отмечались реакции и осложнения, как слабо выраженные, так и более значимые. Интраоперационная кровопотеря во всех группах была примерно одинаковой, скорость заживления раны после ЛТ в сочетании с ГТ даже проявляла тенденцию к ускорению, но количество урологических осложнений (в основном, циститов) было несколько выше при предоперационной ЛТ крупными фракциями. Все вышеперечисленные нарушения корректировались симптоматически, медикаментозно и на длительность реконвалесценции не повлияли.

Заключение

На основании анализа результатов комбинированного лечения 375 больных РПК, распределенных, в зависимости

от метода терапии, предшествовавшей радикальной операции, на 6 прогностически равноценных групп, выявлено, что предоперационная терапия улучшает непосредственные результаты, выраженные в степени ЛП опухоли, что отражается на выживаемости больных и количестве рецидивов. Лучшие результаты при прогностически менее благоприятных случаях получены при сочетании крупнофракционной ЛТ с локальной ГТ, а также пролонгированном курсе ЛТ при сочетании с химиопрепаратом 5-ФУ. При прогностически более благоприятных формах РПК заметных различий при различных вариантах предоперационной ЛТ не выявлено. Статистически значимых различий по количеству интра- и послеоперационных осложнений при анализируемых методах лечения больных РПК не отмечено.

Литература

1. Алиев Д.А., Зейналов Р.С., Марданлы Ф.А. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Азербайджанской Республике в 2003 году. // *Azerbaijan Journal of oncology and hematology* -2004-№2-С.3-11.
2. Алиев Д.А., Мамедов М.К., Марданлы Ф.А. Повышение заболеваемости злокачественными опухолями как поддержка научно-технического и социально-экономического прогресса. // *Azerbaijan Journal of oncology and hematology* -2009-№2-С.3-9.
3. Барсуков Ю.А., Ткачев С.И., Олтаржевская Н.Д. и др. Полирадиомодификация в комбинированном и комплексном лечении больных раком прямой кишки // *Материалы X Российского онкологического конгресса*. -М., 2006, С 95-98.
4. Гордеев С.С. *American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2010. Annual Meeting: Abstract*, 3507.
5. Дворниченко В.В., Афанасьев С.Г., Шелехов А.В., Москвина Н.А. Лучевая терапия в комбинированном лечении рака прямой кишки (обзор литературы) // *Сибирский онкологический журнал*-2009-№1- С. 72-77.
6. Мартынюк В.В. Рак толстой кишки (заболеваемость, смертность, факторы риска, скрининг). // *Практическая онкология: Избранные лекции СПб*, -2004-С.151-161.
7. Помазкин В.И. Метаанализ влияния опыта и специализации на отдаленные результаты хирургического лечения колоректального рака. // *Вопросы онкологии*-2010-№3-Т.56- С.359-365
8. Сидорченко В.О. Лучевая терапия злокачественных опухолей прямой кишки. // *Медицина-Москва-2003*- 270 стр.
9. Чиссов В.И., Старинский В.В., Петров Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2007г. (заболеваемость и смертность)-М.:АнтиФ, 2009 - 241 стр.
10. Borowski D., Ratcliffe A., Kelly S. et al. The effect of volume and specialization on short-term outcome in surgery for colorectal cancer // *Colorectal. Dis.* -2004- Vol. 6 (Suppl. 1). -P.54.
11. Gordon Styll.- *Basic Clinical Radiology*, Third Eds., London, 2002.
12. Greenle R.T., Murray T., Bolden S. et al. *Cancer Statistics* // *CA Cancer J.-Clin.* 50-2007- p.7-33
13. Irvin T., Marriot S. The results of specialists and general surgeons in colorectal cancer surgery // *Colorectal. Dis.* -2004.- Vol. 6 (Suppl. 1). - P.55.
14. Jemal A., Murray T., Ward E. et al. // *Cancer statistics-2005-CA cancer J.*
15. Wolff B.G., Fleshman J.W., Beek D.E. et al // *The ASCRS. Text book of Colon and Rectal Surgery*-2007.

Профилактика постлучевых осложнений у пациенток с раком шейки матки

Батырова Л. М.

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

Вероятность постлучевых осложнений органов смежных с маткой – зависит от многих факторов – имеет разную степень выраженности и являются актуальной проблемой, требующей дальнейшего изучения и изыскания путей решения. (1,3).

Комплексное решение этой проблемы с учетом оптимизации лучевого лечения и особенностей опухолевого процесса позволит улучшить качество жизни пациентов пролеченных по поводу злокачественной опухоли шейки матки. (1,2,5,9)

Установленная взаимосвязь возникновения постлучевых осложнений с величиной суммарной поглощенной дозы, режима фракционирования, объема облучаемых тканей, сопутствующих заболеваний органов, входящих в зону облучения – определяет необходимость проводить своевременную коррекцию умеренно- и выраженных лучевых реакций. (3,4,7)

Таким образом, цель данного исследования основана на оптимизации методов профилактики лучевых осложнений у больных злокачественными новообразованиями шейки матки.

За период с 2007-2010 годы в областном онкологическом диспансере города Талдыкорган было пролечено 40 больных и постлучевые осложнения в органах мочевой системы наблюдались у 0.4% больных, которым проводили сочетанную терапию по поводу злокачественных заболеваний рака шейки матки.

Лучевые циститы чаще наблюдались у женщин, лечившихся по поводу рака шейки матки в основном III и IV стадии, когда применялись большие дозы облучения. Лучевые циститы в основном были легкой формы, характеризовались только учащенным, иногда с резями, мочеиспусканием, равномерной гиперемией слизистой мочевого пузыря, наличием лейкоцитов и эритроцитов в моче.

Постлучевые изменения в органах наступают не сразу после лечения. В период от 3 мес до 1 года появляются ранние лучевые реакции, а поздние лучевые реакции наступают в период от 1 года до 5- 10 лет, а иногда и более (до 30 лет) после окончания лучевого лечения

Для уменьшения уровней поглощенных доз в области соседних с маткой органов используются защитные блоки, что оказывает существенное влияние на степень тяжести лучевых повреждений.

Совершенствуя точность укладок пациентов мы достигаем существенного расширения терапевтического интервала лучевого воздействия без возрастания лучевых осложнений. (1,3,4,8)

Коррекция общесоматического статуса больных проводится на всех этапах лечения и после, так как является обязательным элементом профилактики лучевых повреждений.

Назначение препаратов регулирующих функцию кишечника и мочевого пузыря, назначение витаминов, ферментов, препаратов улучшающих тканевую кровоток, обладающих противовоспалительным, антиоксидантным действием. (2,5,7).

Иммунный статус у больных злокачественными новообразованиями шейки матки перенесших лучевую

терапию, характеризуется глубокими изменениями в Т-клеточном звене, что создает предпосылки для развития инфекционных процессов различного генеза.

Поэтому, терапия постлучевых реакций и осложнений направлена на повышение сопротивляемости организма, уменьшение проницаемости тканей. (7,9)

Подводя итог, факторы, определяющие развитие лучевых осложнений необходимо принимать во внимание при планировании лечения. (2,5,8)

Несомненно важным элементом профилактики развития как ранних, так и поздних лучевых осложнений является адекватная коррекция общесоматического статуса больных до начала лучевой терапии и назначение лечебных микроклизм, а, по показаниям, различных медикаментозных средств, в том числе регулирующих и функцию кишечника. Эти мероприятия необходимо проводить также во время облучения и в ближайшее время после его окончания (3,6).

Именно комплексное решение проблем профилактики – приводит к сокращению сроков достижения положительного эффекта, снижению частоты повторных обострений, а также к увеличению продолжительности между началом ремиссии и обострением лучевых повреждений, приводит к еще более выраженным положительным эффектам (1,4,9).

Список литературы

1. Аветисов Г.М. Синдромы острой лучевой болезни. Клинические проявления, профилактика и лечение // М. - ВЦМК «Защита». - 2003. - 244 с.
2. Антонов В.Г., Козлов В.К. Патогенез онкологических заболеваний, цитоплазматические и молекулярно-генетические механизмы иммунной резистентности малигнизированных клеток // Цитокины и воспаление. - 2004. - Т. 3. - № 2. - С. 23-33.
3. Бардычев М.С. Местные лучевые повреждения / М.С. Бардычев, А.Ф. Цыб. - М.: Медицина, 1985. - 240 с.
4. Бычкова Е.Ю. Оппортунистические инфекции у онкологических больных (эпидемиологические и иммунологические аспекты): Автореф. дис. канд. мед. наук. - Омск, 2003. - 18с.
5. Васин М. В. Средства профилактики и лечения лучевых поражений: Учебное пособие // М. - 2001. - 312 е.
6. Горбунова В.А., Бредер В.В. Качество жизни онкологических больных // Материалы 4 Рос. Онк. Конф. - М. - 2000. - С. 125 - 127.
7. Иваницкая В.И.; Кисличенко В.А., Герштейн И.Г. и др. Осложнения лучевой терапии у онкологических больных // Киев. - Здоровья. - 1989. - 184 с.
8. Лучевая терапия в лечении рака. Практическое руководство. // Всемирная организация здравоохранения. - Лондон - Нью-Йорк — Токио - Мельбурн - Мадрас. - 2000. - С. 338.
9. Ярилин А.А. Радиация и иммунитет. Вмешательство ионизирующих излучений в ключевые иммунные процессы // Радиационная биология. Радиоэкология. - 1999. - Т. 39. - № 1. - С. 181-189.

Консервативное лечение больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста

К.И.Ниязбекова

ГККП Алматинский региональный онкологический диспансер

Консервативное лечение больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста

К.И.Ниязбекова

Алматинский региональный онкологический диспансер

В данной статье обобщён опыт по консервативному лечению рака молочной железы у больных пожилого и старческого возраста.

Treatment of mammary cancer in elderly and senile age

K.I.Niyazbekova

Almaty Regional Oncological Hospital

Current article generalized experience of Almaty regional oncological hospital on treatment of mammary cancer in elderly and senile age.

Сүт безінің қатерлі ісігіне шалдыққан егде және қарт жасындағы науқастардың консервативті емі

К.И.Ниязбекова

Алматы аймақтық онкологиялық диспансері

Осы мақалада Алматы аймақтық онкологиялық диспансеріндегі сүт безінің қатерлі ісігіне шалдыққан егде және қарт жасындағы науқастарды консервативті емдеуден кейінгі нәтижелері жинақталып көрсетілген.

В структуре онкопатологии женского населения Республики Казахстан за последние годы рак молочной железы переместился с пятого на первое место [1].

Риск развития рака молочной железы в возрасте старше 65 лет в 150 раз выше таковой у лиц моложе 30 лет. Женщины с раком молочной железы пожилого и старческого возраста чаще обращаются в специализированные лечебные учреждения с уже распространенным процессом и наличием сопутствующей патологии, которая влияет на течение заболевания, выбор тактики лечения и выживаемость [2].

Несмотря на то, что в последние годы появилось отдельные публикации о возможности консервативного лечения рака молочной железы у женщин пожилого и старческого возраста, в частности с помощью гормональной терапии (ГТ), либо сочетания ГТ с лучевой терапией, которые с успехом могут проводиться даже в амбулаторных условиях, вопросы проведения полихимиотерапии требуют дальнейшего изучения [3,4,5].

Проведен ретроспективный анализ историй болезни и амбулаторных карт больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста (60-80 лет и выше), получавших специализированное лечение в условиях Алматинского регионального онкологического диспансера в период с 2004г по 2010г.

Женщины с раком молочной железы пожилого и старческого возраста были в глубокой менопаузе сроком 10-30 лет.

Проводилось комплексное обследование, включающее клинико-инструментальные (рентгенологические, ультразвуковые и др), лабораторные и морфологические исследования, после которых устанавливался не только окончательный диагноз, но и выявлялась сопутствующая патология (у многих больных впервые).

Диагноз был подтвержден не только цитологически и морфологически, но и проводилось иммуногистохимическое исследование с определением рецепторов на онкомаркеры.

На догоспитальном этапе морфологически верифицирован РМЖ у 85 больных, из них женщины с сопутствующей патологией 55 (64%). После верификации процесса определялась дальнейшая тактика лечения с учетом стадии процесса и сопутствующей патологии.

Соответственно классификации TNM (ВОЗ, 1998 год), в

группе больных, получивших консервативное лечение, у 40 больных (47%) установлено II стадия опухолевого процесса, у 42 (49,4%) больных – III стадия, и у 3 (3,5%) больных IV стадия.

У больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста сопутствующая патология распределилась следующим образом:

Наиболее часто (30,5%) больные имели сердечно-сосудистую патологию (ИБС, стенокардия, артериальная гипертензия, в анамнезе инфаркт миокарда) - 26 женщин.

Сахарный диабет I или II типа отмечен у 17 (20%) больных раком молочной железы (у 6 больных впервые выявленный в условиях нашей клиники). III-группа – 12 (14,1%) больных с прочими сопутствующими заболеваниями (бронхиальная астма, хронические заболевания легких, заболевания мочеполовой системы и т.д.).

Наличие сопутствующей патологии и распространенность опухолевого процесса у 55 больных (64,7%) были одной из основных причин проведения консервативной терапии. В некоторых случаях причиной проведения консервативной терапии был отказ больных от хирургического лечения. Выявление сопутствующей патологии способствовало проведению дополнительных диагностическо-консультативных и лечебных мероприятий, направленных на улучшение статуса больных при проведении запланированного консервативного лечения.

ПХТ проводилась по схемам CMF (циклофосфан 600 мг/м² в 1-й день, метотрексат 40 мг/м² в 1-й и 8 дни, 5-фторурацил 600 мг/м² в 1-й и 8-й дни), CAF (циклофосфан 500 мг/м² в 1-й день, доксорубин 50 мг/м² в 1-й и 8 дни, 5-фторурацил 500 мг/м² в 1-й и 8-й дни), CAMF

Таблица №1. Распределение больных РМЖ пожилого и старческого возраста по сопутствующей патологии

Возраст	I-группа сердечно- сосудистая патология	II-группа сахарный диабет	III-группа п р о ч и е заболевания
60-70 лет	18	11	3
70-80 лет	6	5	8
80 и выше	2	1	1
Всего	26	17	12

(циклофосфан 600 мг/м² в 1-день, метотрексат 50 мг/м² в 1-й и 8 дни, 5-фторурацил 600мг/м² в 1-й и 8-день, доксорубин 50 мг/м² в 1-й день) 3-6 курсов. ГТ включала в себя длительный (более 5 лет) прием больными тамоксифена.

Токсические проявления во время и после проведения ПХТ оценивали соответственно шкале токсичности (NCIC).

При соответствующей коррекции и сопроводительной терапии токсические проявления не требовали прекращения запланированного лечения.

Таким образом, консервативное лечение больных раком молочной железы в пожилом и старческом возрасте является методом выбора при наличии сопутствующей патологии и у больных, отказавшихся от хирургического лечения.

Список использованной литературы:

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Ж. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2009 году (статистические материалы), Алматы, 2010.
2. Абдрахманова А.Ж. К эпидемиологии рака молочной железы в Казахстане. Актуальные вопросы современной онкологии. Сборник научных трудов. Бишкек, 1998 год.
3. Абисатов Х.А. Клиническая онкология, том 2 «Арыс», Алматы, 2007.
4. Иванов В.М., Летягин В.П., Высотская И.В. Лечение рака молочной железы у больных пожилого и старческого возраста. М., 2001.
5. Особенности лечения рака у пожилых людей // Материалы Российского национального конгресса «Человек и лекарство» под редакцией В.А.Горбунова.-М., 1999.

Правила оформления рукописей для журнала «Онкология и радиология Казахстана»

- Формат рукописи - А4.
- Текст должен быть написан в программе Word с использованием шрифта Times New Roman, кеглем 14, с пробелами полуторными.
- Статья подается на CD-диске со вкладышем, на котором обозначается имя автора и название статьи.
- Объем рукописи: научная статья - до 5 стр, случай из практики - 3-4 стр.; обзор, лекция - не более 8 стр.
- Список литературы - минимально необходимый.
- Рукопись визируется руководителем учреждения (кафедры), научным руководителем, скрепляется печатью.
- К рукописи прилагается резюме на казахском, русском, английском языках, ключевые слова, УДК.
- В конце рукописи - сведения об авторах: степень, должность, количество имеющихся публикаций.
- Адрес, телефоны (можно и мобильный), электронная почта.
- Рукопись подписывается лично автором как свидетельство полной аутентичности данных материала, ответственности автора за содержание рукописи.

Распределение гистологических типов рака легкого по регионам Республики Азербайджан

Солтанов А.А.

Национальный Центр Онкологии, Баку

Распределение гистологических типов рака легкого по регионам Республики Азербайджан.

А.А.Солтанов

Национальный Центр Онкологии, Баку

В Азербайджане, в структуре заболеваемости и смертности злокачественных опухолей среди мужчин на первом месте стоит рак легкого. Изучено распространение различных гистопатологических форм рака легкого в Азербайджане, также влияния отдельных факторов, таких как пол, региональных особенностей, вредных привычек на гистопатологию рака легкого. Материалами исследования явились истории болезни 876 больных обследованные и получившие лечение по поводу рака легкого в Национальном Центре Онкологии и Бакинском городском диспансере в период с 1995 по 2003 год. Территория Азербайджанской республики была условно разделена на 5 регионов, куда были включены отдельные административные районы, и больные были распределены по этим регионам, согласно их место жительства. Во всех регионах наиболее часто встречаемым гистологическим типом оказался плоскоклеточный рак. Самый высокий показатель плоскоклеточного рака 230 (55,56%) отмечен в регионе «Большой Кавказ». Этот гистологический тип независимо от пола превалирует и составляет 54,41% среди всех форм рака легкого. Плоскоклеточный рак диагностирован у 213 (59%), аденокарцинома у 37 (10,25%), мелкоклеточный рак у 6 (1,66%), крупноклеточный рак у 6 (1,66%), смешанный рак у 61 (16,9%), другие формы (недифференцированные) у 38 (10,53%) среди 361 больных с центральным раком легкого. Выявлено, что табакокурение и одновременное употребление спиртные напитки повышает риск развития рака легкого. Больше половины (53,5%) больных помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки.

Рак легкого – одна из самых распространенных форм злокачественных новообразований [4,9]. Ежегодно отмечается в мире с 1.3 миллион новых случаев заболеваемости данной нозологической формой злокачественных новообразований, диагностируемых каждый год [6].

В Азербайджане, как и во всем мире, в структуре заболеваемости и смертности злокачественных опухолей среди мужчин на первом месте стоит рак легкого [3]. Так, среди лиц мужского пола, заболеваемость раком легких у нас в республике составляет около 20%, а у женщин 3,3%. Показатели смертности от рака легкого в Азербайджане последние 10 лет не изменились [2].

Ряд авторов описывают изменение показателей заболеваемости и смертности в Европейской зоне в XX столетии в зависимости от гистологических подтипов рака легких [8].

Распределение рака легкого географически неоднородно [7]. Показатели заболеваемости рака легкого резко меняются между различными областями мира. Самые высокие показатели заболеваемости рака легкого у мужчин

Distribution Of Different Histological Types Of Lung Cancer In Regions Of Azerbaijan

Soltanov A.A.

National Center of Oncology, Baku.

The lung cancer is at the first place due to morbidity and mortality in the structure of oncological diseases among males in Azerbaijan. The spread of the different histological forms of lung cancer in Azerbaijan, and also the influence certain factors, like a sex, regional features, bad habits, to histopathology of lung cancer were researched. The materials of study were the case histories of 876 patients, who were observed in National Center of Oncology and Baku's City's dispensary during period of time from 1995 to 2003. The territory of Azerbaijan was conditionally divided to 5 regions, in which separate administrative regions were included, and patients were distributing to these due to their domicile. In all regions the most common histological type was squamous cell carcinoma. The highest rate of squamous cell carcinoma 230 (55.56%) was noted in The Big Caucasus region. This histological type independent from sex amount 54.41% between other types of lung cancer. The squamous cell carcinoma was diagnosed in 213 (59%), adenocarcinoma in 37 (10.25%), small cell carcinoma in 6 patients (1.66%), large cell carcinoma in 6 (10.53%) patients within 361 with central lung cancer. It was revealed that smoking and alcoholic drinks increases risk of lung cancer. More than the half of the patients (53.5%) besides smoking were alcoholic drinkers.

отмечены в Европе, особенно в центральной и Восточной Европе, и в северной Америке. В пределах Европы самые высокие мужские показатели заболеваемости отмечены в Венгрии и Польши, а самые низкие в Швеции и Мальте [6].

Рак легкого могут быть разделены на две главные типы: мелкоклеточный рак (SCLC) и немелкоклеточный рак легкого (NSCLC) [1, 14, 11]. Мелкоклеточный рак (SCLC) - самая агрессивная форма рака легкого, с большим потенциалом к метастазирования, чем другие типы рака легкого. Почти все больные (более чем 95 %) у которых диагностирован мелкоклеточный рак легкого, являются запущенными и ранее курильщиками.

Немелкоклеточный рак легкого (NSCLC) - гетерогенная группа, основные подтипы – плоскоклеточный рак и аденокарцинома легкого.

Эти опухоли способны расти в центре легкого, и приобретать большие размеры. Аденокарциномы обычно развиваются в периферии легкого. Хотя это распространенный тип рака легкого, наиболее часто отмечается у некурящих [13], однако за последние многие годы курение считается все больше причиной аденокарциномы легкого [18].

Плоскоклеточный рак легкого составляет более высокую пропорцию рака легкого [17], диагностированных среди мужчин, чем женщин, тогда как частота аденокарциномы легкого больше, среди женщин по сравнению с мужчинами [14]. Среди мужчин, плоскоклеточный рак был самым частым гистологическим типом рака легкого в Корее (46 %), Франции (41 %) и Великобритании (40 %), тогда как аденокарцинома

Таблица 1. Распространение рака легкого по регионам Республики и гистологическим типам опухолей

Гистология	«Большой Кавказ»	«Куринская межгорная низменность»	«Малый Кавказ»	«Нахичевань»	«Ленкорань»	Итого
Плоскоклеточный	236 73,29%	49 15,22%	21 6,52%	4 1,24%	12 3,73%	322 54,48%
Аденокарцинома	50 75,76%	13 19,7%	-	-	3 4,55%	66 11,17%
Мелкоклеточный	9 81,82%	1 9,09%	1 9,09%	-	-	11 1,86%
Крупноклеточный	6 100%	-	-	-	-	6 1,02%
прочие	78 63,41%	25 20,33%	9 7,32%	1 0,81%	10 8,13%	123 20,81%
Диморф (плоско+аднокарц)	45 71,43%	8 12,70%	8 12,70%	-	2 3,17%	63 10,66%
Итого	424 71,74%	96 16,24%	39 6,60%	5 0,85%	27 4,57%	591 100%

больше всего была распространена в Соединенных Штатах (31 %), Канаде (31 %), Швеции (30 %), и Австралии (29 %). За исключением Великобритании (где 28 % случаев рака легкого среди женщин был плоскоклеточный рак), аденокарцинома легких составляли самую большую часть рака легкого среди женщин по сравнению указанных стран (в пределах от 38 % в Соединенных Штатах до 69 % в Японии) [5]. Мелкоклеточный рак легкого составил от 14 % (Австралия и Япония) до 17 % (Корея и Великобритания) рака легкого среди мужчин, и от 9 % (Япония) до 22 % (Великобритания) среди женщин [19].

Несмотря на обширное исследование, механизмы, приводящие к этим различным типам рака легкого, остаются неизученными. За последние десятилетия были и географические и временные изменения в распределении типов рака легкого [10, 12, 15].

Знание этих модификаций может помочь определить основные новые этиологические и патологические механизмы рака легкого. Аденокарцинома легкого стала ведущим гистологическим типом в Северной Америке [16], Европе [10] и Азии [12].

Целью

настоящего исследования явилось изучение распространения различных гистологических форм рака легкого в Азербайджане в зависимости от возможных факторов риска.

Материал и методы

Материалами исследования явились данные 876 больных раком легкого, обследованных в Национальном Центре Онкологии за период 1995–2003 гг. Средний возраст больных составил 53 года. Диагноз рака легкого установлен у 29,2% больных на основании цитологического, у 53,9% гистологического и у 16,9% обоих методов исследования. У 591 (67,5%) больных удалось определить гистологический тип опухоли. Плоскоклеточный рак установлен у 322 (54,5%), аденокарцинома у 66 (11,2%), мелкоклеточный рак у 11 (1,9%), крупноклеточный рак у 6 (1%), смешанный рак (плоскоклеточный рак + аденокарцинома) у 63 (10,6%) и прочие формы рака диагностированы у 123 (20,8%) больных.

Территория Азербайджанской республики была условно разделена на 5 регионов, куда были включены отдельные административные районы. Эти регионы отличаются климатогеографическими условиями и культурно-традиционными обычаями населения. В сравниваемых группах учтены региональные особенности гистологических типов рака легкого.

Регион «Большой Кавказ» охватывает в основном природную область Большого Кавказа, занимает первое место по площади, численности населения,

городских жителей и экономической мощи.

Более половины территории региона «Куринская межгорная низменность» расположено ниже уровня моря. Будучи первым, по площади и вторым – по численности населения экономическим регионом республики, развит химической промышленностью. В регионе также развита химическая промышленность, машиностроение, легкая, пищевая промышленность.

Регион «Малый Кавказ» простирается от границ с Грузией до Иранской границы. 28% территории республики, 23% населения приходится на долю этого района. Сложность рельефа дает возможность выделить здесь 4 зоны с точки зрения освоенности территории: Гянджа-Газахская наклонная равнина, где развито орошаемое земледелие; предгорная зона – земледелие и животноводство; среднегорья – богарное земледелие (здесь находится основные месторождения полезных ископаемых); высокогорная зона – летние пастбища и животноводство.

IV регион Республики «Нахичевань» расположено отдельно от основной территории Азербайджана, на границе с Турцией, Ираном и Арменией и имеет резкий континентальный климат и сложный рельеф

«Ленкорань» – расположена на юго-востоке республики. Пограничное расположение с Ираном и близость к морю – благоприятные черты ЭГП (экономико-географическое положение). Наличие влажного субтропического климата, низменного и низкогогорного рельефа, плодородные почвы считаются положительными чертами природных условий. 25% населения живет в городах. Основу экономики района составляет АПК (агропромышленный комплекс).

Из 565 опрошенных больных 148 (26,02%) были только курильщиками, 243 (43,01%) помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки (алкоголь), 4 (0,71%) только употребляли спиртные напитки, только 171 (30,27%) отрицали вредных привычек у них в анамнезе. Сформированные по отдельным признакам группы больных подвергнуты однофакторным и многофакторным анализам. Статистическую обработку полученных данных проводили с применением пакета программ STATISTICA-6 Base (Basic Statistical Analysis Methods) с использованием 2-Way table summary. Из-за отсутствия данных в некоторых историях болезни по отдельным изучаемым вопросам, эти больные исключены из исследования самой программой автоматически. Поэтому общее число больных в сравниваемых группах отличались.

Результаты и обсуждение

Анализируя данные по территориальной распространенности рака легкого среди населения Азербайджанской республики, следует констатировать, что во всех регионах наиболее часто встречаемым гистологическим типом оказался плоскоклеточный рак.

Плоскоклеточный рак диагностирован у 322 (54,5%) больных. Высокая частота плоскоклеточного рака 236 (73,3%) отмечен в регионе «Большой Кавказ». Это можно связать с большой плотностью населения в этом регионе, по сравнению с другими, а также наличием в этом регионе таких крупных промышленных городов, как Баку и Сумгаит. Низкая частота плоскоклеточного рака наблюдалась в регионе «Нахичевань» (1,24%), находящемся на гористой местности, и с отсутствием индустриализации в городах этого региона (Рис.1 и табл.1).

Аденокарцинома легких диагностирована у 66 (11,2%) больных. Среди них 50 (75,8%) больных были жителями региона «Большой Кавказ», 13 (19,7%) региона «Куринской межгорной низменности», 3 (4,5%) жителями

Таблица 2. Распределение больных раком легкого по полу и гистологическим типам опухоли

Пол больных	Плоскоклеточный	Аденокарцинома	Мелкоклеточный	Крупноклеточный	прочие	Диморф (плоско+Аденокарцинома)	итого
Мужчины	288	57	10	4	110	62	531
	54,24%	10,73%	1,88%	0,75%	20,72%	11,68%	89,85%
Женщины	34	9	1	2	13	1	60
	56,67%	15,00%	1,67%	3,33%	21,67%	1,67%	10,15%
Итого	322	66	11	6	123	63	591
	54,48%	11,17%	1,86%	1,02%	20,81%	10,66%	100%

Таблица 3. Распределение больных раком легкого по гистологической структуре и наличия вредных привычек в анамнезе

Вредные привычки	Плоскоклеточный	Аденокарцинома	Мелкоклеточный	Крупноклеточный	прочие	Диморф (плоско+аденокарц)	итого
Курение	90 61.22%	14 9.52%	2 1.36%	1 0.68%	23 15.65%	17 11.56%	147 26.02%
Употребление спиртных напитков	2 50.00%	2 50.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4 .71%
Одновременное употребление табака и алкоголя	130 53.50%	20 8.23%	3 1.23%	1 0.41%	59 24.28%	30 12.35%	243 43.01%
Вредных привычек отрицает	88 51.46%	24 14.04%	5 2.92%	4 2.34%	35 20.47%	15 8.77%	171 30.27%
Итого	310 54.87%	60 10,62%	10 1.77%	6 1.06%	117 20.71%	62 10.97%	565 100.00%

региона «Ленкорань». Определенную связь гистологических типов рака легкого регионами Республики выявить не удалось. Отмечено высокая частота плоскоклеточного и недифференцированного («прочие») типов рака легкого.

Независимо от регионов, можно заметить, что больные раком легкого мужского пола встречались в несколько раз чаще, чем женского. Соотношение больных мужчин и женщин для Республики составило 8,8/1. Половое соотношение для плоскоклеточного и недифференцированного («прочие») рака легкого составило 8,5/1, для аденокарциномы 6,3/1, мелкоклеточного рака 10/1, крупноклеточного рака 2/1 и смешанного рака 62/1.

Половое соотношение для отдельных гистологических типов рака легкого изучено и для отдельных регионов (Табл.2 и Рис.2).

Мужское и женское соотношение плоскоклеточного рака в регионе «Большой Кавказ» было, почти одинаково Республиканского соотношения, составив 8,8/1 (212 мужчин/24 женщины). Это соотношение составило для региона «Куриной межгорной низменности» 11,2/1 (45м/4ж), для «Малого Кавказ» 6/1 (18м/3ж), для «Нахичевань» 4/0 (4м/0ж), для региона «Ленкорань» 3/1 (9м/3ж).

Для аденокарциномы это соотношение в регионе «Большой Кавказ» составило 4,5/1 (41муж./9 жен.), для региона «Куриная межгорная низменность» 13 (13м/0ж), для региона «Ленкорань» 3 (3м/0ж). В остальных регионах этот тип опухоли не было диагностировано.

Для мелкоклеточного рака это соотношение в регионе «Большой Кавказ» составило 8/1 (8муж./1 жен.), для региона «Куриная межгорная низменность» 1 (1м/0ж), для региона «Малый Кавказ» 1 (1м/0ж). В остальных регионах этот тип опухоли не было диагностировано.

Все 6 случаев крупноклеточного рака легкого диагностированы у жителей региона «Большой Кавказ».

Для недифференцированных («прочие») форм рака легкого половое соотношение для регионов: «Большой Кавказ» - 5,5/1 (66м/12ж); «Куриная межгорная низменность» - 24/1 (24м/1ж); «Малый Кавказ» - 9 (9м/0ж); «Нахичевань» - 1 (1ж/0ж) и «Ленкорань» - 10 (10м/0ж).

Для смешанного (плоскоклеточный + аденокарци-

нома) рака легкого половое соотношение для регионов составило: «Большой Кавказ» - 44/1 (44м/1ж); «Куриная межгорная низменность» - 8 (8м/0ж); «Малый Кавказ» - 8 (8м/0ж); и «Ленкорань» - 2 (2м/0ж).

Плоскоклеточный рак легкого среди мужчин, так и среди женщин превалирует и составляет большую часть (54,48%) всех форм рака (табл.№2). Независимо от гистологической структуры опухоли соотношение больных по полу составило как 9/1. Из 591 больных раком легкого 89,85% были мужчины, 10,15% женщины.

Анализируя данные больных, выявлено, что наличие или отсутствие вредных привычек у них в анамнезе были внесены только в 565 истории болезни. 147 (26%) из них были курильщиками, 4 (0,71%) только употребляли спиртные напитки, 243 (43%) помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки, только 171 (30,3%) отрицали нали-

чия у них вредных привычек. Среди больных плоскоклеточным раком 130 (41,94% из 310), аденокарциномой легкого 20 (33,33% из 60), смешанной формой рака 30 (48,39% из 62), прочими формами рака 59 (50,43% из 117) больных помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки.

Плоскоклеточный рак превалирует по сравнению другими формами рака. Плоскоклеточный рак одинаково часто диагностирован среди этих сравниваемых групп. Среди курильщиков плоскоклеточный рак выявлен у 61,22%, среди больных которые употребляли только спиртные напитки у 50%, среди больных, которые помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки у 53,50% и среди больных которые отрицали вредных привычек в анамнезе 51,46% случаев. Высокий процент плоскоклеточного рака среди больных (88 (51,46%) из 171), которые отрицали вредных привычек у них в анамнезе, возможно, объясняется тем, что большинство 120 (70,2%) из них явились городскими жителями. Роль загрязнения окружающей городской среды у этой категории больных неизбежно.

Изучены гистологических типов рака легкого среди больных с различным клинико-анатомическим ростом опухоли. Среди 361 больных с центральным раком легкого плоскоклеточный рак диагностирован у 213 (59%), аденокарцинома у 37 (10,25%), мелкоклеточный рак у 6 (1,66%), крупноклеточный рак у 6 (1,66%), смешанный рак у 61 (16,9%), другие формы (недифференцированные) у 38 (10,53%).

Среди 124 больных с периферическим раком легкого плоскоклеточный рак диагностирован у 56 (45,15%), аденокарцинома у 16 (12,9%), мелкоклеточный рак у 3 (2,42%), смешанный рак у 36 (29%), другие формы (недифференцированные) у 13 (10,48%).

Среди 100 больных с атипическим (медиастинальная форма роста) раком легкого плоскоклеточный рак диагностирован у 48 (48%), аденокарцинома у 13 (13%), мелкоклеточный рак у 2 (2%), смешанный рак у 25 (25%), другие формы (недифференцированные) у 12 (12%).

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно заключить, что плоскоклеточный рак превалирует среди больных по сравнению с другими гистологическими

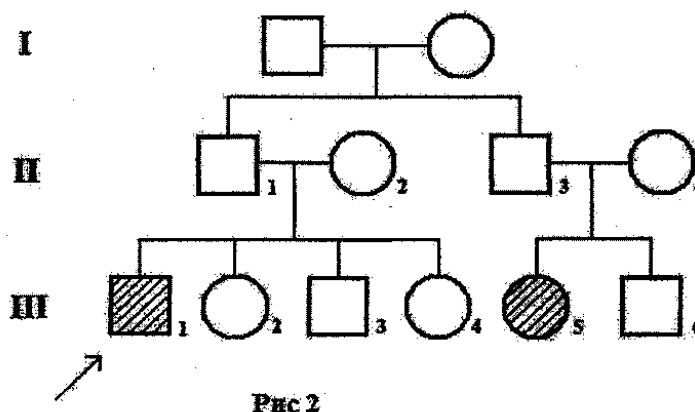


Рис 2

Рисунок 1. Распространение рака легкого по регионам Республики и гистологическим типам опухоли.

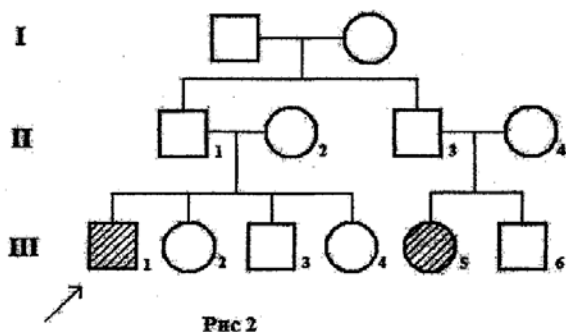


Рис 2

Рисунок 2. Распределение больных раком легкого по 5 регионам Республики, по полу и гистологическим типам опухоли

типами рака легкого. Половое соотношение рака легкого для всех видов рака легкого сохраняется в пользу мужчин и для всех регионов Республики. Высокие проценты рака легкого в регионе «Большой Кавказ» возможно, связаны с воздействием факторов внешней среды, таких как сигаретный дым, а также загрязнением атмосферного воздуха, поскольку регион включает индустриальные города как Баку и Сумгаит [3]. Курение и одновременное употребление спиртных напитков повышает риск развития рака легкого среди мужчин. Эти вредные привычки, в связи с менталитетом народов, проживающих на территории Азербайджанской Республики, характерно в основном для мужского населения, что и связано высокой частоты рака среди мужчин.

Список использованной литературы

1. Бычков М.Б. Мелкоклеточные рак лёгкого. Эволюция химиотерапии за последние 20 лет // *Мат. III съезда онкологов и радиологов СНГ*. - Минск, 2004. - Ч. 1. - С. 151-153.
2. Солтанов А.А. Заболеваемость и смертность от рака легкого в Азербайджане // *Азербайджанский журнал онкологии и гематологии*. - 2005. - №2. - С.37-39.
3. Солтанов А.А. Эпидемиологические особенности рака легкого в Азербайджане // *Азербайджанский журнал онкологии и гематологии*. - 2007. - №1. - С.20-26.
4. Bahader Y., Jazieh A. Epidemiology of lung cancer // *Ann. Thorac Med.* - 2008. - Vol. 3. - P.65-67.
5. Curado M.P., Edwards B., Shin H.R. et al. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. 9. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer (IARC) 2007. IARC Scientific Publications No. 160.
6. Ferlay J., Autier P., Boniol M. et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006 // *Ann. Oncol.* - 2007. - Vol.18, N3. - P.581-592.
7. Gilliland F.D., Samet J.M. Incidence and mortality for lung cancer: geographic, histologic, and diagnostic trends // *Cancer Surv.* - 1994. - Vol. 19. - P.175-195.
8. Janssen-Heijnen M.L., Coebergh J.W. The changing epidemiology of lung cancer in Europe. Eindhoven Cancer Registry, Comprehensive Cancer Centre South, P.O. Box 231, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. m.janssen@ikz.nl Lung // *Cancer*. - 2003. - Vol.41, N 3. - P.245-258.
9. Jemal A., Murray T., Ward E. et al. Cancer Statistics, 2005 // *CA Cancer J. Clin.* - 2005. - Vol.55. - N 1. - P.10-30.
10. Levi F., Franceschi S., La Vecchia C., Randimbison L., Te V.C. Lung carcinoma trends by histologic type in Vaud and Neuchatel, Switzerland, 1974-1994 // *Cancer*. - 1997. - Vol.79. - N 5. - P.906-914.
11. Molina J.R., Yang P., Cassivi S.D. et al. Non-Small Cell Lung Cancer: Epidemiology, Risk Factors, Treatment, and Survivorship // *Mayo Clin. Proc.* - 2008. - Vol. 83, N 5. - P. 584 - 594.
12. Morita T. A statistical study of lung cancer in the annual of pathological autopsy cases in Japan from 1958 to 1997 with reference to time trends of lung cancer in the world // *Jpn. J. Cancer Res.* - 2002. - Vol. 93, N 1. - P. 15-23.
13. Subramanian J., Govindan R. Lung cancer in never smokers: a review // *J. Clin. Oncol.* - 2007. - Vol. 25. - P.561-570.
14. Sun Z., Aubry M.-C., Deschamps C. et al. Histologic grade is an independent prognostic factor for survival in non-small cell lung cancer: An analysis of 5018 hospital- and 712 population-based cases // *J. Thorac. Cardiovasc Surg.* - 2006. - Vol.131. - P.1014-1020.
15. Travis, W. D., World Health Organization., International Agency for Research on Cancer., International Academy of Pathology & International Association for the Study of Lung Cancer. Pathology and genetics of tumours of the lung, pleura, thymus and heart (IARC Press, Lyon, 2004).
16. Travis W.D., Garg K., Franklin W.A. et al. Evolving concepts in the pathology and computed tomography imaging of lung adenocarcinoma and bronchioloalveolar carcinoma // *J. Clin. Oncol.* - 2005. - Vol. 23, N 14. - P. 3279-3287.
17. Wistuba Ignacio I. Histologic Evaluation of Bronchial Squamous Lesions: Any Role in Lung Cancer Risk Assessment? // *Clinical Cancer Res.* - 2005. - N 11. - P. 1358.
18. Yang P., Cerhan J.R., Vierkant R.A. et al. Adenocarcinoma of the lung is strongly associated with cigarette smoking: further evidence from a prospective study of women // *Am. J. Epidemiol.* - 2002. - Vol.156, N12. - P.1114-22.
19. Youliden, Danny R. BSc; Cramb, Susanna M. et al. The International Epidemiology of Lung Cancer: Geographical Distribution and Secular Trends. // *J. of Thoracic Oncology*. - 2008. - Vol.3, N 8. - P.819-831.

Клинико-генеалогический анализ семей с плоскоклеточным раком кожи

Алиева К.А., Гасанова А.Х.

Бакинский государственный университет, Азербайджанская Республика

Клинико-генеалогический анализ семей с плоскоклеточным раком кожи

На основании анализа 95 родословных с плоскоклеточным раком кожи нами впервые установлен мультифакториальный тип наследования заболевания. В экспериментальной группе коэффициент инбридинга и частота эндогамных браков составили $F=0,0067$ и 43,98% соответственно, что не отличаются от средних Республиканских показателей.

Актуальность проблемы

Плоскоклеточная или сквамозно-клеточная карцинома развивается из клеток, лежащих над базальным слоем эпителия. Встречается реже базалиомы, которые включают в себя несколько основных разновидностей: болезнь Боуэна, болезнь Кейра, боуэноподобный папулез и инвазивный плоскоклеточный рак - наиболее опасная форма заболевания, напоминающая болезнь Боуэна, но края папул нечеткие и имеют склонность к изъязвлению и легкой травматизации. Синдромы дефицита, такие как синдром Пламмера-Винсона, характеризующегося дисфагией, железodefицитной анемией, пищеводных пленок, встречаются все реже с улучшением условий питания в развивающихся странах (3,4,8,9). Данные экспериментальных и эпидемиологических исследований показали, что УФ-излучение является канцерогенным для человека и приводит к развитию базалиомы, плоскоклеточного рака и меланомы кожи (5).

Следует отметить недостаточную освещенность в отечественной и зарубежной литературе результатов исследований по изучению генетики плоскоклеточного рака кожи, что открывает перед исследователями определенные перспективы.

Материалы и методы исследований

Клинико-генеалогический анализ - составление и анализ родословных для установления типа наследования, определения типа кровнородственного брака, а также вычисления коэффициента инбридинга проводили по (3,4,7). Для клинико-генеалогических исследований нами составлен и проведен анализ родословных 95 пробандов.

Результаты собственных исследований

На основании клинико-генеалогических исследований 95 родословных больных - пробандов, нами впервые установлен мультифакториальный тип наследования плоскоклеточного рака кожи. Определена структура браков и вычислен коэффициент инбридинга в этих семьях. Среднее количество детей и средний размер семьи у пробандов с плоскоклеточным раком кожи составил 4,2 и 6,2, соответственно. Эти показатели для больных мужчин и больных женщин соответственно составили - 4,1; 6,1 и 4,3; 6,3, и отличаются статистически недостоверно. Нам было интересно узнать порядок рождения больного мальчика и больной девочки в семье. Результаты клинико-генеалогического анализа ядерных семей пробандов пред-

Clinical-Genealogical Analysis Of Families With Skin Squamous Cell Carcinoma

K.A.Aliyeva, A.X.Hasanova

For the first time we identified multifactorial inheritance type of skin squamous cell carcinoma on the basis of 95 family trees analysis. Inbreeding coefficient and endogamous marriage frequencies comprised $F=0,0067$ and 43,98%, respectively, that did not differ from average indications in the Republic.

ставлены в таблице № 1.

Как видно из таблицы № 1, наблюдалось снижение количества больных детей от количества деторождения: следовательно, больные в независимости от пола в 40,0% случаях были первенцами, в 30,53% случаях вторыми по рождению, в 17,89% случаях третьими, 7,36% четвертыми, 3,16% пятими и в одном случае - 1,05% шестым. Эту закономерность также можно объяснить возрастом ребенка-больного, чем старше человек тем чаще, выше вероятность заболеть онкологическим заболеванием, в частности плоскоклеточным раком кожи.

В наших исследованиях в трех семьях наблюдали заболевание у разнополых сибсов, т.е. у брата и сестры, и в одном случае у двух двоюродных сестер по отцовской линии. В этих четырех семьях только в одном случае выявили кровное родство между родителями больного. В остальных трех случаях наблюдали эндемичный тип брака. На рисунках № 1. и №2. представляем родословные пробандов М.К. и Т.Е.

Как видно из рисунка №1. пробанд - IV-1 является первым, а больная сестра - IV-3 третьим ребенком в семье. Отец - III-1 и мать - Ш-2 имеют кровное родство второй степени, т.е. двоюродный брат и двоюродная сестра. Их матери являются родными сестрами (П-1, П-4).

На рисунке №2. пробанд Т.Е. (III-1) и двоюродная сестра (Ш-5) имеют заболевание кожи. Пробанд Т.Е. (III-1) является первым из четырех детей, двоюродная сестра (Ш-5) также первая из двух детей в семье. П-1 и П-3 являются родными братьями.

Внутрисемейная частота плоскоклеточного рака кожи соответствует -1,23, что характерно для мультифакториального типа наследования заболевания. Следовательно, для возникновения заболевания необходимо изменение в группе генов под воздействием эндогенных и экзогенных факторов (8).

Сегрегационный анализ патологического признака в родословной не установил такие типы наследования как аутосомно-рецессивный, аутосомно-доминантный и сцепленный X-половой хромосомой.

В структуре браков в семьях пробандов с плоскоклеточным раком кожи частота двоюродного, троюродного и четвероюродного типов кровнородственных браков составили; 5,26%, 6,32% и 9,47% соответственно.

Коэффициент инбридинга в экспериментальной группе составил $-F=0,0067$, что соответствовало средней популяционной частоте коэффициента инбридинга по Республике - $F=0,0066$ (1-4).

Частота эндогамных браков составил - 44,21%),

Таблица № 1. Результаты клинко-генеалогического анализа семей пробандов

Порядок рождения			девочка		всего	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
1-й ребенок	17	36,96	21	42,86	38	40,0
2-й ребенок	13	28,26	16	32,65	29	30,53
3-й ребенок	12	26,01	5	10,20	17	
4-й ребенок	2	4,35	5	10,20	7	
5-й ребенок	2	4,35	1	2,04	3	
6-й ребенок	-	1		2,04	1	

что также соответствует средней популяционной частоте эндогамных браков по Республике -43,98%.

Таким образом, путем клинко-генеалогических исследований нами впервые установлен мультифакториальный тип наследования плоскоклеточного рака кожи. В этих семьях коэффициент инбридинга и частота эндогамных браков соответственно составили $F=0,0067$ и 43,98%, что соответствовало средним Республиканским показателям.

Выводы

На основании анализа родословных нами впервые установлен мультифакториальный тип наследования плоскоклеточного рака кожи.

В экспериментальной группе коэффициент инбридинга и частота эндогамных браков составили $F=0,0067$ и 43,98% соответственно, что не отличается от средних республиканских показателей.

Литература

1. Алиева К.А., Расулов Э.М. Популяционно-генетические и демографические исследования некоторых районов Азербайджанской Республики. Второй Российский съезд медицинских генетиков, Курск, 17-19 мая 2000, т.1. с.151.
2. Мухтаров З.Я., Алиева К.А., Расулов Э.М. Популяционно-генетические исследования в Лерикском районе Азербайджанской Республики. Ж.Цитология и генетика, Киев, 2000, №5, с.22-29.
3. Козлова СИ., Демикова Н.С., Семанова Е. и др. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование: Справочник. 2-е издание. Москва. Практика. 1996.
4. Козлова СИ., Семанова СО, Демикова Н.С., Блинникова О.Е.. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование. Ленинград, 1987.
5. Кропотов М.А. Срединная мандибулотомия как средство оперативного доступа у больных местнораспространенным раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки // Рос. онкол. журн. - 2002. - №2. - С.34-37.
6. Липкин Е.Е., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников Н.Б. Генетика для врачей. Москва. Медицина. 1990. с.255.
7. Харпер П. Практическое медико-генетическое консультирование. Москва. Медицина. 1984. с. 280.
8. McKusick A. Mendelian inheritance in man. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London. Tenth edition. V. 1,2. 2002. p. 1167.
9. H-Parkes M., Barmada M.M., Satsangi J. et al., The IBD2 locus show linkage heterogeneity between ulcerative colitis and Crohn disease. AmJ.Hum.Genet.2000. 67(6): 1605-1610.

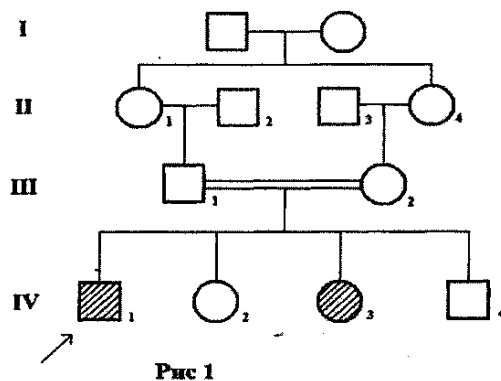


Рис 1

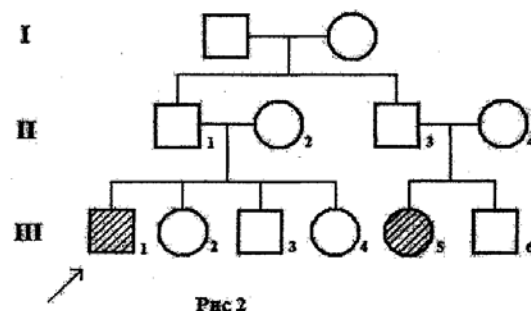


Рис 2

К вопросу о гисто-цитоморфологических особенностях плоскоклеточного рака кожи

Мурадов Х.К., Гасанова А.Х.

Городской онкологический диспансер, Баку, Азербайджан

Актуальность проблемы

Заболеваемость злокачественными опухолями кожи характеризуется большим разнообразием на различных территориях и у отдельных групп населения. В США ежегодно регистрируется 400-700 больных раком кожи, при заболеваемости 422 на 100000 населения (16, 18, 19, 20.). Частота злокачественных опухолей кожи в Турции составляет 11,6% (7), Иране – 16,6% (17) Ираке – 8,1% (6).

В последние годы во многих районах земного шара заболеваемость злокачественными опухолями кожи увеличивается (10, 11, 12) и это явление приобрело характер бесшумной эпидемии (21). В данном контексте следует отметить, что успешная диагностика и лечение больных со столь агрессивной злокачественной опухолью как плоскоклеточный рак кожи, до настоящего времени остается нерешенной и актуальной проблемой современной онкологии (11).

Сообщений об особенностях морфологической верификации плоскоклеточного рака кожи небольшое число, в немногочисленных работах (2, 4) на сравнительно небольшом числе наблюдений дается цитологическое описание плоскоклеточного рака кожи, высоко оценивается информативность цитологического исследования. При этом отмечается, что дифференциальная диагностика между базалиомой и плоскоклеточным раком кожи затруднена при наличии в препаратах одновременно реактивно измененного плоского эпителия с признаками атипии (13).

Ряд авторов сообщает о трудностях цитологической диагностики плоскоклеточного рака сопровождающимся некрозом и воспалением (5, 8, 9). У других авторов (15) уверенная диагностика плоскоклеточного рака с помощью цитологического исследования возможна лишь в 40% случаев. Результативность гистологического исследования так же как и цитологического снижается при рубцовом раке кожи часто осложненным воспалительным процессом. При плоскоклеточном раке кожи гистологическое исследование в 15,8% наблюдений дает ложно отрицательные ответы (1).

Цель исследования

- изучение гисто-цитоморфологических особенностей плоскоклеточного рака кожи и улучшение диагностической программы у данного контингента больных.

Согласно цели исследования были осуществлены рандомизированный отбор и последующее исследование контингента больных, на основании общепринятых способов и принципов формирования аналогичных контингентов, изложенными в ряде работ.

Материал и методы исследования

Проанализированы результаты обследования 896 больных, находившихся на лечении и динамическом наблюдении в Бакинском онкологическом диспансере с 1997 по 2006 гг. После рандомизации (отбора историй болезней и карт амбулаторного наблюдения с неполными данными, случаев повторного и многократного обращения) контингент был сформирован из 731-ти больных, распределение которых по годам выглядело следующим образом: 1997 - 66(9%),

1998 - 68(9,3 %), 1999 - 83(11,4%), 2000- - 79(10,8%), 2001 - 75(10,3%), 2002 - 78(10,7%), 2003 - 69(9,4%), 2004 - 70(9,6%), 2005 - 74(10,1%), 2006 - 69 (9,4%).

54(7,44%) пациента получили курс стационарного лечения без последующего амбулаторного наблюдения, 677(92,6%) больным проводилось стационарное лечение, последующие амбулаторные наблюдения и курсы терапии. По нашим данным, рак кожи почти одинаково наблюдался у лиц обоего пола. Было 378(51,7%) мужчин и 353(48,2%) женщины. Возраст больных варьировал от 46 до 87 лет; по конкретным возрастным диапазонам они были распределены в следующем виде: 41–50 лет - 97(13,3 %); 51-60 лет-259(35,4 %); 61-70 лет-224 (30,6 %); 71-80 лет-106(14,5 %); 80 лет и более - 45(6,2 %).

Кроме основного патологического процесса, были отмечены следующие сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия и вегето-сосудистые нарушения–593(81,1%), ишемическая болезнь сердца–685 (93,7%), атеросклероз–701(95,9%), сахарный диабет – 262(35,9 %), бронхиты, астма–33(4,5%), болезни мочевыводящих путей–44(61%), болезни пищеварительной системы в 134(18,2%) случаях (табл. 1).

Таблица 1. Сопутствующие заболевания у больных раком кожи

Патология	Число больных	%
Ишемическая болезнь сердца	685	93,7
Атеросклероз	701	95,9
Сахарный диабет	263	63,3
Варикозы вен и флебиты	224	30,6
Гипертиреоз	68	9,3
Патология мочевыделительной системы	446	61
Артериальная гипертония	593	81,1
Патология печени, желчевыводящих путей	104	14,2
Гастриты, язва желудка	21	2,9
Язвенный колит	9	1,2
Астма бронхиальная	33	4,5
Дерматиты, экзема	11	1,5

Обследованию каждой больной предшествовали тщательная регистрация всех жалоб, а также сбор жизненного анамнеза у 731(100,0%). больного. Далее, во всех случаях брались мазки, наряду с общеклиническим обследованием основных органов и систем, проводился общий и биохимический анализ крови и мочи. У 654(89,4%) больных выполнялись рентгенологические исследования, у 577(78,9%)-ультразвуковое исследование, 96(13,1%) пациентам выполнена компьютерная томография.

Были применены следующие цитологические методы окрашивания: окраска по Романовскому – Гимзе, по Граму, гематоксилином-эозином. При выполнении этих методик мазки предварительно были зафиксированы, по возможности 10,0% раствором метанола в 0,2 М фосфатном буфере с pH-7,4.

Использованы следующие селективные цитохимические методы окраски: инкубация мазков в 0,05% забуференном растворе тионина; инкубация мазков

в 1,0 % растворе альцианового синего при pH-5,5.

Результаты и обсуждение

Плоскоклеточный рак, особенно его ороговевающая форма, распознавался по выраженному разнообразию форм крупных клеток атипичного плоского эпителия и резко выраженной гиперхромии ядер. При обзоре полей зрения с малым увеличением клетки этой формы рака выделялись среди других клеточных элементов яркостью окраски цитоплазмы и ядер. Часто, они располагаются по ходу полос слизи среди бесструктурных остатков клеточных тел различной величины и формы, лишенных ядер. Последнее, отражало наличие процесса некробиоза в клетках рака.

Клетки плоскоклеточного ороговевающего рака, имея те же размеры, что и нормальные близлежащие клетки плоского эпителия поверхностного слоя, резко отличались от них интенсивностью окраски цитоплазмы и размерами ядер. Вместо нежно окрашенных, с хорошо обозначенной сетью хроматина или маленьких пикнотичных, мы наблюдали крупные, плотные, гиперхромные ядра.

Следует отметить, что нередко обращало на себя внимание разнообразие форм клеток при плоскоклеточном раке, особенно при его ороговевающей форме. Форма клеток столь причудлива, что трудно поддается сравнению с геометрическими формами. Могут встречаться клетки гигантского размера до 30 ц в диаметре и резко уменьшенного размера, немногим большего, чем лейкоцит, однако, в наших наблюдениях преобладали крупные клетки.

Нередко отличалось и раннее ороговение, когда у незрелой клетки (небольшой размер, округлая форма, крупное ядро) в цитоплазме отмечался процесс ороговения (насыщенный цвет цитоплазмы с переходом в оранжевый тон). Ядро отличалось особой грубостью строения хроматина, при том, сеть хроматина не различалась даже в крупных ядрах. Это придает ядрам вид плотных гомогенных образований. Большинство клеток плоскоклеточного ороговевающего рака не имеет в ядре выраженных ядрышек, тем не менее, в части клеток можно было увидеть и увеличенное число гипертрофированных ядрышек. В клетках плоскоклеточного неороговевающего рака обычно наблюдалось больше ядрышек и они встречались чаще. Клетки этой формы рака, как правило, имели округлую форму, тогда как змеевидные, лентовидные формы и формы ракетов были свойственны ороговевающему раку.

Мы полностью согласны с мнением многих авторов (3, 14) о том, что, несмотря на успешное развитие гистоморфологической диагностики плоскоклеточного рака кожи, не всегда представляется возможным правильно определить точную разновидность плоскоклеточного рака.

Следует отметить, что малое число встреченных клеток может не полностью отражать структуру имеющейся опухоли. Затруднения могут быть и иного рода, например, когда атипия клеток стирает различия между видами эпителия. Первое впечатление от изображенного скопления клеток направляет мысль в сторону атипии цилиндрического эпителия, однако расположение крупных ядер в широкой части клеток более характерно для выраженной атипии, наблюдающейся при плоскоклеточном раке. В наличии именно этой формы убеждают и присутствующие в том же препарате клетки, явно относящиеся к атипичному плоскому эпителию. По нашему мнению, необходимо также иметь в виду и то, что атипичные клетки плоского эпителия, встречающиеся в виде отдельных клеток или в виде групп, несмотря на их атипизм и выраженную жировую дистрофию, не всегда могут служить основанием даже для предположительного диагноза рака. Аналогичное мнение можно высказать и об атипичных клетках плоского эпителия, относящихся к парабазальному слою. Сочетание подобных клеток хотя бы с одной из клеток, уже обязывает высказать подозрение о

принадлежности их к плоскоклеточному раку, а поскольку в оранжевом тоне окраски цитоплазмы отражен и процесс ороговения, можно думать о его ороговевающей форме. Мы считаем, что если атипизм клеток и ядер не столь выражен, как описано, то диагноз рака не может быть поставлен.

Согласно нашим данным, можно встретить комплексы, состоящие только из двух взаимно связанных клеток. Характер связи клеток при выраженности атипии ядер, может служить основанием для установления диагноза плоскоклеточного рака с наклоном к ороговению. Рассмотрение клеток при иммерсии выявляет в них все критерии, характеризующие злокачественные клетки: различная степень интенсивности окраски ядер, неравномерность их контуров, неправильное распределение хроматина в виде сгущений и разрежений, анизокитоз и анизонуклеоз, увеличение размера ядер. В некоторых клетках могут обнаруживаться и гипертрофированные нуклеолы розоватого тона. Характерно отсутствие границ между клетками в нижней части комплекса. Гомогенность структуры цитоплазмы, ее интенсивно розовый тон, переходящий в оранжево-красный, позволяют определить начало ороговения. Комплекс наглядно демонстрирует клеточный атипизм. Хорошо видна различная степень плотности сети хроматина, наличие участков неравномерного сгущения, грубости его зерен, особенно в наиболее крупном ядре.

Анализ результатов показал, что используемая нами интерпретация данных цитологического и гистологического исследований при плоскоклеточном раке кожи, с учетом комплексной оценки гистоморфологических особенностей данной патологии, способствовала улучшению диагностической программы и результатов лечения у данного контингента больных.

Выводы

Даже незначительное число клеток, связанных между собой в комплекс, способно служить отражением строения раковой ткани.

Различная степень интенсивности окраски ядер, неравномерность их контуров, неправильное распределение хроматина в виде сгущений и разрежений, анизокитоз и анизонуклеоз, увеличение размера ядер могут служить критерием злокачественности процесса.

Атипичные клетки плоского эпителия, встречающиеся в виде отдельных клеток или в виде групп, несмотря на их атипизм и выраженную жировую дистрофию, не могут служить основанием даже для предположительного диагноза рака кожи.

Литература

1. Абросимов В. Н. Предраковое состояние и рак кожи у инвалидов Великой Отечественной войны, как позднее осложнение боевых травм // Автореферат кандидатской диссертации. М., 1982. 47 с.
2. Аюбян А. А. Цитологическая диагностика эпителиальных опухолей кожи // Автореферат кандидатской диссертации. Ереван, 1982. 47 с.
3. Апатенко А. К. Эпителиальные опухоли и пороки развития кожи. М.: Медицина, 1974. С. 193—215.
4. Кирюшкина М. Р. Цитоморфологическая характеристика новообразований кожи (меланома, рак кожи, базалиома) // Автореферат кандидатской диссертации. М., 1977, 46 с.
5. Плетнев С. Д., Слесарева Р. И. Ошибки и трудности диагностики первичных злокачественных опухолей кожи // Советская медицина. 1977. № 8. С. 67—72.
6. Al-Fuadi A., Parkin D. M. Cancer in Iraq: Seven-year data from the Baghdad tumour registry. Cancer Prev. Dev. countries. Prof. 2nd UICC Conf. Nagoyashi, 1986. Oxford I.a. 1986.
7. Balic Josip, Ivar Zelyka. Epidemiologia raka kože na podzucjn opii na Sibenik i Drnis u vremenu od 1971 do 1980 godine. Zijec. Vjesn. 1985, 107, №9, 375—379.
8. Bourguet Claire C., Checkonny Harvey, Hulka Barbera S. A case-

- control study of skin cancer in the tire and rubber manufacturing industry. *American Journal Ind. Med.* 1987, № 4, 461—473.
9. Casabonne D., Michael K.M., Waterboer T., Pawlita M., Forslund O., Burk R.D., et al. A prospective pilot study of antibodies against human papillomaviruses and cutaneous squamous cell carcinoma nested in the Oxford component of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. *Int. J. Cancer* 2007;121:1862-8.
 10. Chuang T. Y., Reizner G. T., Elpern D. J., Stone J. L., Farmer E. R. Nonmelanoma skin cancer in Japanese ethnic Hawaiians in Kauai. Hawaii: an incidence report. *J-Am-Acad-Dermatol.* 1995 Sep; 33(3): 422—426.
 11. Heinritz H., Benzel W., Hoffmann K., Iro H. Imaging superficial skin tumours of the ENT area. High frequency ultrasound in comparison with computerized tomography and magnetic resonance tomography. *HNO.* 1995 Jan; 43(1): 6—11.
 12. Ivic Zeljko, Petric Vlado, Pipic Wedim. Hivremeni aspekti u Kirurjkim liječenji tumura Koze glave i vrata. «An. Klin. Boln. Dr. M. Stojanovic». 1985, 24, №3, 207—218.
 13. Karagas M.R., McDonald J.A., Greenberg E.R., Stukel T.A., Weiss J.E., Baron J.A., et al. Risk of basal cell and squamous cell skin cancers after ionizing radiation therapy. *J. Natl. Cancer Inst.* 1996;88:1848-53.
 14. Karagas M.R., Weinstock M.A., Nelson H.H. Keratinocyte carcinomas (basal and squamous cell carcinomas of the skin). In: Schottenfeld DFJF Jr, ed. *Cancer epidemiology and prevention*. 3rd ed. Oxford University Press, 2006.
 15. Karamlou A. Characterization of cancer in different regions of Iran. «Cancer Prev..Dev. Counties Proc. 2nd UICC Conf., Nagoya-Shi, 1985, Oxford I.a. 1986, 51—53.
 16. Korovessis P., Repanti M., Sidiropoulos P. Refracture of a healed tibial shaft fracture after irradiation for post-traumatic squamous-cell carcinoma. *Injury.* 1995 Oct; 26 (8): 559—561.
 17. Kubitckek H. E., Baker K. S., Plak M. J. Enhancement of mutagenesis and human skin cancer rates resulting from fluences of solar ultraviolet radiation. «Photochem. And Photobiol.» 1986, 43, №4, 443—447.
 18. Ohin A. I. Les cancers en Afrique. «Med. Biol. Environ» 1980, 8, №2, 14—22.
 19. Pagani W., Carli G., Lorenzi G. Il carcinoma basocellulare degli arti inferiori: note di clinica terapia chirurgica. «Acta chir. Ital.» 1984, 40, №2, 244—249.
 20. Saint-Ives Iau F. M., Monari Mortelza. Skin cancers in Australia's northern territory 1981—1985 years. «J. Roy. Soc. Health.» 1981, 108, №2, 69-74.
 21. Scholtens R. E., van-Zuuren E. J., Posma A. N. Treatment of recurrent squamous cell carcinoma of the hand in immunosuppressed patients. *J-Hand-Surg-Am.* 1995 Jan; 20 (1): 73—76.

Оптимизация скрининга заболеваний молочной железы

Ватанха В.С.

Национальный центр онкологии Минздрава
Азербайджанской Республики, Азербайджанская Республика, г.Баку

Проблема своевременной диагностики и лечения онкологических заболеваний на сегодня остается, пожалуй, одной из наиболее болезненных тем для медицины. Во многом это обусловлено тем, что современные методы диагностики и лечения злокачественных образований достаточно сложны и специфичны, а значит их использование, как правило, сопряжено со значительными финансовыми затратами. Согласно имеющимся на сегодня данным Минздрава Азербайджанской Республики, в 2010 году абсолютное число зарегистрированных случаев рака молочной железы в Азербайджане составило 1221, из них 9 – у мужчин. Скрининг рака молочной железы предполагает массовое профилактическое обследование здоровых женщин с целью выявления у них ранней стадии заболевания. Для проведения таких обследований Национальным центром онкологии был закуплен первый в Азербайджане передвижной маммографический комплекс. Если ресурсы адекватны, методом выбора для скрининга с целью раннего выявления рака молочной железы является маммография. Это единственный метод раннего выявления, эффективность которого подтверждена с соблюдением принципов доказательной медицины.

Проблема своевременной диагностики и лечения онкологических заболеваний на сегодня остается, пожалуй, одной из наиболее болезненных тем для медицины. Во многом это обусловлено тем, что современные методы диагностики и лечения злокачественных образований достаточно сложны и специфичны, а значит их использование, как правило, сопряжено со значительными финансовыми затратами. В Азербайджане в силу известных социально-экономических условий особенно остро стоит вопрос обеспечения права всех пациентов на гарантированный доступ к существующим в настоящее время методикам диагностики и лечения злокачественных новообразований, которые соответствуют всем современным стандартам, на качественную медицинскую, социальную и психологическую помощь. В этом смысле не является исключением и такая онкологическая патология, как рак молочной железы, которая занимает лидирующие позиции в структуре смертности женщин от злокачественных новообразований во всем мире.

Введение

Согласно имеющимся на сегодня данным МЗ Азербайджанской Республики, в 2010 году абсолютное число зарегистрированных случаев рака молочной железы в Азербайджане составило 1221, из них 9 – у мужчин. Безусловно, в сравнении с данными о заболеваемости раком молочной железы в Азербайджане 5-6 лет назад, можно констатировать улучшение показателей диагностики рака молочной железы I-II стадии согласно классификации TNM: в настоящее время заболевание в этих стадиях выявляют у 47,2% пациентов. Как известно, снижение смертности от рака молочной

Nowadays the problem of early diagnostics and treatment of oncological diseases remains as painful subject in medicine. It is mostly caused by the fact that the up-to-date methods of diagnostics and treatment are difficult and typical, so the application of them is joined by considerable financial cost. According to the data of the Ministry of Public Health of Azerbaijan for today, the absolute number of registered cases of breast cancer in Azerbaijan in 2010 has been 1221 and 9 of them were men. The screening of breast cancer considers massive prophylactic examination of healthy women for detecting early stage of the disease. For carrying out such examination the National centre of oncology has purchased mobile mammographic complex, which is for the first time in Azerbaijan. This is the only method of early detecting, efficiency of which is proved by following the principles of evidence based medicine.

железы и успехи в лечении, во многом, определяются ранней диагностикой заболевания: при I стадии 5-летний срок переживают 90-95% больных; при IV – менее 10%. Однако, большинство заболевших сами обнаруживали у себя опухоль; выявленные таким путем новообразования, к сожалению, не соответствовали ранним стадиям процесса. Очевидно, что для улучшения результатов диагностики и лечения скринингу (массовому обследованию здорового населения) нет альтернативы.

Выявление РМЖ во время профилактических осмотров в целом по стране остается низким, а показатель запущенности (IIIБ - IV ст.), который является ведущим критерием качества диагностики, наоборот - высоким. Реальный путь улучшения результатов лечения опухолей молочной железы - ранняя, а в ряде случаев - доклиническая диагностика. Решить эту проблему можно только при условии применения комплексных методов диагностики [1].

По нашим данным, большинство заболевших раком молочной железы (93,5%) обратились к врачу лишь после обнаружения у себя опухоли в молочной железе. Это связано с отсутствием в нашей стране системы скрининговых обследований. Диспансерное наблюдение, регулярное обследование женщин специалистами с применением современных диагностических методов позволит значительно улучшить показатели раннего выявления и лечения заболеваний молочной железы.

Скрининг должен отвечать следующим требованиям: обладать высокой чувствительностью и специфичностью, приносить минимальный вред здоровью обследуемых; оборудование должно быть простым в эксплуатации и содержании, стоимость затрат должна быть приемлемой. Указанным

требованиям соответствует маммографический скрининг, позволяющий выявить значительный спектр новообразований – от микрофокусов *carcinomae in situ* до крупных инвазивных очагов поражения. Установление размера диагностируемых опухолей является важным критерием оценки качества скрининга и определения возможностей маммографии выявлять не пальпируемые опухоли. Проведение маммографического скрининга показано с периодичностью один раз в два года в возрасте 40 и более лет, так как именно в этой возрастной группе отмечена наиболее высокая заболеваемость [5].

До 1980-х гг. рост заболеваемости и смертности от рака молочной железы наблюдался как в развивающихся, так и в экономически развитых странах. Затем, по мере внедрения маммографического скрининга, улучшения результатов диагностики и лечения в экономически развитых странах Запады произошло замедление, а затем и снижение смертности (IARC, 2002), в то время как в странах Восточной Европы и Латинской Америки, напротив, смертность от рака молочной железы продолжала возрастать [9].

В странах Западной Европы и Северной Америки достигнута возможность выявления I стадии заболевания у 70-80% и, соответственно, выздоровления от рака молочной железы - 60-80% женщин. Маммографический скрининг, таким образом, позволил уменьшить смертность от рака молочной железы на 30% через 5-7 и на 20% - через 15-20 лет от начала скрининга [13].

В настоящее время очевидно, что основное внимание должно быть сосредоточено на ранней диагностике рака молочной железы. К сожалению, нам пока недоступна реализация широкомасштабных скрининговых программ, подобных таковым в европейских странах, т. к. наше государство не готово к этому не только технически, но и, прежде всего, организационно. Очевидно, что покупка, к примеру, одного маммографа на целый регион абсолютно не в состоянии решить проблему организации скрининга. На сегодня обследование на предмет выявления рака молочной железы – это целый комплекс четко отработанных мероприятий, который, помимо всего прочего, подразумевает и современное техническое, программное и кадровое обеспечение процесса обработки данных, необходимое для учета количества населения того или иного региона в целом, лиц, прошедших скрининг, и находящихся в группе риска развития данного новообразования.

Скрининг – сложное и дорогое мероприятие, поэтому его проведение осуществимо лишь в странах, обладающих адекватно обеспеченной системой здравоохранения. Для эффективного скрининга необходимы подготовленные сотрудники маммографических кабинетов, способные должным образом оценивать неизбежные (в 4-12% случаев) рентгеногемативные опухоли молочных желез, а также опухоли «интервальные», выявляемые (в 15-25% случаев) в интервалах между обследованиями скрининга. Ложноположительные и ложноотрицательные результаты маммографии составляют 5-25% и 10-25%, соответственно.

Проведение маммографического скрининга предполагает решение многих организационных задач. Кроме обеспечения финансирования, необходимо добиться активного и добровольного участия в скрининге самих женщин [9]. Следует отметить существенные различия в психологии обследуемых в странах Западной Европы и Северной Америки, сравнительно с «установками» пациенток в Азербайджане. В отличие от рационального, прагматичного отношения к своему здоровью на Западе, наш контингент обследуемых часто не уделяет должного внимания состоянию здоровья, не осознает важности, значимости своевременной диагностики и лечения (в том числе – и по стоимости затрат на обеспечение здоровья). Важнейшая мотивация активного и добровольного участия в профилактических обследованиях – сохранение собственной жизни

и здоровья – не укрепляется в сознании граждан средствами массовой информации (телевидение, радио, пресса).

Не менее важным вопросом организации такого обследования является надлежащая подготовка врачей-рентгенологов, способных квалифицированно анализировать результаты маммографического исследования, и рентгенлаборантов, обеспечивающих высокое качество подготовки к использованию оборудования для маммографии и проведения самого процесса исследования. Не секрет, что в нашей стране специальность врача-рентгенолога сложно отнести к разряду престижных, хотя в Европе подготовке этих специалистов уделяют очень большое внимание. Исходя из мирового опыта, для реализации программ скрининга рака молочной железы в Азербайджане необходимо также создать реально действующий и финансируемый в достаточном объеме Национальный комитет по скринингу, в который вошли бы ведущие отечественные специалисты.

Маммографический скрининг состоит из трех звеньев. Первое из них – городская поликлиника, которая организует диспансеризацию женского населения на закрепленной территории, формирует активный вызов и направление на скрининг, а также проводит учет его результатов. Второе звено скрининга – это маммографический кабинет, где выполняется маммографическое обследование в стандартной косо́й проекции. В случае выявления патологических изменений больная направляется для прохождения заключительной, (третьей) диагностической части скрининга – в окружное маммологическое отделение и онкологическую сеть для уточняющей диагностики и лечения.

Проводившиеся ранее обследования, которые ограничивались лишь осмотром и пальпацией молочных желез, были сопряжены со значительной частотой (до 28-30%) диагностических ошибок. При этом, частота выявления I стадии не превышала 13-16% случаев, что приводило к неоправданно большому числу хирургических вмешательств с диагностической целью.

Внедрение в клиническую практику специальных рентгеновских маммографов позволило выявлять до 70% непальпируемых злокачественных опухолей. При этом, достигнуто снижение дозовых нагрузок за счет специальных кассет, усиливающих экранов и растров. В целом, точность диагностики повысилась до 80-90%. Применение ультразвуковой техники дало возможность дополнить клинко-рентгенологическую информацию и на 20% снизить число предположительных заключений. Доплеросонография дополнила сведения о кровотоке опухоли, тем самым, способствовала уточненной дооперационной диагностике раннего рака. Новая магнитно-резонансная техника обеспечила радиационную безопасность высокоэффективного исследования. Стала более совершенной технология пункционной биопсии.

Создание современной рентгеновской и ультразвуковой техники дало возможность разработать новые инвазивные технологии, в частности, пункционные и дрель-биопсии молочной железы, позволяющие получать высокоинформативный материал для цитологического и гистологического исследований, что в большинстве случаев исключает необходимость проведения секторальных резекций с диагностической целью и дает возможность устанавливать точный диагноз до операции [8].

Материалы и методы

Скрининг рака молочной железы предполагает массовое профилактическое обследование здоровых женщин с целью выявления у них ранней стадии заболевания. Для проведения таких обследований Национальным центром онкологии Минздрава Азербайджанской Республики был закуплен первый в Азербайджане передвижной маммографический комплекс. Комплекс оснащен современным диагностическим

оборудованием в соответствии с европейскими стандартами качественного маммографического обследования.

За 5 лет работы мобильного маммологического комплекса обследовано 1250 тысяч женщин в различных регионах Азербайджана. Из числа обследованных 95% проживали в пригороде и небольших поселках, где не было возможности проведения специализированного обследования. Таким образом, создание выездных маммографических комплексов стало одной из форм ранней диагностики рака молочной железы в условиях Азербайджана, приблизило специализированную помощь населению районов, удаленных от профильных медицинских учреждений.

Процент выявляемости из общего количества обследованных (1250 человек) составил 15% - 187 человек, из которых у 40% было подозрение на злокачественный процесс. Подобная ситуация описана во всех международных скрининговых программах при обобщении первого опыта скрининга, что связано с повышением выявляемости опухолей в популяции обследованных.

Достижение убедительных результатов скрининга, во многом, объясняется высоким качеством осуществляемой программы. Следует отметить, что проведение маммографического скрининга предусматривает формирование групп квалифицированных специалистов, включая онколога, рентгенолога, патоморфолога; также как и соответствующее техническое и научное обеспечение их работы, надлежащее обучение и тренинг медицинского персонала.

Очевидно, что программа скрининга не может быть действительно успешной без реальной долгосрочной государственной поддержки. Скрининг рака молочной железы – это, в первую очередь, серьезная государственная проблема здравоохранения, требующая принятия ответственных организационных решений.

Самообследование молочной железы с целью выявления злокачественного новообразования неэффективно. Рандомизированные исследования, проведенные в Китае с участием 267 тысяч женщин, не выявили разницы в смертности от рака молочной железы между опытной (скрининговой) и контрольной группами. Такие же результаты получили ученые в Англии, Москве и Санкт-Петербурге [7].

Риск рака молочной железы повышен у здоровых женщин, находящихся в менопаузе, при отягощенном семейном анамнезе (в случаях рака молочной железы с одним и более родственниками первой, или двумя и более родственниками второй степени родства), при гиперплазии (дисплазии) эпителия молочной железы, при семейном анамнезе носительства BRCA-1 и BRCA-2 (Breast Cancer), и некоторых других состояниях.

Кроме того, у больных, которым уже проведено лечение по поводу рака молочной железы, повышен риск возникновения множественной (второй) опухоли в контралатеральной железе. По данным литературы, вероятность заболеть (повторно) раком молочной железы у имеющих рак молочной железы в анамнезе в 5 раз превышает риск заболевания у здоровых женщин (данные регистра Национального противоракового института США – Surveillance Epidemiology End Results).

Предраковые состояния – это морфологические изменения, которые могут прогрессировать в инвазивный рак. Пролиферативные изменения эпителия молочной железы аналогичны дисплазии в других органах. Таким образом, выявление предопухолевого состояния молочной железы возможно при исследовании пунктата ее ткани. Для получения цитологического материала в НЦО Минздрава Азербайджанской Республики отработана методика жидкостной цитологии.

Результаты цитологических исследований (и определение риска заболевания, относительно пациенток без факторов риска (ОР)) оцениваются следующим образом:

1. Непролиферативное состояние. Риск не повышен (ОР=0,85).

2. Пролиферация без атипии. Незначительно повышенный риск (ОР=1,9).
3. Атипическая пролиферация. Умеренно повышенный риск (ОР=4,4). При дальнейшей прогрессии развивается рак in situ [7].

Наиболее интересным скрининговым исследованием, проведенным под руководством Европейской ассоциации онкологов, является определение мутаций генов BRCA 1 и 2 у женщин с целью раннего выявления рака молочной железы. Данные белки, по результатам исследований, ответственны за 30–40% случаев наследственной предрасположенности к раку молочной железы. По рекомендациям седьмой конференции по адъювантной терапии рака молочной железы (Ст.-Галлен, Швейцария, февраль 2001 года), в данной группе женщин более приемлемы такие профилактические меры, как двухсторонняя мастэктомия (снижение риска развития рака молочной железы более чем на 90%) и двухсторонняя овариэктомия (снижение риска на 50–70%). Однако, этическая сторона подобных профилактических мер остается нерешенной [7].

Большой интерес для современной онкологии представляет использование полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определения изменений различных генов в плазме крови с целью раннего выявления злокачественных новообразований различной локализации, профилактики развития рака, а также формирования групп риска для динамического наблюдения.

ООО «Центром молекулярно-генетической диагностики Сабирова А.Х.» был проведен профилактический осмотр с использованием полимеразной цепной реакции 837 работников газодобывающей компании. Были выявлены изменения генов у 358 (42,8%) пациентов. У 18 (2,2%) пациентов при дальнейшем наблюдении диагностированы и морфологически подтверждены в онкологических центрах России различные формы рака на 0 (in situ) и I стадиях опухолевого процесса. Временные интервалы от момента выявления изменений некоторых генов до момента диагностики значимых форм рака были различными и составили от 4 до 15 месяцев. Данные пациенты пролечены в онкологических центрах России. Остальной группе пациентов проведена соответствующая терапия. У 34 удалось добиться ингибирования мутаций. Оставшиеся 295 пациентов внесены в группу риска.

Учитывая высокую эффективность ПЦР-скрининга, его необходимо ввести в повседневную клиническую практику как рутинное исследование, что уже сделано во многих развитых странах. Скрининг злокачественных опухолей и предраков имеет важное значение не только для увеличения продолжительности жизни онкологических больных, но и для уменьшения заболеваемости. В связи с чем разработка новых методов скрининга, в первую очередь, молекулярно-генетических, имеет существенное социально-экономическое значение [8].

В 1975 г. Эд Саузерн использовал меченую нуклеиновую кислоту для выявления специфической последовательности среди фрагментов ДНК, иммобилизованных на твердой подложке, – это был первый ДНК-чип, названный по имени автора «Саузерн блот». В настоящее время активно развиваются ДНК-технологии, позволяющие не только определять наличие того или иного признака, но и одновременно проводить дифференциальный сиквенс (определение точечных мутаций, полиморфизма известных участков генома, изучение экспрессии гена и определение функции гена). Технология ДНК-чипов основана на гибридизации неизвестной нуклеотидной последовательности с расположенными в определенном порядке известными ДНК-последовательностями, иммобилизованными на поверхности стекла или кремния. Результат детектируется по флуоресценции зонда, предварительно меченного флуорофором и гибридного с одной из иммобилизованных проб [11].

С помощью биологических чипов можно определять:

- онкомаркеры;
- генетическую предрасположенность к различным заболеваниям, в частности наследственную форму рака молочной железы и рака яичников;
- индивидуальную чувствительность к лекарствам;
- наличие и тип мутаций.

Многолетнее наблюдение за десятками тысяч женщин, подвергавшихся ежегодной маммографии в США, Швеции, Голландии с 1963 по 1980 гг., подтвердило, во-первых, высокую эффективность и чувствительность этого метода, обеспечивающего выявление, в основном, ранних стадий рака молочной железы, и, во-вторых, практически, полную безопасность его за счет сверхнизких доз облучения при исследовании. И, очевидно, самое главное достижение такого обследования заключается в том, что в группе женщин, принимавших участие в маммографическом скрининге (ежегодно или один раз в два года), смертность от рака молочной железы оказалась на 30-50% ниже, чем среди женщин, не подвергавшихся такому регулярному обследованию [14].

Поэтому в странах, где скрининг испытан всесторонне, оценена его стоимость и эффективность, уже сейчас рекомендуется ежегодная маммография женщинам 50 лет и старше, а также женщинам 35-40 лет, если кто-то из их кровных родственников болел раком молочной железы или обнаружены атипические изменения в эпителии молочной железы при биопсии. Женщинам 40-49 лет рекомендуется маммография один раз в два года, женщинам от 35-40 лет - одна исходная маммография. Если, при этом, не выявлено рака молочной железы, следующую маммографию следует выполнять после 40 лет.

Несмотря на громадное значение маммографии для раннего выявления рака молочной железы, она не лишена существенных недостатков. Имеются специфические формы рака молочной железы, не улавливаемые маммографией при ежегодном ее выполнении. Более же частое регулярное использование этого метода может оказаться опасным и дорогим для женщин. Единственной практической альтернативой, восполняющей этот пробел, остается какое-то ежемесячное обследование, например, самообследование молочных желез.

Результаты подобных исследований, проведенных в Швеции и Англии, показали, что методика самообследования женщин требует определенной организации. Так, в Швеции в эту процедуру было вовлечено 56000 женщин с доброкачественными изменениями в молочной железе, особенно у женщин моложе 50 лет.

Всем им были вручены памятки, содержащие основные данные о раке молочной железы, описание приемов самообследования, признаки доброкачественных заболеваний и рака молочной железы, имя, телефон и адрес врача, к которому следует обратиться при подозрении на опухоль.

Дополнительная информация распространялась через радио, телевидение и прессу. Каждая женщина получила специальный календарь с инструкцией и вопросником. Наблюдение осуществлял 21 врач. Оказалось, что 75% указанных женщин регулярно проводили самообследование, по сравнению с 1-2% женщин, не вовлеченных в программу. В течение 3 лет выявлено ровно вдвое большее число заболеваний раком молочной железы, чем ожидалось, причем, число внутрипротоковых (наиболее благоприятных) форм было в 2,6 раза выше, чем обычно, и в более молодом (на 2,5 года ранее) возрасте.

Затраты на выявление рака молочной железы оказались в 20 раз меньше, чем при массовом профилактическом осмотре. Не было отмечено случаев канцерофобии, и больные с симптомами рака молочной железы так же охотно контактировали с врачом, как и остальные [14].

Регулярное самообследование особенно важно

женщинам из групп высокого риска, тем, чьи матери, бабушки или сестры болели раком молочной железы, женщинам, у которых первый менструальный цикл начался рано (до 12 лет), или тем, у которых поздно (после 50 лет) прекратилась менструальная функция, а также нерожавшим женщинам или впервые рожавшим после 30 лет, и женщинам, страдающим ожирением.

В связи с высокой заболеваемостью раком молочной железы, наличием определенного опыта в проведении программ ранней диагностики рака молочной железы, отсутствием широкого распространения среди населения метода самообследования исследование рекомендовано было провести Научно-исследовательскому институту онкологии им. профессора Н.Н.Петрова (Санкт-Петербург) и Всесоюзному онкологическому научному центру (Москва). Оно начато в 1983 г. и завершено в 2005 г.

В течение ряда лет в исследование в Москве и Санкт-Петербурге включены около 230 тыс. женщин в возрасте 40-64 лет. Обучение технике самообследования, разъяснение необходимости его выполнения и целесообразности ранней диагностики рака молочной железы проводится в группах до 20 человек с вручением памяток и календарей по самообследованию (последние в течение трех лет ежегодно обмениваются).

Таким образом, проведение данного исследования позволило получить научно обоснованную информацию об эффективности метода самообследования для ранней диагностики рака молочной железы. Последний анализ результатов выполнения программы (2005 г.) не подтвердил достоверного снижения смертности от рака молочной железы в группах обученных самообследованию (СМЖ), но наблюдалась тенденция к повышению показателей 15-летней выживаемости. Кроме того, лучшая осведомленность женщин в группе СМЖ о проблеме рака молочной железы служила важным мотивирующим фактором обращения их к онкологам и выполнения регулярной маммографии.

Комплексное ультразвуковое исследование молочной железы в современной онкологической практике относится к основным методам скрининговой диагностики. Этот метод, который включает традиционное исследование в В-режиме, а также цветное доплеровское картирование, разрешает не только оценить структуру новообразования, но и его отношение к окружающим анатомическим структурам, а также особенности внутриопухолевой васкуляризации. Информативность, безвредность, возможность многократового применения определяют лидерство данного метода в скрининговой диагностике. В маммологии метод является незаменимым для:

1. Исследования «рентгенологически плотных» молочных желез у молодых женщин;
2. Дифференциальной диагностики кистозных и солидных образований;
3. Изучения структуры и васкуляризации внутриполостных вегетаций;
4. Выявления степени распространения процесса на лимфатические узлы;
5. Исследования локализации опухолевого очага в недоступных для рентгеновской маммографии участках молочной железы.

Весьма перспективным и высокоинформативным методом диагностики является магнитно-резонансная томография (МРТ), однако, из-за дороговизны у нас в стране она не получила широкого применения при первичной диагностике, а, в основном, применяется для оценки степени распространенности заболевания, в целом.

Одно из важных мест занимает иммунорадиоферментная диагностика - выявление опухолевых маркеров. Изменение их концентрации зависит от возникновения и роста злокачественной опухоли. К ним

относятся белки группы СА (Carbohydrate Antigen) СА 15-3; РЕА (раково-эмбриональный антиген); МРА (муциноподобный раково-ассоциированный антиген) и др.

Завершающим этапом диагностики является цитологическое и морфологическое (гистологическое) исследование. Морфологическая верификация необходима при любом подозрении на злокачественный процесс в молочной железе. Сегодня наиболее информативным является выполнение трепан-биопсии опухолевого образования в молочной железе.

Биологические факторы также имеют существенное прогностическое значение и разрешают прогнозировать ответ на лечение. К биологическим факторам относятся возраст или состояние репродуктивной функции, количество пораженных региональных лимфоузлов, состояние рецепторов эстрогенов и прогестерона, количество пролиферирующих раковых клеток и экспрессия HER 2/neu. На стадиях I, II, IIIA биологические факторы дают иногда более точную прогностическую информацию, чем размеры опухоли. На современном этапе рядом с традиционным большое значение отводится иммуногистохимическому стадированию РМЖ.

В основе метода иммунодиагностики злокачественных опухолей молочной железы лежит специфика экспрессии ряда генов, которые присущи только эпителиальным клеткам [7].

Современным и важным методом является иммуногистохимическая диагностика. При РМЖ практическое значение имеет определение эстрогеновых рецепторов (ER), прогестероновых рецепторов (Pg), HER-2/neu (c-erb-2) (аналог рецепторов к факторам роста, продукт онкогена), мутации генов-супрессоров p53, BRCA-1, BRCA-2 (Breast Cancer genes). Метод разрешает прогнозировать течение заболевания и обосновать целесообразность применения гормонотерапии, химиотерапии и дополнительного противоопухолевого лечения.

Специализированная гамма визуализация для маммологии (BSGI) дает возможность увидеть изменение активности клеточного метаболизма, помогая дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования. Исследование на аппарате Dilon 6800 – дополнительная процедура, представляющая собой пост-маммографическое уточняющее исследование.

Использование технологии BSGI – это инновационный научный прорыв в области скрининговых исследований молочной железы, позволяющий эффективно справляться с подозрительными и трудными для интерпретации случаями. В случаях, где маммография малозэффективна в определении поражений, BSGI, наоборот, эффективна, особенно когда у пациента:

1. Плотная ткань молочной железы;
2. Множественные подозрительные поражения;
3. Пальпируемые (прощупываемые) поражения, неопределяемые при помощи маммографии или ультразвука;
4. Гормонотерапевтическая терапия;
5. Пост-хирургическая или пост-терапевтическая масса;
6. Имплантат.

Метод маммографического исследования имеет хорошую чувствительность, но недостаточную специфичность, что подтверждается большим количеством отрицательных биопсий. BSGI имеет сравнимые с рентгеновским излучением характеристики гораздо более высокой специфичности. Два этих метода исследования дают в руки врача уникальную возможность более точной и своевременной диагностики заболеваний молочной железы.

Метод термографии основан на выявлении с помощью инфракрасных лучей температуры разных участков молочной железы. Различие в температуре симметричных участков молочной железы на 2,50С свидетельствует о злокачественном процессе. С появлением в последнее время тепловизио-

ров, позволяющих регистрировать и количественные перепады температуры (реометрическое исследование), возможности метода термографии значительно расширились.

В последние годы в диагностике рака молочной железы и ДЗМЖ с успехом применяется метод радиотермометрии, основанный на исследовании излучения глубоко лежащих тканей тела в дециметровом диапазоне длин волн. Интенсивность этого излучения пропорциональна абсолютной температуре тканей. Поскольку изменение температуры тканей предшествует структурным изменениям, имеется принципиальная возможность обнаружения рака молочной железы и дисгормональных изменений на ранних стадиях. Во время этого исследования регистрируется ряд признаков: расположение, интенсивность, размеры, форма, структура участков, значение температурного градиента.

В последние годы для решения проблем, требующих построения математических моделей в задачах распознавания образов, часто используют метод нейросетевого моделирования, доказавший свою эффективность при решении задач диагностики, классификации и прогнозирования в медицине.

Нейросетевое моделирование позволило выявить 4 факторных признака, которые в наибольшей степени определяют риск развития РМЖ (признаки перечисляются в порядке убывания их влияния): возраст, болезненность молочных желез перед месячными, отсутствие или нерегулярная половая жизнь, наличие доброкачественных заболеваний молочных желез в сочетании с гипертонической болезнью. На выделенном наборе признаков построена математическая модель прогнозирования риска развития РМЖ (выражается формулой).

Чувствительность модели составляет 78,8%, специфичность – 79,0%.

Научно обоснованный подход к проведению скрининга был введен в клиническую практику еще в 1975 г. двумя врачами общей практики, P.S. Frame и S.J. Carlsen, которые предложили способы выявления некоторых заболеваний при плановом физикальном обследовании. Их предложения были переработаны, дополнены и узаконены Канадской комиссией по периодическим профилактическим обследованиям в ее первом докладе, опубликованном в 1979 г. С изменениями их одобрила и Американская комиссия по профилактическим мероприятиям. Эти публикации, а также распространение методов клинической эпидемиологии послужили толчком к дальнейшей разработке доказательного подхода к проведению скрининга, в которую включились многие исследовательские группы [12].

На сегодняшний день большинство рекомендаций по скрининговым исследованиям основывается на сравнении эффективности лечения после скрининга и в отсутствии скрининга. Степень обоснованности доказательств определяется методологическим уровнем опубликованных исследований. Эффективность раннего лечения оценивают, сравнивая смертность от исследуемой причины в группе скрининга и в контрольной группе.

Показателями точности теста обычно служат его чувствительность и специфичность. На практике основное внимание следует уделять количеству ложноотрицательных и ложноположительных результатов, полученных в разных популяциях (например, в разных возрастных, этнических группах или в группах риска). Практически, все рекомендации по проведению скрининга у взрослых подразумевают повторение теста, поэтому однократное получение ложноположительных или ложноотрицательных результатов несет мало информации о том, чего следует ожидать при повторном скрининге спустя большой промежуток времени. Следовательно, необходимо определять общее число ложноположительных результатов, полученных по крайней мере за 10 лет, но подобные наблюдения проводятся крайне редко. Нужно также учитывать негативные последствия

ложноположительных результатов, например, дополнительные исследования и другие медицинские процедуры (и их стоимость), неблагоприятное психологическое воздействие (и возможные скрытые затраты на медицинское обслуживание). В немногочисленных исследованиях оценивалась эмоциональная реакция больных на сообщение о том, что результаты скринингового теста оказались «не вполне удовлетворительными». Выводы этих исследований очень тревожны, особенно если их перенести на популяцию, в целом.

Другая важная задача — анализ экономической эффективности. Почти всегда группы экспертов-ученых вырабатывают в процессе обсуждения четкие рекомендации. Но должны ли ученые этим заниматься на самом деле? Возможно, пора предоставить право решать, проводить или не проводить скрининговый тест тем, кого в большей степени затрагивают последствия принятого решения, т.е. больным и страховым компаниям. Задача исследователей — определить научные принципы и методы, используемые для обоснования скрининга, и разъяснить его возможные последствия. На основании их отчетов должностные лица (государственные чиновники, работники здравоохранения) и больные смогут составить собственное мнение и решить, хотят ли они платить определенную сумму за определенный результат, с учетом побочных эффектов лечения и возможности ложноположительных результатов. Несмотря на одинаковые сведения, полученные от экспертов, окончательное решение, скорее всего, будет разным в разных группах населения в зависимости от социально-экономического положения.

Ключевая концепция скрининга — это обнаружение настолько раннего заболевания, что проводимое далее лечение изменяет его прогноз и дальнейшее «естественное» клиническое течение. Однако, РМЖ представляет собой гетерогенное многоликое заболевание, что может существенно повлиять на эффективность скрининга. Модели скрининга РМЖ обычно основаны на том, что большинство выявляемых опухолей представляют собой инвазивные раки в ранней стадии прогрессии.

Когда популяция женщин подвергается скринингу, далеко не все случаи РМЖ выявляются при первоначальном раунде скрининга, некоторые опухоли диагностируются уже в постскрининговом периоде с помощью клинического метода (пальпации). Это так называемые «интервальные» или межскрининговые РМЖ, обнаруженные у женщин с негативными результатами скрининга. Обычно пропорция интервальных РМЖ колеблется от 15% до 25%. Чем выше частота интервальных (пропущенных при скрининге) РМЖ, тем меньше оснований ожидать снижения смертности в данной популяции. Вероятность выявления рака при скрининге зависит от продолжительности «времени доклинического обнаружения» опухоли (length time detectable preclinically), то есть от «sojourn time». Чем дольше «sojourn time», тем больше шанс обнаружения опухоли. Таким образом, многие опухоли, обнаруженные при скрининге, характеризуются медленным ростом и хорошим прогнозом. Это «отклонение» скрининга получило название «length time bias».

А пока маммография остается основной составляющей скрининга. Рентгеномаммография как скрининговый тест была всесторонне изучена и оценена в рандомизированных испытаниях, в которых женщины с ранее диагностированным РМЖ были исключены из числа участников. Почти во всех испытаниях (в 7 из 8) было показано, что эффект раннего обнаружения инвазивного рака проявляется через 5–7 лет от начала скрининга. Иными словами, снижение смертности от РМЖ отсрочено даже при хорошо организованном и качественно проведенном скрининге. Позитивный эффект может проявиться и значительно позже, если женщины, участвующие в скрининге, моложе 50 лет (Tabar, 1997), как это наблюдалось в Шведском исследовании.

Эффективность использования маммографии в

качестве основного теста скрининга проверена в многочисленных рандомизированных испытаниях, проведенных в США (Shapiro, 1966), Шотландии (Alexander, 1999), Канаде (Miller, 1992), Швеции (Tabar, 1999; Andersson, 1997; Nystrom, 2002), Финляндии (Hakama, 1997). Наряду с несомненной пользой маммографии, заключающейся, в конечном итоге, в снижении смертности от РМЖ, имеются и некоторые проблемы. Среди них и упоминавшаяся выше «сверхдиагностика» (over diagnosis), т.е. обнаружение случаев РМЖ, которые никогда бы не были найдены без скрининга на протяжении всей жизни (до 80–90 лет) пациента. Сверхдиагностика увеличивает стоимость скрининга, усложняет оценку программ, но не приносит пользу пациенту, так как выявленное заболевание не угрожает его здоровью. От 5% до 25% выявленных при маммографии опухолей можно отнести к разряду «сверхдиагностики».

В связи с проблемой сверхдиагностики, прежде всего, рассматриваются неинвазивные РМЖ, в частности, протоковая карцинома in situ. Ретроспективные исследования показали, что клинически определяемая (пальпируемая) форма DCIS прогрессирует в инвазивный рак в 65% случаев (В.В. Семилгазов, 2001; 2003; Holland, 2004). Как часто переходят в инвазивный рак непальпируемые DCIS, выявляемые только с помощью маммографии, остается неясным. Результаты испытаний Канадского скрининга показали, что обнаружение и последующее лечение DCIS не привело к сокращению частоты возникновения инвазивного РМЖ на протяжении 11 лет наблюдения [12]. Современные работы свидетельствуют о том, что прогноз DCIS в значительной мере определяется степенью ее злокачественности. Поэтому скрининг может представлять большую пользу женщинам с определенными формами DCIS, например, с опухолями 2-3 степеней злокачественности. Для других форм DCIS остается открытым вопрос, перевешивает ли потенциальная польза их обнаружения при скрининге побочный эффект (тревога, ненужная операция, лучевая терапия).

Анализ типа «стоимость-эффективность» различных программ скрининга показал, что стоимость «спасенного года жизни» колеблется от 3 до 8 тыс. евро, если скрининг касается женщин 50-69 лет и повторяется каждые два года.

В странах с низкими ресурсами злокачественные новообразования обычно не считаются приоритетной проблемой здравоохранения, поскольку основную угрозу общественному здоровью в этих условиях представляют инфекционные болезни. Ресурсы здравоохранения все же тратятся на лечение злокачественных новообразований, когда больные обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания. Преграды на пути совершенствования онкологической помощи разнообразны. Среди них недостаточные знания и осведомленность населения, социальные и культурные барьеры, трудности организации здравоохранения и недостаток ресурсов.

В странах с высокими ресурсами сформулированы и распространены рекомендации, разработанные с соблюдением принципов доказательной медицины, очерчивающие основные подходы к раннему выявлению, диагностике и лечению рака молочной железы [2].

В странах с высокими ресурсами маммография — основной метод обследования при объемных образованиях молочных желез с любыми клиническими проявлениями. Маммография — метод выбора при обследовании женщин в возрасте 30 лет и старше с пальпируемыми объемными образованиями молочных желез. В странах с высокими ресурсами ультразвуковое исследование (УЗИ) применяется в дополнение к маммографии для прицельного изучения очаговых изменений, выявленных при маммографии или в клиническом исследовании молочных желез. Проведение УЗИ молочных желез в рамках скрининга (исследование обеих молочных в отсутствие клинических проявлений

их патологии) обычно не рекомендуется, поскольку данных для определения эффективности и рентабельности этого метода в рамках скрининга недостаточно.

С другой стороны, в странах с низкими ресурсами УЗИ молочных желез обычно становится доступно до того, как находит широкое применение маммография. Последняя является узкоспециализированным методом лучевой диагностики, который гораздо дороже УЗИ. Напротив, УЗИ обычно доступно в условиях любых ресурсов, поскольку оборудование может применяться для исследования разных органов и не требует пленки. Ультразвуковые аппараты могут использовать различные датчики, что делает их применимыми для разных исследований.

В странах с низкими ресурсами применение УЗИ молочных желез на первом этапе обследования может быть более целесообразным. Этот метод особенно полезен для визуализации объемных образований молочных желез, может применяться для дифференциальной диагностики солидных и содержащих жидкость кистозных образований, позволяет судить о форме и структуре солидных образований. Все это помогает выявлять больных с пальпируемыми образованиями молочных желез, которые с большей вероятностью имеют патологию, требующую биопсии.

Заключение

Если ресурсы адекватны, методом выбора для скрининга с целью раннего выявления рака молочной железы является маммография. Это единственный метод раннего выявления, эффективность которого подтверждена с соблюдением принципов доказательной медицины. Поскольку увеличение размеров опухоли ухудшает прогноз, лучше выявлять клинически проявляющуюся опухоль молочной железы меньших размеров. Однако, следует принять во внимание, что в некоторых регионах мира программы маммографического скрининга неосуществимы из-за отсутствия ресурсов. Кроме того, во многих из этих регионов у большинства больных диагностируют опухоли III-IV стадии, что предполагает наличие огромных возможностей для ранней диагностики без дорогостоящих методов визуализации. В этих обстоятельствах приоритетом является наличие на местах учреждений, обеспечивающих неотложную диагностику и хирургическое лечение. После появления этой возможности можно сосредоточить усилия на раннем выявлении. Следует иметь в виду, что в некоторых регионах с низкими ресурсами большинству больных недоступно никакое другое лечение, кроме хирургического. Следовательно, в этих обстоятельствах расширение возможностей для выявления заболевания на стадии, когда заболевание можно излечить хирургическим методом, становится еще более необходимым.

С точки зрения раннего выявления следует пропагандировать осведомленность о патологии молочной железы среди всех женщин. Оптимизация базовых ресурсов должна включать следующее: эффективное обучение соответствующего персонала лечебно-профилактических учреждений проведению клинического исследования молочных желез как у предъявляющих жалобы, так и у не предъявляющих жалобы женщин; несистематический скрининг с помощью клинического исследования молочных желез; демонстрационные проекты или исследования систематического скрининга с помощью клинического исследования молочных желез или самообследования молочных желез; наконец, исследования возможностей проведения маммографического скрининга. В идеале для полноты оценки результатов эти проекты требуют регистрации случаев смерти больных раком молочной железы и определения стадии выявленных опухолей.

Женщин из группы риска следует выявлять с помощью вопрросников или при несистематических опросах при обращении за медицинской помощью по другим поводам. Эта стратегия также требует тщательной оценки, поскольку на Западе программы, учитывающие риск и охватывающие женщин с известными факторами риска, не выявляют значительную часть не связанных с ними случаев рака молочной железы [2].

Основная цель диагностики рака молочной железы в странах с ограниченными ресурсами, как и в странах с достаточными ресурсами, — точно дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования молочной железы, а также неинфильтрирующий и инфильтрирующий рак, чтобы своевременно оказывать надлежащую помощь.

Перед глобальным медицинским сообществом стоит растущая проблема рака молочной железы. Все более единодушным становится мнение, что давно пора любыми возможными способами применять на практике уроки, полученные в течение нескольких последних десятилетий, чтобы снизить заболеваемость раком молочной железы поздних стадий во всем мире. Хотя дополнительные исследования необходимы, они должны быть недлительными и иметь потенциал быстрого внедрения оказавшихся эффективными стратегий. Кроме того, необходимо объединение усилий организаций здравоохранения из разных стран в рамках международного консорциума для осуществления долгосрочной целевой программы глобальной борьбы с раком молочной железы.

Литература

1. Алиев Д.А., Мамедов М.К., Марданлы Ф.А. Повышение заболеваемости злокачественными опухолями как издержки научно-технического и социально-экономического прогресса // *Азербайджанский журнал онкологии и гематологии*, 2009, №2, с.3-8.
2. Бенджамин О., Андерсон М.Д. Рак молочной железы в странах с ограниченными ресурсами / Обзор рекомендаций Глобальной инициативы «Здоровье молочной железы», 2005.
3. Мазо М.Л. Роль радиологических и молекулярно-генетических методов исследования в дифференциальной диагностике образований аксиллярной области / *Вестник РНЦРР МЗ РФ*, №8.
4. Семиглазов В.Ф., Нургазиев К.Ш., Арзуманов А.С. Опухоли молочной железы (профилактика и лечение). Алматы, 2001, 344 с.
5. Семиглазов В.Ф. Скрининг рака молочной железы / *Материалы VIII Российского Онкологического Конгресса*, М., 2004.
6. Семиглазов В.В. Рак *in situ*. Опухоли молочной железы (лечение и профилактика). Алматы, 2001, с.103-125.
7. Смопанка И.И., Скляр С.Ю. Современный взгляд на проблему диагностики и лечения рака молочной железы // *Жіночий лікар*, №5, 2008, с.8.
8. Шабалова И.П., Джангирова Т.В. Новые технологии для оптимизации цитологической диагностики // *Справочник заведующего клинко-диагностической лабораторией*, 2010, №5.
9. IARC handbooks of cancer prevention. WHO. Breast cancer screening. IARC Press, Lyon, 2002, 229 p.
10. Fletcher S.W. Evidence-based screening: What kind of evidence is needed? ACP J Club, 1998.
11. Hakama M. Implementation of screening as a public health policy // *J. Med. Screen*, 1999, vol. 6, p.209-216.
12. Miller A. The Canadian national breast cancer screening study // *J. Natl. Cancer Inst*, 2000, vol. 92, p.1490-1499.
13. Tabar L. The natural history of breast carcinoma – what have we learned from screening? // *Cancer*, 1999, vol. 86, p.449-462.
14. Tabar L. Update of the Swedish two county program of mammographic screening for breast cancer // *Radiol. Clin. N. Am.*, 1992, vol.30, p.187-210.

Возможности криотерапии при лечении базальноклеточного рака кожи

Тулеуова Д.А., Серикбаев Е.А., Савхатов Д.Х., Косаев А.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии,

Республика Казахстан, Алматы

Базальноклеточный рак кожи - местноинвазивная, медленно распространяющаяся опухоль, которая редко метастазирует, возникая в эпидермисе или волосяных фолликулах, и в которой в особенности периферические клетки обычно имитируют базальные клетки эпидермиса». Заболеваемость базалиомами кожи высока во всем мире, причем имеется отчетливая тенденция к росту числа больных, темп которой соответствует общему росту заболеваемости злокачественными опухолями. Первично-множественная базалиома встречается в 10% случаев. Пик частоты возникновения базалиомы приходится на возраст 50-70 лет. Частота возникновения этого новообразования у мужчин по сравнению с женщинами составляет в соотношении 1,1:1.

Цель исследования

использование криотерапии при лечении базальноклеточного рака кожи.

Материал и методы

В КазНИИОиР с 2008 года 250 больным в возрасте от 25 до 88 лет с базальноклеточным раком кожи I—III стадией заболевания проводилась криотерапия аппаратом «КАС-01». В зависимости от размера опухоли один курс лечения составлял от 1 до 6 сеансов.

Результаты лечения. После проведения криотерапии через 1-2 года в 6% случаев отмечался рецидив опухоли. Из них у 3% больных рецидив вылечен повторным курсом криотерапии, 3% больным проведено оперативное лечение.

Важными достоинствами криовоздействия является простота выполнения, возможность осуществлять лечение в амбулаторных условиях без анестезии, отсутствие серьезных осложнений и отрицательной реакции организма на локальное криовоздействие, пластичность заживления раны.

Таким образом, Преимущество криотерапии над оперативным и лучевым методами лечения особенно при первично-множественном поражении опухолью кожи имеет 100% излечение, а также безрубцовое заживление ран.

Клинико-цитологические особенности местнораспространенного рака шейки матки при применении неоадьювантной полихимиотерапии

Аликулова

Жамбылский ООД

Рак шейки матки (РШМ), являясь визуально доступной локализацией, продолжает входить в число наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований, занимая пятое место в структуре онкологической заболеваемости в мире. Несмотря на возможности ранней диагностики данного заболевания, остается высоким процент заболеваемости по РК 8,5%000, по Жамбылской области 7,1%000, а смертности по РК и Жамбылской области за 2009 г.-4,4%000, запущенных форм РШМ (III-IV), составляющих по Жамбылской области-9,6% за 2009 год. Поэтому лечение местнораспространенных форм РШМ остается актуальной проблемой онкогинекологии. В настоящее время при распространенных формах (T2b, T3, T4) применяется, по возможности, радикальное хирургическое лечение с предоперационной лучевой терапией или химиотерапией. Данные современной литературы свидетельствуют о несомненной целесообразности применения неоадьювантной химиотерапии с включением платиносодержащих препаратов при планировании тактики лечения больных местнораспространенными формами РШМ.

Цель исследования

изучение комплексных методов лечения больных с местнораспространенными формами раком шейки матки в Жам-

былском областном онкологическом диспансере.

Материалы исследования

В исследование включены больные с раком шейки матки, впервые выявленные за 2006-2009гг.

В нашем диспансере проводится три основных метода лечения: хирургический, комбинированный и сочетанная лучевая терапия.

Всего за исследуемые годы выявлены 135 больных. По стадиям больные распределены следующим образом: T_{in situ}-1-0,7%, I-стадия- 19-14,0%, II стадия-102(75,5%) больных, из них T_{2a}N₀M₀-47-(47,0%), T_{2b}N₁M₀-55(53,0%), III стадия - 11(8,1%) больных, IV стадия-3(2,2%) больных. Возраст больных варьировал от 30 до 82 лет. Удельный вес больных по возрастам: 30-39 лет-24(17,7%), 40-59 лет-77(57,0%), 60-69 лет-17(12,5%), и 70 и >-14(10,3%). У всех больных диагноз верифицирован гистологически: плоскоклеточный рак - 113(83,7%), аденокарцинома-6 (4,4%), железисто-плоскоклеточный рак-13 (9,6%), ca in situ-3 (2,2%).

Всем больным II стадией первым этапом комплексного лечения проведена неоадьювантная полихимиотерапия по схеме: цисплатин 80-100мг/м², адриабластин 60 мг/м², 5-фторурацил 1200 мг/м², в зависимости от степени распространенности процесса и чувствительности опухоли к химиотерапии от 1 до 4 курсов с трехнедельным перерывом.

Из 102 больных проведение неоадьювантной

полихимиотерапии, позволило перевести неоперабельные формы рака шейки матки в операбельные у 25 (24,5%). У 64 (62,7%) больных после неоадьювантной полихимиотерапии проведена сочетанная лучевая терапия из-за частичной регрессии параметриальных инфильтратов. СОД на г. А 72 Гр, на т. В 54 Гр. У 11 (10,7%) больных отмечалось прогрессирование заболевания на фоне лечения. Установлен цитологический патоморфоз у 3 больных с плоскоклеточного ороговевающего рака на *са in situ*.

Таким образом, клинически и цитологически показана эффективность неоадьювантной полихимиотерапии при местнораспространенных формах рака шейки матки. Применение неоадьювантной полихимиотерапии позволило перевести первично неоперабельные формы рака шейки матки в операбельные в 25(24,5%) случаях при II стадии и цитологический патоморфоз в 3 случаях

с плоскоклеточного ороговевающего рака на *са in situ*.

Выводы:

1. Усилить эффективности программы скрининга на раннее выявление предрака и рака шейки матки в 0-1 стадиях, и таким образом уменьшить количества неоперабельных больных.
2. Увеличить количество операбельных больных со 2-3 стадией после широкого применения неоадьювантной полихимиотерапии.

Список литературы:

1. Бохман Я. В. *Руководство по онкогинекологии*. - 2002г.
2. Козаченко В. П. *Рак шейки матки//Современная онкология*. - 2000г.
3. *Статистические материалы 2 отделения ЖООД*.

Результаты хирургического и комбинированного лечения опухолей плечевой кости

Серикбаев Г.А., Жумадуллаев Б.М., Тулеуова Д.А., Савхатов Д.Х., Косаев А.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии,

Республика Казахстан, Алматы

При лечении опухолей костей с вопросами абластичности и радикальности, решаются ортопедические проблемы. Основной проблемой при реконструктивно-пластических операциях, становится выбор пластического материала. При опухолевом поражении верхней трети плечевой кости из-за отсутствия плечевых эндопротезов ранее после резекции производилась пластика малоберцовой костью. Но в динамике во всех случаях отмечалось рассасывание трансплантата, что приводило к нарушению функций конечности.

Цель исследования - повышение эффективности хирургического лечения больных с опухолью плечевой кости.

Материал и методы лечения. Последние 4 года по поводу опухоли верхней трети плечевой кости в плане комбинированного и самостоятельного лечения проведено хирургическое лечение у 10 больных. Возраст больных колебался в различных пределах. 0-15 лет - 5 больных, свыше

15 лет - 5 больных. У 5 больных выявлена остеогенная саркома, у 2 - хондросаркома, у 3 - гигантоклеточная опухоль.

У 5 больным после трех курсов полихимиотерапии и 5 больным первым этапом произведена резекция верхней трети плечевой кости с пластикой дефекта костным цементом с элементами остеосинтеза. В динамике функциональные способности верхней конечности восстанавливались в течение 3-4х месяцев после оперативного лечения. Пациенты свободно пользовались верхней конечностью. Рецидива заболевания не наблюдалось в течение трех лет. У двух больных отмечено прогрессирование заболевания с метастазами в легкие.

Таким образом, при хирургическом лечении опухолей верхней трети плечевой кости пластика костным цементом с элементами металлоостеосинтеза является методом выбора.

Хирургическое лечение гигантоклеточных опухолей костей

Тулеуова Д.А., Серикбаев Г.А., Савхатов Д.Х., Косаев А.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, Республика Казахстан, Алматы

Гигантоклеточные опухоли (ГКО), развивающиеся из мезенхимальных зачатков соединительной ткани представляют собой новообразования с невыясненной до конца природой и непрогнозируемым клиническим течением. ГКО наблюдается достаточно часто от 12-25% всех опухолей скелета. В настоящее время также не рекомендуется называть злокачественной гигантоклеточной опухолью те варианты, при которых в опухоли наблюдаются резко выраженный («дистрофический») клеточный полиморфизм и атипия или имеются метастазы в легких. В связи с этим предложен термин «доброкачественная метастазирующая гигантоклеточная опухоль» и составляет по частоте 1—2 % от типичных злокачественных гигантоклеточных опухолей.

Цель исследования - повышение эффективности хирургического лечения больных гигантоклеточными опухолями костей.

Материал и методы лечения. В КазНИИ онкологии и радиологии с 2007года отделении опухолей костей и мягких тканей по поводу гигантоклеточных опухолей костей

прооперированы 63 больных. Из них 34 больным произведено экскохлеация опухоли с криообработкой костной полости, пластика костным цементом, 25 больным - экскохлеация опухоли с криообработкой костной полости, пластика кальцием гидроксилапатитом и 4 -резекция кости с пластикой костным цементом и спицами Киршнера.

Результаты лечения. У троих больных наблюдалась «доброкачественная метастазирующая гигантоклеточная опухоль», у которых через 2 года после оперативного лечения появились метастазы в легких, 2-м больным произведено оперативное лечение, 1 больному проведена полихимиотерапия в связи с множественными метастазами в легких. Частота локального рецидива гигантоклеточных опухолей составляет 50-60 %.

Несмотря на высокий процент рецидивирования опухоли, все же наиболее эффективным и адекватным методом лечения остается оперативный, направленный на сохранение конечности и ее функции.

Современные подходы к организации паллиативной помощи в Республике Казахстан

Кульжанов М.К., Егеубаева С.А., Нуркеримова А.К., Досмаилова А.М.

*Высшая школа общественного здравоохранения,
Городской центр паллиативной помощи, г. Алматы*

Актуальность проблемы.

Современная модель паллиативной помощи представляет собой систему организации медицинской помощи и общего ухода за умирающими больными, включающую поддержку физических, психологических, социальных и духовных потребностей пациентов, а также психологическую помощь их семьям в течение болезни и в период утраты. Такая модель предполагает оказание паллиативной помощи с момента постановки диагноза неизлечимого заболевания.

На сегодняшний день согласно Постановления Правительства Республики Казахстан (РК) от 26 ноября 2009г. №1938 «Об утверждении перечня категорий населения, подлежащих паллиативной помощи и сестринскому уходу» в паллиативной помощи нуждаются лица страдающие: злокачественными новообразованиями IV стадии; СПИДом в терминальной стадии; хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии (стадия декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности, тяжелые последствия нарушений мозгового кровообращения). А также лица неспособные к самообслуживанию вследствие перенесенной болезни и (или) инвалидности, продолжительность которых ограничена.

Важными аспектами изучения в паллиативной медицине на сегодняшний день являются качество жизни пациентов, эффективность оказываемых услуг, организационные модели в оказании паллиативной помощи, оценка потребности населения в подобных услугах и многие другие. Одной из попыток изучения проблем паллиативной помощи было социологическое исследование, проведенное при финансовой поддержке Фонда Сорос Казахстан.

Целью данного исследования явилось изучение системы предоставления паллиативной помощи в стране и разра-

ботка рекомендаций по ее совершенствованию и развитию.

Материалы и методы. Исследование проведено одномоментно в 10 городах (в различных регионах) РК. Для сравнения были выбраны города, с какими либо формами предоставления паллиативной помощи и без них. В исследовании участвовали 4 группы: население, медицинские работники, представители НПО и религиозных организаций. Общий объем выборки составил 800 человек. Для каждой целевой группы были разработаны вопросники структурированного интервью.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о существовании следующих проблем предоставления паллиативной помощи:

- отсутствие единых стандартов и протоколов диагностики и ухода за инкурабельными больными, что значительно усложняет механизм мониторинга и оценки эффективности деятельности данных организаций;
- нехватка квалифицированных кадров;
- недостаток самих учреждений паллиативной помощи, необходимость развития различных форм оказания паллиативной помощи в зависимости от оценки потребности населения в этих услугах;
- необходимость развития паллиативной медицины в стране как неотъемлемой части общей медицины, открытие учреждений паллиативной помощи;
- недостаток учебных программ подготовки и переподготовки кадров по паллиативной медицине.

В настоящее время сформирована Рабочая группа по разработке стандартов и нормативов деятельности служб по оказанию паллиативной помощи с участием международных и национальных экспертов.